

**SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS INDÍGENAS DE UN
RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, 2021.**



LUIS MIGUEL VERGARA ESQUIVEL

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN SALUD PÚBLICA

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
MONTERÍA, CÓRDOBA
2021**

**SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS INDÍGENAS DE UN
RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, 2021**

LUIS MIGUEL VERGARA ESQUIVEL

Tesis para optar el título de Magister en Salud Pública

Directora.

Magister. NYDIA NINA VALENCIA JIMENEZ

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
MONTERÍA, CÓRDOBA
2021**

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Montería, febrero de 2022.

DEDICATORIA

A mi madre **Omaira Del Carmen Esquivel**, por ser ese apoyo fundamental y por depositar siempre su confianza en mis capacidades.

A mis padres de crianza **Hernán Emiro Coronado y Everlides Morales** por ser un pilar esencial en mi proceso de formación académica.

A mis Hermanos **Naira Peñate, Jhon Jairo Peñate, María Camila Coronado y Hernán Andrés Coronado**, por ser un soporte indispensable en mi vida, por permanecer siempre en esos momentos de soledad, por escucharme, animarme y motivarme a salir adelante en todo lo que me proponga.

A mi Asesora de tesis **Nina Valencia Jiménez** por ser la persona que me motivó a no rendirme en la ejecución de esta tesis para obtener el título de Magister en Salud Pública.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por haberme concedido la sabiduría necesaria y haberme permitido esta oportunidad de avanzar en mi formación académica, por darme la fortaleza y la confianza necesaria para seguir adelante cuando no me creía capaz.

A mi madre, por apoyarme no solo en esta formación académica, sino también en todas mis decisiones, por creer en mí cuando muchos no lo hacían, por enseñarme a terminar todo lo que me propongo y alcanzar todas mis metas.

Al resto de mi familia, que siempre ha estado dispuesta a impulsarme a alcanzar los logros y metas, a mis hermanos por proporcionarme no solo apoyo moral y espiritual, sino que me estimularon cada día a realizar y alcanzar este logro que también se los atribuyo.

A las comunidades indígenas Zenú, a sus capitanes, mujeres y hombres, que participaron en este estudio y ayudaron así a construir juntos esta estrategia comunitaria, para poder brindarles un mejor estilo de vida a los suyos.

A todos los docentes por estar dispuestos a instruirme en cada paso, transmitirme sus conocimientos y estar dispuestos a animarnos para alcanzar este logro.

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	10
ABSTRACT	11
INTRODUCCIÓN	12
1.OBJETIVO	14
2.MARCO REFERENCIAL	15
2.1 MARCO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES POLÍTICOS	16
2.1.1 Origen de la palabra dengue y primeras epidemias	16
2.1.2 Políticas de prevención y control del dengue en América	18
2.2 MARCO TEÓRICO	22
2.2.1 Salud Intercultural	22
2.2.2 Generalidades del dengue	25
2.2.3 Estrategias comunitarias de prevención del dengue	29
2.2.4 Saberes, Actitudes y prácticas indígenas como fundamento del diálogo de saberes en la prevención del dengue	33
2.3 MARCO CONCEPTUAL	37
2.3.1 Dengue	37
2.3.2 Prevención y Control	38
2.3.3 Estrategia comunitaria	39
2.3.4 Conocimientos, Actitudes y Prácticas	40
2.3.5 Comunidad indígena	40
2.4 MARCO LEGAL	41
2.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS	44
3. METODOLOGIA	54
3 .1 TIPO DE ESTUDIO	54
3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS	54
3.3 SUJETOS DEL ESTUDIO	55
3.4 CONTEXTO INVESTIGATIVO	55
3.5 MUESTREO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES	55

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	57
3.7 CRITERIOS DE RIGOR METODOLÓGICO	58
3.8 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS	59
3.9 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES	60
3.10 PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESPONSABILIDAD	60
3.11 ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DEL HALLAZGO	60
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS	62
4.1 CONDICIONES INDIVIDUALES, FAMILIARES, COMUNITARIAS Y ESPACIALES DEL CONTEXTO DE ESTUDIO	62
4.2 SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS RELACIONADOS CON LA PREVALENCIA DEL DENGUE	68
4.3 ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL DENGUE	73
4.4 ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE: “HOJAS DE ALMENDRO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE”	78
5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	96
6. CONCLUSIONES	101
7. RECOMENDACIONES	103
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Características generales del dengue	26
Tabla 2. Evolución de la enfermedad	27
Tabla 3. Prácticas para prevenir el dengue	85
Tabla 4. Principales visiones o posturas frente a un caso de dengue	88
Tabla 5. Plantas medicinales para tratar los síntomas del dengue	90

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Línea de tiempo Políticas de prevención y control del dengue	21
Figura 2. Tendencias investigativas sobre estrategias comunitarias y saberes ancestrales para la prevención del dengue	53
Figura 3. Método del análisis de conversacional	59
Figura 4. Ubicación de casos reportados de dengue en el área urbana del municipio de San Andrés de Sotavento, durante el año 2020.	63
Figura 5. Condiciones de las viviendas	63
Figura 6. Condiciones individuales y familiares de los participantes	64
Figura 7. Condiciones sociales y culturales de los participantes	65
Figura 8. Narrativas sobre condiciones sociales y culturales de los participantes	66
Figura 9. Condiciones ambientales de la vivienda: acceso a servicios públicos	67
Figura 10. Definición y asociaciones relacionadas con el dengue	69
Figura 11. Conocimiento de mecanismos de transmisión asociados con el dengue	70
Figura 12. Síntomas que asocian los participantes con el Dengue	71
Figura 13. Reconocimiento de responsabilidades para la prevención y atención del dengue	72
Figura 14. Actitudes asumidas por los participantes frente al control del dengue	74
Figura 145. Prácticas individuales y familiares para prevenir el dengue	75
Figura 16. Prácticas comunitarias realizadas para prevenir la transmisión del dengue	76
Figura 17. Plantas y recursos tradicionales empleados para la prevención del dengue	77
Figura 18. Prácticas relacionadas con la manifestación de síntomas asociados con Dengue	78

RESUMEN

Introducción: El dengue es una de las enfermedades transmitidas por vectores de mayor propagación en el mundo. Sin embargo, las estrategias de prevención y control suelen estar centradas en métodos físicos, químicos o biológicos, que en ocasiones excluyen formas tradicionales con que las comunidades responden a esta problemática. **Objetivo:** Interpretar los saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del Departamento de Córdoba relacionados con la prevención y control del dengue con miras construir una estrategia comunitaria que contribuya con la reducción del evento en el territorio. **Metodología:** Se empleó el enfoque cualitativo bajo un diseño micro etnográfico con la participación de 23 miembros del Resguardo. Se emplearon la entrevista semiestructurada, grupos de discusión y la cartografía social. **Resultados:** Los participantes cuentan con un bajo nivel de formación académica, sus actividades laborales están relacionadas con el sector informal de la economía, en su mayoría no cuenta con acceso al servicio de agua potable. Asimismo, se evidencian conocimientos básicos sobre el mecanismo de transmisión del dengue, síntomas y el tipo de vector que lo trasmite. Persisten dudas e inconsistencias entre los saberes enunciados que requieren ser afianzados, así como también aquellos aspectos relacionados con la concepción y forma de transmisión de esta enfermedad. **Conclusión:** Se encontraron prácticas relacionadas a la prevención y control del dengue como los sahumeros de plantas autóctonas de la región y técnicas de fumigación con productos químicos, lo que evidencia la articulación entre lo moderno y lo tradicional que desde la perspectiva de la presente investigación resultan muy importantes para el diseño y planificación de una estrategia comunitaria.

Palabras clave: *Dengue, conocimientos actitudes y prácticas en salud, estrategia de prevención, salud pública.*

ABSTRACT

Introduction: Dengue is one of the most widespread vector-borne diseases in the world. However, the management that has been given to prevention and care strategies is centered on medical and chemical methods, ignoring the traditional knowledge and practices that the communities possess. **Objective:** To interpret the knowledge, attitudes and practices of the indigenous people of a reservation in the Department of Córdoba related to the prevention and control of dengue, to build a community strategy for the prevention of dengue. **Methodology:** The qualitative paradigm was used under a microethnographic design where participant observation, 1 focus group, 23 semi-structured interviews and social cartography were applied. **Results:** the participating population has a low level of academic training, their work activities are related to the informal sector of the economy, 21 of the participants do not have access to drinking water at home. On the other hand, basic knowledge about the transmission mechanism of dengue, symptoms and the type of vector that transmits it is evidenced. Doubts and inconsistencies persist in said knowledge that needs to be strengthened, such as those related to the conception and form of transmission of this disease. **Conclusion:** Practices related to the prevention and control of dengue were found, such as the incense of native plants of the region or fumigation techniques with chemical products, which shows the articulation between the modern and the traditional that from the perspective of the present investigation result very important for the design and planning of the strategy.

Keywords: *Dengue, knowledge, attitudes and practices in health, prevention strategy, public health.*

INTRODUCCIÓN

El dengue, de acuerdo al concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad viral transmitida por el vector *Aedes aegypti*, y tipificada como una de las más extendidas en gran parte del mundo, siendo además considerada endémica para la región de las Américas (1). Asimismo, es catalogada como una epidemia la cual se ha documentado ampliamente durante las últimas décadas y se tienen reportes históricos de los siglos XVII y XVIII de posibles casos de pacientes con sintomatologías asociadas con esta, por lo que se consideran como antecedentes etiológicos de la misma (2).

Durante los últimos 50 años, la incidencia mundial de casos de dengue ha ido en aumento de manera considerada en un grupo prominente de países. Actualmente cada año ocurren un estimado de 50 millones de infecciones por esta enfermedad y aproximadamente 2,5 mil millones de personas viven en países con dengue endémico considerándose un problema de salud pública (3-5).

Para el caso de Colombia, durante el año 2021 se reportaron 46.366 casos de dengue, de los cuales 49,9% estuvieron asociados con signos de alarma; además, según el Instituto Nacional de Salud (INS), 53,7% de los casos confirmados eran hombres y 0,9% manifestaron pertenecer a una etnia indígena (6) El Departamento de Córdoba no se encuentra exento del comportamiento epidemiológico del aumento del evento, puesto que para el periodo epidemiológico XII, es decir, a diciembre de 2021, se reportaron 2098 casos con una incidencia de 223.3 casos por cada 100000 habitantes, destacando el reporte la ocurrencia de cuatro casos confirmados de muerte por esta enfermedad(6).

Por su parte, el municipio de San Andrés de Sotavento ubicado en el norte del Departamento de Córdoba (que constituyó la unidad espacial de análisis fijada para el presente estudio), es un territorio cuya población mayoritariamente pertenece a la etnia Zenú. Asimismo, los índices de necesidades básicas insatisfechas, la pobreza, las falencias en el sistema educativo y las dificultades en el acceso a servicios domiciliarios como agua potable o recolección de basuras es notoria, las cuales se suman al desconocimiento que poseen las personas sobre las enfermedades transmitidas por vectores y crean las condiciones propicias para la proliferación del *Aedes aegypti* y la propagación del dengue (6, 7).

En respuesta a lo anterior, para el control del dengue al interior del Resguardo Indígena Zenú del municipio de San Andrés de Sotavento, se han empleado diversos saberes y prácticas heredadas tradicionalmente, y que según testimonios de los indígenas pertenecientes a esta comunidad resultan ser efectivas para el control del vector y la prevención del dengue. Estas oportunidades del territorio requieren ser documentadas para construir estrategias locales y contribuir con la formulación de programas contextualizados para una mayor efectividad en el control y atención oportuna de esta enfermedad (9).

En relación a lo expuesto, en Colombia se han creado y adaptado diversos protocolos y estrategias de salud para mitigar la proliferación del vector transmisor del dengue y sus efectos, sin embargo, aún persiste una alta incidencia de dicha enfermedad. Por lo anterior, se deduce que existe una desconexión entre las estrategias planificadas y los saberes y prácticas indígenas, situación que conlleva a la implementación de medidas descontextualizadas que desafortunadamente no surten los efectos esperados.

Lo anterior, se constituyó en uno de los puntos de partida de la presente investigación, puesto que se considera que las potencialidades y capacidades que albergan los actores comunitarios deben ser encaminadas y fortalecidas para lograr la formulación de acciones más eficientes y de gran impacto en relación con la prevención y atención oportuna del dengue, con el fin de reducir no solo la carga económica generada por esta enfermedad en los países endémicos, sino también mejorar la calidad de vida de los actores comunitarios.

En concordancia, es una necesidad actual diseñar y desarrollar nuevas estrategias que surjan de las formas naturales en la que los miembros de la comunidad indígena Zenú de San Andrés de Sotavento articulan los saberes tradicionales con el conocimiento de las ciencias de la salud para lograr una prevención efectiva del dengue. Por lo anterior, es necesario preguntarse: ¿De qué manera se puede construir una estrategia comunitaria que ayude a la prevención del dengue, a partir de los saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del Departamento de Córdoba?

En este sentido, los resultados derivados de este estudio contribuirán a la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba: La salud en el contexto social, en donde es necesario explorar diversas rutas para comprender el proceso complejo que implica la toma de decisiones que se producen en una comunidad para cambiar su perspectiva ante medidas pertinentes en procura de promover la participación comunitaria como estrategia efectiva en el control de las enfermedades transmitidas por vectores(10, 11).

1. OBJETIVO

Interpretar los saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del Departamento de Córdoba relacionados con la prevención y control del dengue con miras construir una estrategia comunitaria que contribuya con la reducción del evento en el territorio.

2. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial de este estudio inicia con un recorrido histórico sobre el origen de la palabra dengue, así como también, se describen las primeras epidemias y aquellas políticas desarrolladas e implementadas en América para el control y prevención de la enfermedad. Seguidamente, se definen conceptos como dengue, prevención y control, estrategias comunitarias, conocimientos, actitudes y prácticas y comunidad indígena.

Adicionalmente, este ítem comprende el enfoque de la salud intercultural en el marco de los conocimientos, actitudes y prácticas de las comunidades indígenas como mecanismos de prevención y control del dengue que orienta la fundamentación teórica. En esta dirección, se incluye la revisión normativa legal en el territorio colombiano, se señalan los aspectos más relevantes del contexto investigativo y se abordan los antecedentes investigativos que lo sustentan.

2.1 MARCO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES POLÍTICOS

2.1.1 Origen de la palabra dengue y primeras epidemias. El origen de la palabra dengue probablemente proviene de la lengua swahili del este de África y Zanzíbar, donde se encuentran registros de epidemias de una enfermedad llamada Ka-Dinga pepo, que describe síntomas como una convulsión repentina parecida a un calambre causada por un espíritu maligno o un fantasma, de donde se tomaron las palabras Dinga o Denga para referirse a la enfermedad (12). Se asume que la palabra Denga fue traída por los esclavos africanos a América durante la época de la conquista y luego se le conoció como Fiebre Dandy (13). Los síntomas del dengue se registraron por primera vez en una enciclopedia de enfermedades y remedios que fue publicada en China durante la dinastía Chin (265 a 420 DC) y editada en la dinastía Tang (610 DC) y en la dinastía Sung del Norte (992 DC). En esta publicación se menciona la relación que existe entre la enfermedad y los insectos voladores asociados con el agua, por lo que se le empezó a conocer como agua venenosa o intoxicación por agua (14).

Las primeras manifestaciones de dengue en América se reportaron en 1635 en las Antillas Francesas (Martinica y Guadalupe) y en 1699 en Panamá. Sin embargo, los primeros reportes clínicos encontrados en la literatura médica fueron los casos de “fiebre articular” de la isla de Java en 1779 y la epidemia de una “fiebre quebranta huesos” en Filadelfia durante 1780. A pesar que se desconoce la etiología del primer brote de dengue en América, la descripción realizada por Benjamín Rush sobre la epidemia en Filadelfia, muestra que se trata claramente del virus del dengue, el cual llegó al continente en barco gracias al comercio de azúcar, ron y la trata de esclavos (15).

La palabra dengue fue utilizada por primera vez para referirse a la enfermedad en 1828 durante una epidemia en Cuba (16), donde además se utilizó para referirse a un ritmo musical con raíces de la guaracha-son y elementos de la música del Congo y Angola, compuesto por el famoso músico cubano Dámaso Pérez Prado (18). También se utilizó en la santería para referirse a una bebida elaborada a base de maíz seco, azúcar y miel, ofrecida a los dioses antes de cada ritual (12).

Las primeras epidemias de dengue en América se presentaron en Perú en 1818 reportando aproximadamente 50.000 casos. El virus se extendió rápidamente por el Caribe entre 1827 y 1828, desde las Islas Vírgenes hacia Cuba, Jamaica, Venezuela, Colombia y algunas ciudades del sur de Estados Unidos. Posteriormente, entre 1879 y 1880, se reportaron casos esporádicos en ciudades portuarias del Atlántico, Estados Unidos y el Golfo de México (19). A principios del siglo XX, se reportó una pandemia en Florida, Texas, Panamá, Puerto Rico y países del sur como Chile, Argentina y Brasil, los brotes más frecuentes se presentaron en La Florida (1934) y Nueva Orleans (1945) (20).

Entre 1943 y 1944 se realizaron las primeras pruebas diagnósticas para confirmar la enfermedad y se aisló por primera vez el virus en un laboratorio, comprobándose la presencia del serotipo DEN-2 en la región (16). En los años 60 se reportó una gran epidemia producida por el serotipo DEN-3 y en 1977 se documentó por primera vez la propagación del DEN-1 en América. Finalmente, en 1981 se reportaron los primeros casos de DEN-4, encontrándose así los 4 serotipos de manera simultánea en varios países del continente (18).

En el Sudeste Asiático y las islas del Pacífico por su parte, el virus se propagó rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no se tiene mucha certeza sobre la distribución del dengue antes de esta guerra, se infiere que el incremento de las viviendas temporales para los refugiados, la destrucción de ciudades y suministros de agua, la migración del campo a los centros urbanos y el crecimiento acelerado de la población luego de la guerra, fueron factores que facilitaron la propagación del vector *Aedes Aegypti* (19).

Debido a la cantidad de muertes de soldados aliados y japoneses atribuidas a la fiebre de dengue durante la Segunda Guerra Mundial, tanto el ejército de los Estados Unidos como el de Japón decidieron estudiar la enfermedad (22) (23). En Japón, los científicos Hotta y Kimura lograron aislar el virus en 1943, sin embargo, su trabajo no se reconoció durante años. Por su parte, Sabin, un virólogo estadounidense, aisló el virus en 1944 en India, Nueva Guinea, y Hawái,

hallando el mismo serotipo DENV-1 en los tres lugares y además una cepa de DENV-2 en Nueva Guinea (24).

En los años siguientes, la enfermedad continuó expandiéndose por muchos países del mundo como China, India, Camboya, Singapur, Indonesia, Maldivas, Vietnam y en las Islas del Caribe, el Océano Índico y el Pacífico. A principios de la década de los 70, en Colombia se reportaron brotes de los serotipos 2 y 3, y se introdujo el serotipo 1, que después de propagarse por todas las islas del Caribe y varios países de Latinoamérica, se convirtió en el serotipo más común del continente (24).

La incidencia del dengue en el mundo ha aumentado considerablemente en las últimas décadas y aunque el número de casos reportados no se acerca al número de casos real, se estima que anualmente se producen 390 millones de infecciones por dengue, de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de dengue en las últimas dos décadas se ha multiplicado por 8, pasando de 505.430 casos en 2000 a más de 2,4 millones en 2010 y 4,2 millones en 2019 (25).

En 2010 se notificaron los primeros casos locales de dengue en Francia y Croacia y en 2012 en Portugal, alertando a toda Europa ante la posibilidad de enfrentar brotes epidémicos de carácter explosivo. En 2013, se notificó en Asia un aumento del número de casos después de muchos años, especialmente en Singapur y Laos. En 2014 por su parte, se reportaron incrementos en los casos de dengue en China, Malasia, Vanuatu y Fiji, y en Japón se diagnosticaron personas con dengue después de casi 70 años de erradicada la enfermedad. 2016 fue un año de grandes brotes en el mundo, especialmente en la Región de las Américas donde se reportaron más de 2.380.000 casos ese año, de los cuales 1.500.000 se presentaron en Brasil. A pesar que 2017 y 2018 fueron años en los que se redujo considerablemente el número de casos de dengue en el mundo, el 2019 registró cifras históricas, considerándose el año con más casos de dengue en las Américas superando los 3 millones (25).

2.1.2 Políticas de prevención y control del dengue en América. La primera estrategia para controlar el virus del dengue en América, fue propuesta en Cuba en 1901 por William Gorgas, quien siguiendo las teorías de Walter Reed y colaboradores (26) y Carlos Finlay (27) sobre la importancia del mosquito en la propagación de la fiebre amarilla, planteó la eliminación de recipientes y contenedores de agua y la fumigación como técnicas efectivas para el control del vector (21).

En la década de 1940, durante la Conferencia Sanitaria Panamericana que se realizó en Brasil, se mencionó por primera vez la prevención y control del *Aedes aegypti* en la Resolución CSP11.R11, abriendo el debate mundial sobre la necesidad de los mecanismos de control del dengue y su importancia para la salud pública en el continente (20). En 1947, la Organización Panamericana de la Salud, inició una campaña de erradicación del dengue en todos los países afectados, lo que permitió que, en 1962 18 países continentales y varias islas del Caribe lograran eliminar el vector, demostrando así la efectividad de la campaña (21).

No obstante, a pesar del compromiso y los esfuerzos de la OPS para continuar con el plan de erradicación, solo 3 nuevos países lograron erradicar el vector, debido a la ineficiencia de la estructura centralizada del programa que no pudo brindar una respuesta rápida a las reinfecciones y que no previó la resistencia desarrollada por los mosquitos al DDT utilizado en las fumigaciones, el alto costo de la estrategia, la falta de participación de las comunidades y la indiferencia de los gobiernos, promovió la proliferación del *Aedes aegypti* en países que habían logrado erradicarlo (21).

En 1978, se llevó a cabo en Kazajistán una Conferencia Internacional para proteger y promover el modelo de atención primaria de salud. De esta conferencia surgió la Declaración de Alma-Ata, la cual reitera la importancia de la salud como derecho humano fundamental y la obligación de los gobiernos de mantener la salud de sus pueblos, partiendo de la premisa que la atención primaria es la clave para alcanzar el desarrollo, puesto que permite a las personas llevar una vida social y económicamente productiva (28).

Siguiendo los lineamientos planteados en la Declaración de Alma-Ata y como respuesta a la creciente demanda de una nueva perspectiva de la salud pública en el mundo, se realizó la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en 1986. Durante esta conferencia se redactó la Carta de Ottawa, que entre otras cosas menciona que la participación activa en la promoción de la salud implica la elaboración de una política pública sana, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de las aptitudes personales y la reorientación de los servicios sanitario (29).

Una década después de la elaboración de la Carta de Ottawa, la OPS motiva a los Gobiernos a participar en la elaboración de una política de salud pública y ambiental para el control del *Aedes Aegypti*, basada en la participación de las comunidades y la comunicación masiva, identificando los recursos necesarios para el desarrollo de estrategias que permitieran la vigilancia y control del dengue

y otras enfermedades infecciosas (20). A partir de lo propuesto en la Resolución de 1996, la OPS desarrolla un Plan de acción para la próxima generación: prevención y control del dengue, para la promoción de actividades intersectoriales resaltando la importancia del trabajo mancomunado y la comunicación social en los programas de control (30).

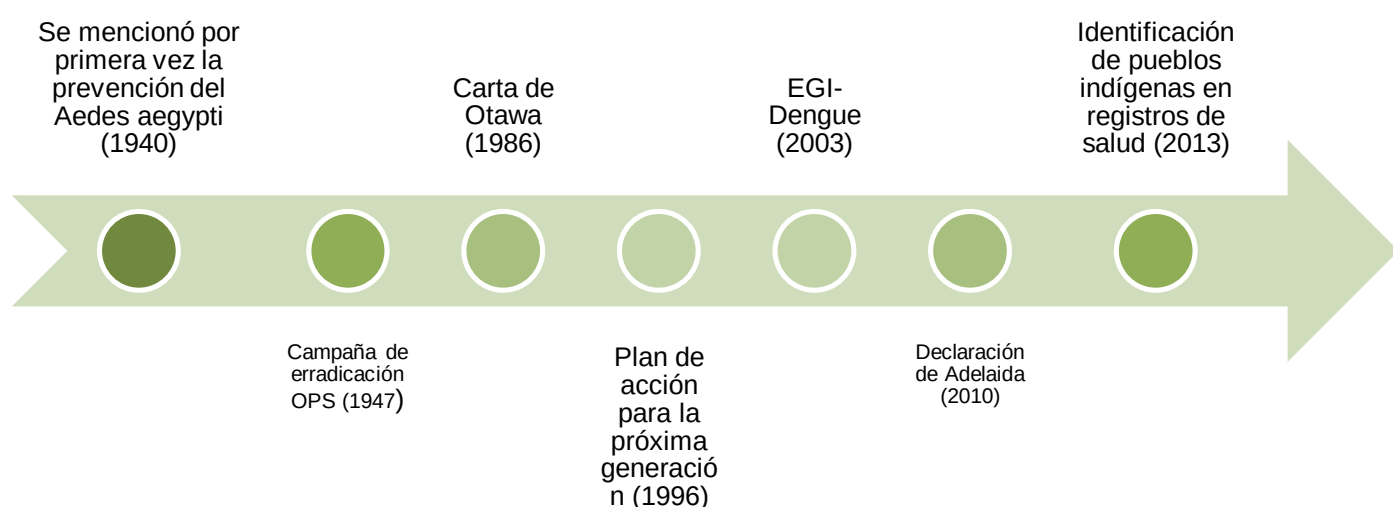
El Plan de acción para la próxima generación reitera la necesidad de abordar el dengue de una manera distinta y es por ello que en 2003 los Estados Miembros de la OPS y la OMS adoptaron la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue (EGI-dengue) (31), la cual se ha constituido en el referente conceptual y operativo para el control de la enfermedad durante la última década en América (20). Por otra parte, como un método de participación comunitaria, se desarrolló la estrategia Comunicación para el Impacto Conductual (COMBI) por sus siglas en inglés “Communication for Behavioral Impact” la cual se caracteriza por realizar actividades de comunicación y movilización social para modificar los comportamientos frente a la prevención y control del dengue (30).

Como parte también de los esfuerzos de la comunidad internacional por alcanzar los objetivos de incluir la salud y el bienestar en la formulación de políticas públicas, surge la Declaración de Adelaida en 2010, la cual se basa en la necesidad de desarrollar un “nuevo contrato social” multisectorial que permita lograr el desarrollo humano, la equidad, la sostenibilidad y el mejoramiento de los servicios sanitarios (32). Por su parte, para la promoción de la salud del siglo XXI, se propuso en la Declaración de Yakarta, promover la responsabilidad social, aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud, consolidar alianzas, ampliar las capacidades de las comunidades y empoderar al individuo, y consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud (33).

Para el caso específico de las comunidades indígenas, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, la Comisión Económica para América Latina y la Organización Panamericana de la Salud, plantean los lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes en los registros de salud, donde se busca incorporar preguntas para la visibilización de estos pueblos en las bases de datos (34). Por otro lado, La OPS propone la iniciativa de salud de los pueblos indígenas para el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas tradicionales, como estrategia intercultural y multidireccional basada en la identificación de mecanismos alternativos, que permita construir un sistema de salud eficiente, eficaz y accesible, determinando la vigencia de planes y políticas más realistas y viables (35).

En este orden de ideas, como parte de los lineamientos estratégicos para la Incorporación de las perspectivas, medicinas y terapias indígenas en la Atención Primaria de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, plantean una armonización de los sistemas de salud indígenas y el sistema de salud convencional en el continente americano, para lo cual proponen una armonización jurídica, conceptual y práctica, mediante el desarrollo de leyes y normativas que favorezcan el acceso de la población indígena a una atención de salud de calidad, el reconocimiento de los saberes y prácticas indígenas como sistemas de salud, y la implementación de modelos de atención que tengan en cuenta las características sociales y culturales de las personas (36).

Figura 1. Línea de tiempo Políticas de prevención y control del dengue



Fuente: Elaboración propia

2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Salud Intercultural. La presente investigación se guía por el enfoque de salud intercultural que comprende la interacción entre la medicina tradicional indígena y la medicina convencional, a partir del desarrollo de un modelo multicultural de salud y sociedad, que busca disminuir las barreras sociales y culturales entre los usuarios y los profesionales de la salud, así como mejorar los procesos de comunicación para lograr la validación cultural (37).

El concepto de interculturalidad hace referencia a la relación entre diferentes grupos humanos de una sociedad, que comparten espacios territoriales y que interactúan entre sí, sin que una cultura se imponga por encima de la otra (38). Se trata de un intercambio de cosmovisiones a veces antagónicas en términos étnicos, lingüísticos, denominación religiosa o nacionalidad. De acuerdo con lo anterior, “la interculturalidad puede entenderse como el intercambio respetuoso de conocimientos y tradiciones, la complementariedad, el diálogo, la comunicación, el aprendizaje constante, y la primacía del sujeto sobre las diferencias culturales y sociales” (39).

Es oportuno precisar que, existe una confusión conceptual entre interculturalidad y el concepto de multiculturalidad, que aunque tienen relación no hacen referencia a lo mismo, la multiculturalidad enfatiza en la composición de los grupos, mientras que el interculturalismo se centra en la naturaleza de las relaciones intergrupales para promover un diálogo entre sus miembros, fomentando el respeto y el reconocimiento de sus saberes y prácticas, construyendo así una visión diferencial que pueda aportar al bienestar de todos. En ese sentido, “la interculturalidad es un término que significa "entre culturas", que va más allá del hecho de convivir sin relación como en el caso de la pluriculturalidad o interactuar de forma hegemónica como ocurre en la multiculturalidad.

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha recurrido a diferentes métodos para combatir los males físicos y mentales que lo aquejan, de acuerdo al contexto sociocultural en el que se desarrolla y los recursos que tiene a su disposición. Ahora bien, la población indígena desde antes de la conquista “tenía su propia forma de concebir la salud y la enfermedad, a partir de la dimensión natural y espiritual, dado que “cada colectividad desarrolla a través de su cultura su propio estilo de cuidado, lo cual marca la diferencia entre un sistema y otro” (40). Con la llegada de los españoles a territorio americano, no solo llegaron nuevas enfermedades tan letales como la propia conquista, sino que se empezó a dejar de lado los saberes y prácticas ancestrales para el cuidado de la salud

de las comunidades indígenas, para imponer las concepciones de los conquistadores.

De esta manera, los pueblos indígenas han sido objeto de exclusión e imposición de ideas, cosmovisiones y prácticas, ampliando la brecha social que impide que estas poblaciones tengan las mismas oportunidades que el resto, evidenciándose en los bajos niveles de salud como consecuencia de la malnutrición, la pobreza, la precariedad de la infraestructura sanitaria y la descontextualización de las políticas públicas, que no toman en consideración los saberes propios de las comunidades indígenas para la promoción de la salud. Por tal motivo, La ONU sostiene que debido a las difíciles condiciones en las que viven los indígenas en todo el mundo, es preciso alentar a la comunidad internacional a plantearse el desarrollo desde la perspectiva del 'desarrollo acorde con la cultura y la identidad' (41).

El carácter social e histórico de la salud y la enfermedad pueden explicarse desde el contexto social donde tienen lugar y las circunstancias que han vivido los individuos de determinado grupo poblacional durante el transcurso de su existencia. En este sentido, la salud intercultural considera la atención de los pueblos indígenas a partir de la articulación entre los saberes científicos y los culturales, como una estrategia de salud integradora que haga posible la prevención y promoción de la salud en los diferentes grupos sociales de manera complementaria (42).

La interculturalidad apunta a abordar la salud desde una perspectiva más amplia, ofreciendo servicios coherentes y acorde a las realidades y necesidades de los diferentes grupos poblacionales. En este orden de ideas, el sistema Indígena de salud Propio Intercultural (SISPI) sostiene que la interculturalidad es “la comunicación y coordinación comprensiva entre los diferentes saberes y prácticas de los pueblos y las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que genera el reconocimiento, la valoración y el respeto a su particularidad, en el plano de la igualdad, armonía y equilibrio” (43).

El enfoque intercultural de salud, como concepto reciente que orienta las acciones para nuevos modelos de atención en salud, busca fortalecer la calidad de la atención médica dirigida especialmente a la población indígena. En este sentido, la OMS, en la nueva estrategia sobre medicina tradicional 2014 – 2023, establece recomendaciones para lograr la integración de las medicinas tradicionales al sistema de salud de los estados parte y sostiene que “muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de salud, que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y, muy especialmente, a los usuarios de los servicios de salud, el

acceso a la Medicina Tradicional y Complementaria (MTC) de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva” (44).

El Sistema Nacional de Salud, así como todo el andamiaje de la medicina occidental, es respetado por la cultura indígena, sin embargo, no reemplaza su concepto de salud y enfermedad, fundamentada en la relación entre cada individuo con el territorio. El SGSSS define las Medicinas y Terapias Alternativas y Complementarias, como las prácticas, técnicas, procedimientos, conocimientos o enfoques utilizados para la autorregulación del individuo a través de la estimulación del funcionamiento de las leyes naturales, con el fin de prevenir, promover, tratar y rehabilitar la salud de la población de manera integral” (45).

Bajo esta misma óptica, el sistema médico se concibe como todas aquellas prácticas, modelos y tecnologías formuladas para el servicio individual y colectivo de acuerdo al contexto sociocultural en el que se lleva a cabo. Es decir, una construcción cultural que responde a las necesidades de un grupo social en particular y su contexto socio histórico y cultural, que, desde la perspectiva antropológica, parte de la cultura de los pacientes y profesionales de la salud para conceptualizar modelos o técnicas terapéuticas relacionadas al proceso de salud enfermedad. No obstante, los diferentes sistemas médicos están sujetos a discordancias debido a la imposición de un modelo de salud sobre otro, por lo cual, se hace necesario el diálogo entre saberes para el desarrollo de políticas públicas que respalden en este sentido a las culturas indígenas (46).

En este sentido, la OPS, ha hecho énfasis en la necesidad de un compromiso político para avanzar en el acceso a la salud por parte de los diferentes grupos étnicos, para lo cual, aprobó la primera política sobre etnicidad y salud para las Américas en la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en septiembre de 2017, convirtiéndose en el principal referente a nivel mundial para atender a la población étnica desde la salud intercultural (47). De esta forma, la política sobre etnicidad y salud contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos, resaltando la necesidad de disponer de datos suficientes para asegurar la participación social de los distintos grupos en la construcción de las políticas de salud y su implementación, reduciendo finalmente las desigualdades en la cobertura universal de salud.

Colombia es un país con una gran diversidad cultural que promueve la transmisión de conocimientos ancestrales de generación en generación y el desarrollo de prácticas preventivas para evitar enfermedades frecuentes como las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). Es por ello que el contexto cultural influye en el autocuidado colectivo, fundamentado en las buenas

prácticas para proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente. Por esta razón, para lograr un sistema médico intercultural, se requiere que exista un consenso entre el estado y las comunidades indígenas, promoviendo así políticas más incluyentes y fortaleciendo la participación comunitaria (48).

En este sentido, existen prácticas de la medicina tradicional para la preparación de remedios a base de plantas que son capaces de tratar varias enfermedades, por lo que deben ser estudiadas y tomadas en cuenta para su uso en la medicina convencional mediante la medicina alternativa. Tal es el caso de la Uña de gato para tratar la gastritis, la diarrea y el paludismo, el Carambolo para las infecciones urinarias, el Yarumo para las afecciones pulmonares, picaduras de mosquitos y quemaduras (49), así como el limón criollo, el mango, el guineo, el llantén, el limoncillo y la menta para tratar picaduras de mosquitos y dolores ocasionados por el virus del dengue y Chikunguya (50).

Un sistema de salud intercultural en el país, requiere además de la capacitación del personal de salud y de la preparación de los nuevos egresados, incorporar las prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias de las comunidades indígenas sobre el uso de plantas, animales y/o minerales, así como de terapias espirituales y técnicas manuales para prevenir, diagnosticar y tratar diversas enfermedades, evitando de esta forma que se presenten dificultades para el acceso a la salud (45).

El camino de la salud intercultural en Colombia hará posible el acercamiento entre las dos medicinas, el reconocimiento de los saberes de cada una y sus tratamientos, así como la concertación de acciones de atención de calidad para toda la población sin discriminación cultural. Es importante que los profesionales de la salud entiendan la interculturalidad como un camino de diálogo constructivo entre el profesional y el paciente, que tome en cuenta las creencias y prácticas culturales de las comunidades, para comprender el proceso salud-enfermedad-atención en población indígena y lograr así prevenir las enfermedades y promover el bienestar de todas las personas.

2.2.2 Generalidades del dengue. El dengue es una enfermedad viral febril aguda que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados de las especies *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*. Presenta un espectro de manifestaciones que va desde casos asintomáticos hasta casos graves, estos últimos relacionados a otras complicaciones como encefalitis, hepatitis y miocarditis, que se asocian a la letalidad del dengue grave. De acuerdo a los síntomas que presenta, el dengue puede clasificarse según la OMS en dengue con o sin signos de alarma y dengue grave (51, 52).

A continuación, se menciona la sintomatología característica de cada caso:

- **Dengue:** Es una enfermedad incapacitante que puede presentarse con o sin signos de alarma. Cuando se manifiesta sin signos de alarma produce síntomas como fiebre alta, dolores musculares y articulares, cefalea, erupción cutánea, náuseas, vómito, dolor detrás de los globos oculares. Por otro lado, cuando se presenta con signos de alarma genera sangrado de mucosas, vómito persistente, dolor abdominal agudo, acumulación de líquidos y letargia.
- **Dengue grave:** La fase crítica inicia de 3 a 7 días después del inicio de la enfermedad, estos casos se caracterizan por el desarrollo de choques por dengue debido a la extravasación severa de plasma. En este tipo de dengue grave se manifiestan complicaciones hepáticas, neurológicas, cardíacas, renales, pulmonares, síndrome hemofagocítico y abdomen agudo. Los signos de alerta del dengue grave son dolor abdominal intenso, fatiga, presencia de sangre en el vómito, hemorragias en las encías, vómito persistente, respiración acelerada y agitación (1).

Tabla 1. Características generales del dengue

Aspecto	Descripción
Agente Etiológico	Virus del dengue de la familia Flaviviridae, género Flavivirus que pertenece a los arbovirus, es decir, virus que se transmiten por insectos. Tiene cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 Y DEN-4.
Vector	Mosquito hembra <i>Ae. aegypti</i> y <i>Ae. Albopictus</i> .
Reservorio	Humano
Transmisión	Se transmite por la picadura de la hembra del mosquito <i>Aedes aegypti</i> o <i>Aedes albopictus</i> infectada hacia un huésped susceptible.
Incubación	El periodo de incubación se presente de 3 a 14 días luego de la picadura del mosquito.
Transmisibilidad	El dengue se transmite si el mosquito pica a una persona infectada durante el periodo de viremia (después del periodo de incubación), y puede transmitirlo a otra persona después de un período de 7 a 14 días de incubación. Este mosquito puede seguir transmitiendo el virus el resto de su vida (aproximadamente 10 días).
Susceptibilidad	Cualquier persona que no haya padecido antes la enfermedad y viva en zonas endémicas.

Fuente: Protocolo de Vigilancia en Salud Pública (46).

En cuanto a la ecología del vector, el principal responsable de la transmisión del dengue es el mosquito *Aedes aegypti*, el cual se reproduce normalmente en recipientes artificiales de agua y habita en zonas urbanas. Las picaduras de estos mosquitos se intensifican iniciando la mañana y finalizando la tarde. Al reproducirse, sus huevos son viables durante varios meses y eclosionan al contacto con el agua. El *Aedes albopictus* por su parte, es el vector secundario del dengue, tiene gran capacidad a condiciones más frías, por lo que es el responsable de algunos brotes en Europa, Estados Unidos y Asia (1).

El curso de la enfermedad se presenta en tres etapas: etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. Durante la etapa febril, el paciente muestra síntomas como fiebre alta, enrojecimiento de la piel, dolor corporal, cefalea, mialgias, artralgias y dolor retroocular en un periodo de 2 a 4 días. En algunos casos se presenta hiperemia en faringe y conjuntivas, y odinofagia. Durante el examen físico se pueden observar equimosis y petequias en la piel, y por medio del examen de laboratorio se puede confirmar la presencia del virus en la sangre en esta etapa (53).

La etapa crítica de la enfermedad ocurre luego de superar la etapa febril que coincide con la extravasación de plasma, en un periodo de 24 a 48 horas. Durante esta etapa, el paciente manifiesta síntomas como dolor abdominal, vómitos persistentes y se debe prestar especial atención a las hemorragias de la mucosa nasal y las encías. Durante el examen de laboratorio, se observa aumento de hematocrito y disminución de plaquetas, además, leucopenia con neutropenia y linfocitosis con 15 a 20% de formas atípicas (53).

Luego de superar la etapa crítica el paciente pasa a una etapa de recuperación, donde se produce la reabsorción del líquido extravasado y se presenta una mejoría de los síntomas gastrointestinales y el estado general del cuerpo. En algunas ocasiones se puede presentar una erupción en la piel, y aparecer edema pulmonar o insuficiencia cardíaca. En el examen de laboratorio se observa la estabilización del hematocrito y un aumento paulatino de glóbulos blancos y plaquetas (53).

Tabla 2. Evolución de la enfermedad

Días de enfermedad	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Temperatura	Hasta 40°C			Disminución de la temperatura		Reabsorción de líquidos					
Eventos clínicos	Deshidratación			Shock Hemorragias Falla de órganos							
Laboratorio	Presencia del virus en la sangre			Disminución de plaquetas						Aumento de plaquetas	
				Aumento de Hematocrito						Disminución de Hematocrito	
Serología	Viremia					IgM/Igs					
	Fase febril			Fase crítica		Fase de recuperación					

Fuente: Diagnóstico y manejo clínico de casos de dengue (92).

Con relación a las definiciones operativas del dengue, la OMS los ha clasificado en caso probable, caso confirmado por laboratorio, caso confirmado por nexo epidemiológico y mortalidad por dengue (51). Las características de cada caso se especifican a continuación:

- **Caso probable:** entre las características de esta clasificación se encuentran pacientes procedentes de regiones endémicas, con enfermedad febril aguda, cefalea, erupción cutánea, leucopenia, dolor retroocular, mialgias y artralgias. En otros casos, aquellos que además de los síntomas anteriores presentan dolor abdominal intenso, sangrado en mucosas, vómitos, diarrea, acumulación de líquidos, caída abrupta de plaquetas, entre otros. En cuanto al caso probable de dengue grave, los pacientes presentan manifestaciones como extravasación severa de plasma, dificultad respiratoria, hemorragias Severas, daño grave de órganos.
- **Caso confirmado por laboratorio:** Se refiere a los casos probables de dengue, dengue grave, o mortalidad por dengue que son confirmados por PCR o aislamiento viral en pacientes con menos de 5 días desde el inicio de la fiebre o Prueba de IgM Dengue ELISA en pacientes con 5 o más días desde el inicio de la fiebre.

- **Caso confirmado por nexo epidemiológico:** Son aquellos casos que se confirman mediante los casos confirmados por laboratorio a partir de la relación de personas, tiempo y espacio, utilizado un área de 200 m. a la redonda del caso confirmado por laboratorio, desde 21 días antes, y 21 días después de dicha confirmación.
- **Mortalidad por Dengue:** Incluye los casos de personas que fallecen como caso probable de dengue grave con diagnóstico confirmado por laboratorio.

Adicionalmente, puede decirse que el dengue es un problema creciente para la salud pública en el mundo, debido a su gran impacto epidemiológico, económico y social; alrededor de 2.500 millones de personas están en riesgo de padecerla. Existen factores demográficos, sociales y medioambientales, como los aspectos culturales, las condiciones de las viviendas, la infraestructura sanitaria, la urbanización no planificada y las migraciones que ayudan a la reproducción del vector y la transmisión descontrolada del virus, generando un incremento en la incidencia del dengue en nuevos lugares del planeta (51).

Ante la exposición al riesgo por el incremento de la incidencia del dengue en muchas regiones del mundo, se hace necesario establecer estrategias de prevención y control que involucren la participación de las comunidades, así como procesos de comunicación, modificación conductual de los sujetos y la inclusión de los saberes ancestrales en el sistema de salud, con el propósito de fortalecer los planes y programas de salud pública que se aplican en la actualidad para el control de las enfermedades transmitidas por vectores.

2.2.3 Estrategias comunitarias de prevención del dengue. La prevención se define como el conjunto de acciones sociales, económicas, políticas y terapéuticas que buscan minimizar y eliminar el impacto de las enfermedades (51). Se clasifica teniendo en cuenta los niveles de desarrollo de la enfermedad, en cuatro categorías: prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria.

La prevención primordial, es un nivel reconocido recientemente que busca evitar ciertos patrones sociales, culturales y económicos que incrementan el riesgo de enfermar, como, por ejemplo, la medida propuesta a los gobiernos para el mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias como estrategia para evitar la reproducción del vector que transmite el virus del dengue. Por su parte, la prevención primaria limita la incidencia de las enfermedades gracias al control de factores de riesgo y causas, a través de medidas de protección de la salud aplicadas por las personas y comunidades, por ejemplo, el lavado correcto de

tanques, el uso de toldos, la eliminación de posibles contenedores de agua estancada, la modificación de comportamientos de riesgo, entre otros, para prevenir el dengue (55).

En este orden de ideas, la prevención secundaria busca curar a las personas enfermas y reducir las consecuencias graves de la enfermedad, a través de la detección y tratamiento temprano de los casos. Este nivel de prevención no pretende reducir la incidencia de la enfermedad sino la duración, complicaciones y letalidad de la misma. Finalmente, la prevención terciaria se centra en disminuir el avance y las complicaciones de una enfermedad establecida, aplicando medidas para minimizar las secuelas y el sufrimiento, y facilitar la adaptación de los pacientes a su nueva vida; es un aspecto importante en la rehabilitación y requiere de una buena atención médica (55).

Desde el punto de vista de la salud pública, el control consiste en realizar acciones que permitan restaurar la normalidad y reducir la incidencia de una enfermedad, dirigidas a disminuir su morbilidad y mortalidad. El nivel de control va a depender de los recursos con los que se cuenta, el tipo de enfermedad y las características propias de la población que la padece. En este sentido, la eliminación de la enfermedad consiste en evitar la presencia de casos, aunque persistan las causas que pueden producirla. Por ejemplo, en las regiones donde se reproduce el *Aedes aegypti* existe un riesgo potencial de presentar casos de dengue, aunque el virus no circule, porque la simple presencia del vector posibilita la eventual ocurrencia. La erradicación de la enfermedad es entonces cuando se logra eliminar tanto los casos como la causa y constituye un verdadero logro de los sistemas de salud cuando se consigue a escala mundial (52).

Para lograr que las medidas de prevención y control de las enfermedades sean efectivas, el desarrollo de las acciones de salud pública debe basarse en la puesta en marcha de programas o campañas dirigidas a la población en su totalidad, como por ejemplo el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, que establece los lineamientos técnicos y administrativos para ejecutar, monitorear y evaluar acciones de promoción, prevención y control de estas enfermedades en los distintos entes territoriales de Colombia (56). Para que dichas acciones sean calificadas como programas, deben resultar de una clara definición de los objetivos y metas enmarcadas en una política de salud.

Las campañas, por otro lado, surgen a raíz de situaciones de emergencia que requieren concentrar todos los recursos humanos y materiales, por un periodo de tiempo limitado y de forma intensa, en el control rápido del brote de una enfermedad. Tanto las campañas como los programas se han ejecutado aisladamente y de manera independiente, por lo que se busca la integración y

potencialización de los recursos disponibles, para que se facilite su uso en la prevención y control de enfermedades (52).

El dengue es una enfermedad que, a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos y organismos internacionales en materia de políticas públicas de salud, continúa siendo un problema recurrente que afecta principalmente a los países ubicados en las regiones tropicales y subtropicales del mundo como Colombia, que en 2020 ocupó el quinto lugar de los países con mayor número de casos reportados en América (14). Es por ello que, a lo largo de la historia de esta enfermedad, se han desarrollado e implementado una serie de estrategias y acciones en busca de su prevención y control, como el uso de insecticidas organoclorados y larvicidas organofosforados para la eliminación del vector. Sin embargo, este tipo de mecanismos químicos ha perdido efectividad debido a la resistencia desarrollada por los mosquitos a los componentes de los insecticidas comúnmente usados durante las campañas de fumigación (54, 56).

Debido a lo anterior, se han adelantado varias investigaciones en el campo de la química, la botánica, la biología y la genética, en busca de nuevas alternativas de prevención y control del dengue. Tal es el caso del estudio de la actividad larvicida e insecticida de extractos vegetales de la familia Asteraceae (57), aceites esenciales de albahaca (58), altamisa (59), Cúrcuma y limoncillo, así como extractos metanólicos de semillas de aguacate (60), entre otros, que han demostrado ser además de ecológicos, sostenibles y rentables, bastante efectivos para la inhibición de los ciclos de desarrollo de las larvas y el control de los vectores.

Ahora bien, como una forma de mejorar la efectividad de los mecanismos de control químicos, también se han evaluado las potencialidades de mecanismos biológicos como el uso de bacterias, peces y hongos para la erradicación del vector en su etapa larval, brindando la posibilidad de ofrecer alternativas de control integradas mediante el uso de cepas de hongos como el *G. Virens* (61) para mejorar los efectos de algunos larvicidas e insecticidas que han perdido efectividad debido a la resistencia de los mosquitos. Asimismo, se han realizado estudios sobre la posibilidad de introducir bacterias como la *Wolbachia* en poblaciones silvestres de mosquitos a través de microinyecciones en los embriones del *Aedes Aegypti* para protegerlos contra el virus del dengue, hasta que la bacteria se fije en las poblaciones naturales de mosquitos (62).

Otro mecanismo biológico de control del vector es el uso de peces en los contenedores de almacenamiento de agua; existen algunas especies como *Gambusia* y *Poesilia* (63) que se alimentan de las larvas de los mosquitos disminuyendo la reproducción de los mismos, constituyéndose como una

alternativa fácil y de bajo costo. No obstante, la introducción de peces no nativos ocasiona impactos ambientales y cambios en los ecosistemas que en la mayoría de los casos no se pueden controlar, además, existe resistencia por parte de las personas a la presencia de animales en el agua para el consumo (64, 57).

Es por ello que las estrategias de prevención y control que involucran la participación de las comunidades, como las campañas de lavado correcto de tanques y la eliminación de los posibles contenedores de agua estancada como neumáticos, baldes, botellas, etc., son hasta el momento las más efectivas contra el dengue. Sin embargo, estudios recientes demuestran que el conocimiento sobre estos mecanismos de prevención no se traduce necesariamente en buenas prácticas (65-67), debido a que muchas veces esta correlación se encuentra intrínsecamente ligada a factores sociodemográficos y económicos (65, 68, 69).

Además, puede decirse que el poco compromiso de las personas frente a la prevención del dengue, se debe no solo a la falta de información al respecto, sino a la idea errónea que el gobierno y las instituciones de salud son las únicas responsables del control del vector; sin embargo, a pesar que existe una comprensión razonable sobre la transmisión de la enfermedad, no se evidencia que las personas asuman su responsabilidad en el proceso (67, 70).

En virtud de lo anterior, las estrategias con miras hacia el empoderamiento comunitario se encuentran a la orden del día, por la necesidad de darle participación a las comunidades, como actores principales en la promoción y mantenimiento de la salud. La Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control del dengue en la región de las Américas (EGI-Dengue), es un instrumento metodológico que se desarrolla en el marco del Plan Estratégico de la OPS y busca reducir la carga económica y social generada por el dengue el continente americano (71).

El objetivo principal de esta metodología actualizada, es ajustar las estrategias y planes nacionales y subregionales, así como fortalecer de forma efectiva las acciones preventivas y de control del dengue, tomando como referencia determinantes ambientales y sociales tales como la infraestructura sanitaria, la pobreza, las migraciones, etc., que permiten la transmisión del dengue. La estrategia contempla los componentes de manejo integrado de vectores, laboratorio, epidemiología, comunicación social, atención a los pacientes, medio ambiente, vacunas y gestión, así como el eje transversal basado en la comunicación para el cambio conductual (71).

En Colombia se siguen fortaleciendo los seis componentes iniciales de la iniciativa EGI –Dengue desde 2006, y en la EGI-ETV 2012 – 2021 se mencionan las acciones efectivas para control de dengue, leishmaniasis, malaria, Chagas, entre otras. Además, se propone como componentes la gerencia del programa, inteligencia epidemiológica, gestión del conocimiento, promoción de la Salud, prevención primaria de la transmisión, atención integral de pacientes y gestión y atención de contingencias (51).

2.2.4 Saberes, Actitudes y prácticas indígenas como fundamento del diálogo de saberes en la prevención del dengue. El Ministerio de Salud y Protección Social promueve la recuperación de los saberes, actitudes y prácticas de los pueblos indígenas como bases para la atención integral en salud, a partir de la inclusión del enfoque diferencial. Dentro de sus orientaciones, recomienda que cada uno de los actores implicados en las acciones de prevención de las enfermedades se escuchen entre sí y analicen qué aspectos pueden tomarse en consideración de una o de la otra parte, o contemplar la posibilidad de aceptar, reconocer y entablar procesos de concertación de sus particularidades para lograr escenarios donde fluyan diálogos de saberes en sana convivencia (72).

En la ruta de construcción de los ambientes para el diálogo de saberes, está el ejercicio de concertar los mecanismos mediante los cuales se puedan identificar, para este estudio en particular, los elementos de la cosmovisión indígena que apoyen la prevención del dengue. Entre estos se destacan los encuentros o grupos temáticos que permitan develar el conjunto de saberes contruidos históricamente por las comunidades, que se encuentran cargados de significados acerca el cuidado de la salud y la atención integral de esta por parte del personal de salud, así como también, cuáles de estos saberes se llevan a la práctica y qué actitud tiene la familia de la enfermedad.

Durante estos encuentros de saberes, el Minsalud (72) recomienda instaurar grupos focales o círculos de la palabra para profundizar este tipo de temáticas, donde puedan participar madres, abuelos, agentes educativos e informantes claves de los grupos étnicos. Posteriormente, se ha de sistematizar y analizar la información recuperada para que sustente la elaboración de un documento con los aspectos clave discutidos, y finalmente, convocar las autoridades tradicionales y sabedores para validar los datos capturados e interpretados.

La importancia de recuperar los saberes, actitudes y prácticas de los pueblos indígenas, a partir de procesos participativos hacen parte de las recomendaciones internacionales y nacionales que fundamentan las políticas de salud pública, particularmente aquellos que sujetan la bandera de la promoción de la salud. La participación comunitaria es un eslabón fuerte entre las

disposiciones públicas y el sentir de las comunidades étnicas o de otro tipo de organizaciones sociales; en primer lugar, porque desde las actuaciones participativas de la comunidad se construyen y solidifican estrategias integrales con mejores resultados que aquellas que no cuentan con estas, por otro lado, porque la salud se promueve con mayor efectividad en los entornos naturales de las personas, más aún, si se incorporan sus modos y estilos de vida.

Por lo anterior, la participación comunitaria surge como una alternativa para la prevención del dengue, en función que esta se asume como el proceso mediante el cual las personas de forma individual o colectiva se hacen responsables de su vida en la identificación de necesidades de salud, y aportan desde sus saberes, prácticas y actitudes elementos para minimizar los efectos de la enfermedad y contribuir a la sostenibilidad de las estrategias que se logren construir.

Ante este interés mundial, los estudios que abordan los conocimientos, actitudes y prácticas se vienen empleando en diversos ámbitos de la salud, siendo las herramientas idóneas para establecer diagnósticos integrales que sirven de soporte a instituciones públicas y privadas responsables de diseñar, implementar y evaluar programas de promoción y mantenimiento de la salud. Desde otra perspectiva, los pueblos indígenas provocan investigaciones bajo el lente de estudios interculturales que privilegian aspectos culturales, saberes y prácticas ancestrales, y todo el manejo relacionado con la medicina tradicional, entre otros (73).

En una primera línea, el perfil de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP) se utiliza para conocer lo que las personas creen, piensan y cómo se comportan frente a una situación determinada. El primer dominio busca analizar el nivel de conocimiento de una persona, es decir, las representaciones mentales desarrolladas y arraigadas durante toda su vida. Por su parte, las actitudes son la unión de tres componentes; el cognitivo, el afectivo y el comportamental, que combinan experiencias, sentimientos y habilidades. Finalmente, las prácticas corresponden a la correlación entre el conocimiento y las actitudes, definiéndose como la habilidad que se obtiene luego de realizar continuamente una actividad (74).

Dentro de una perspectiva metodológica, la encuesta CAP es una herramienta que permite reunir información sobre lo que saben las personas, cómo se sienten y cómo actúan con relación a un tema específico, aportando información necesaria para el diseño de programas sociales y el análisis de su impacto. Los datos arrojados por este tipo de encuestas orientan las acciones de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y brindan un panorama completo para el desarrollo de políticas públicas que buscan mejorar las

condiciones de vida de las personas. Entre las ventajas de esta metodología se pueden mencionar su diseño sencillo, su fácil interpretación y la generalización de los resultados (75).

Este tipo de encuestas son ampliamente utilizadas para evaluar creencias y comportamientos relacionados con la salud y prácticas de prevención de enfermedades, las cuales proporcionan información valiosa para la planificación, la implementación y la asignación de recursos de programas de salud pública. Los estudios CAP son simples y directos, fáciles de diseñar, analizar e interpretar, dirigidos normalmente a una población de fácil acceso y no requieren de mucho presupuesto. Además, estos estudios buscan ser representativos y su objetivo es obtener lo que se sabe (conocimiento), lo que se cree (actitud) y lo que se hace (se practica) con respecto a un tema de interés. Dicha información se recolecta a través de cuestionarios semiestructurados o estructurados y se pueden obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos luego de su aplicación (76).

Una encuesta CAP se aplica para identificar brechas de conocimiento, creencias culturales y patrones de comportamiento que evidencien problemas y barreras, con el propósito de planificar e implementar programas de intervención acorde a las necesidades de la población sujeto de estudio. Además, permite generar una línea de base para medir los cambios que se obtienen luego de las intervenciones. Las CAP también ayudan a profundizar la comprensión de la información y los factores que influyen en el comportamiento, así como a evaluar los procesos de comunicación para la implementación efectiva del programa (76).

El momento ideal para realizar una encuesta CAP sería antes y después de llevar a cabo un programa de intervención en una comunidad. La encuesta previa proporcionará datos sobre conocimientos básicos, creencias, mitos, conceptos erróneos, actitudes, y comportamientos que adoptan las personas en relación a un tema específico relacionado con la salud, los cuales ayudarán a la planificación de programas y campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades y además servirán como referencia para medir el impacto de las actividades realizadas. La encuesta posterior permitirá evaluar la efectividad de dichos programas a partir de la medición de los cambios que se presentaron luego de la intervención (76).

La incidencia del dengue, como problema de salud pública, está relacionada a la conducta de las personas, por lo que se hace necesario conocer lo que saben, creen y cómo actúan frente a esta enfermedad, con el propósito de desarrollar estrategias acordes a sus necesidades particulares. En este orden de ideas, para

hacer frente a esta problemática, se ha planteado la importancia de la participación comunitaria a través de programas de educación en salud, vivienda saludable y ambiente sano, priorizando la concientización de la comunidad sobre la vigilancia de eventos prevenibles, como mecanismos para disminuir los casos de dengue (77).

En Colombia, la mayoría de los estudios realizados sobre CAP en relación al dengue en los últimos 10 años fueron de corte descriptivo transversal. Estas encuestas fueron aplicadas en zonas urbanas con una alta incidencia de casos de dengue, los participantes en su mayoría fueron mujeres con edades comprendidas entre 18 y 44 años (78-81, 67), quienes permanecen más tiempo en casa ocupándose de las labores del hogar y el cuidado de los hijos (77).

En cuanto al conocimiento sobre dengue, los resultados de estos estudios muestran que entre 70% y 90% de los participantes saben que es una enfermedad que la transmite un mosquito, más de la mitad no conoce el vector y la mayoría solo reconoce la fiebre como principal síntoma y los recipientes de agua limpia estancada como potenciales criaderos.

Dentro de las prácticas más utilizadas para prevenir el vector se encontraron la eliminación de criaderos y la fumigación (70), en su mayoría almacenan agua en sus viviendas (80) y menos de la mitad realizan el lavado de tanques periódicamente (79, 80). Adicionalmente, la gran mayoría indicó que buscan ayuda médica si presentan algún síntoma de dengue.

La actitud frente al control del dengue se encuentra dividida entre quienes creen que todos somos responsables del control (78), los que afirman que es responsabilidad de la comunidad (81) y quienes respondieron que es responsabilidad del gobierno (67). Por otro lado, se evidenció que existe poca participación comunitaria en las actividades de prevención porque no se convoca a la comunidad para hablar sobre la enfermedad (77), y no se realiza ninguna acción por parte de las familias para prevenirla (78).

Otra de las líneas de interés en este estudio, son aquellas aproximaciones teóricas y conceptuales que se han generado a partir de estudios con pueblos indígenas, donde el saber y la práctica son dispositivos culturales que hacen parte de un sistema educativo natural, propio y particular que caracteriza la cosmovisión de estas comunidades.

Dentro de estos estudios se encuentra el realizado con Los Chachis, un grupo étnico ubicado en la zona selvática del noreste de Esmeralda, Ecuador, quienes se caracterizan por asociar las enfermedades con el deterioro ambiental, la

contaminación de las aguas y los cambios en la alimentación. El objetivo de esta investigación determinar enfermedades comunes de la comunidad, así como la prevalencia de especies de plantas en los hogares y sus usos para el tratamiento de dichas enfermedades. Del estudio se obtuvo que entre las especies de plantas más utilizadas para aliviar los síntomas del dengue y el Chikunguya, así como evitar la picadura de los insectos, se encuentran el limoncillo, la menta y la chilangua. Los autores concluyeron que las culturas andinas poseen un gran conocimiento sobre las plantas y su uso en la medicina tradicional, que podría utilizarse para obtener productos que ayuden a repeler el mosquito transmisor del dengue (50).

Otro estudio importante fue el realizado en Perú en la región de Huancavelica para describir las prácticas culturales vinculadas al cuidado de la salud, donde se determinó que el uso de plantas medicinales es la práctica más usual, lo que puede ser explicado por la amplia disponibilidad de especies con propiedades curativas y una situación de rechazo o inconformidad a la medicación ofrecida por los establecimientos de salud pública (82).

2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 Dengue. Según la OMS (83), el dengue es una infección vírica febril aguda que se transmite por la picadura de mosquitos hembra infectados pertenecientes al género *Aedes*, produce síntomas similares a los de la gripe, afectando a lactantes, niños pequeños y adultos. Actualmente, existen cuatro serotipos (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4), que se presentan principalmente en zonas urbanas y semiurbanas con climas tropicales y subtropicales en todo el mundo, los cuales no desencadenan inmunidad cruzada, por lo que se considera una problemática en salud pública.

El cuadro sintomático del dengue se presenta de 3 a 14 días después de la picadura del mosquito infectado, con síntomas como fiebre alta, malestar general, cefalea, dolor retro ocular, dolores osteomioarticulares, mialgias, artralgias, leucopenia y en ocasiones algún tipo de sangrado (84). La sintomatología varía de acuerdo al paciente y esta puede confundirse con un cuadro viral, por lo que se hace necesario observar la evolución de los pacientes realizando un seguimiento estricto a través de pruebas serológicas que ayuden a confirmar la enfermedad (85).

A pesar que el dengue es una enfermedad viral que no distingue entre sexo, edad, raza o condiciones socioeconómicas, es preciso mencionar que, de acuerdo a algunos estudios, existen comunidades con características específicas como condiciones sanitarias precarias, bajo nivel educativo y

prácticas poco saludables que promueven la reproducción del vector (86) (65) (66) (87), que deben ser consideradas una prioridad para los programas y estrategias de prevención y control del dengue.

El mosquito que transmite el dengue se reproduce cerca de las viviendas en reservorios de agua estancada como floreros, botellas, baldes, neumáticos, entre otros, que intensifican el riesgo de padecer la enfermedad. Es por ello que, la OMS (1) afirma que la forma más efectiva de erradicar el vector es la prevención, especialmente a través de la eliminación de criaderos y el uso de elementos de protección como toldos, repelentes, camisas manga larga, pantalón largo, etc.

2.3.2 Prevención y Control. La prevención puede definirse como el conjunto de acciones sociales, económicas, políticas y terapéuticas encaminadas a eliminar, minimizar y erradicar el impacto de las enfermedades (88). Según el Módulo de Principios de Epidemiología para el control de enfermedades de la OPS (55), existen dos enfoques estratégicos para la prevención y el control de enfermedades: el enfoque de nivel individual y el de nivel poblacional. El enfoque individual se centra en la prevención y control de las causas de las enfermedades de las personas que son más propensas a enfermar, mientras el enfoque poblacional determina las causas de la enfermedad en la población, distinguiendo entre las causas de los casos y las causas de la incidencia.

Al realizar un contraste entre el enfoque individual y el enfoque poblacional, se puede comprender mejor los patrones de las enfermedades y las estrategias de prevención y control empleadas a lo largo de la historia, demostrando así, que el resultado de los cambios en la distribución de los factores de riesgo influye significativamente en la carga de la enfermedad de las poblaciones (96). Es por esta razón que, el conocimiento epidemiológico de las enfermedades ayuda a categorizarlas por grado de importancia y posibilidad de prevención, así como el conocimiento de la historia natural de dichas enfermedades posibilita la prevención e intervención efectiva, y finalmente, la organización y capacidad de respuesta de los sistemas de salud permite su control.

En este orden de ideas, el término control se refiere al conjunto de acciones, o programas que se desarrollan de manera continua con el fin de reducir la incidencia y prevalencia de un problema de salud pública, considerándose un acción correctora, restrictiva y restauradora de la normalidad. Se pueden distinguir dos dimensiones que delimitan su definición práctica; la dimensión circunstancial y la dimensión temporal, las cuales dependen del escenario donde se desarrolle el control. Por ejemplo, en un escenario epidémico, el control significa agotar rápidamente la epidemia hasta lograr una curva descendente a

corto plazo. En un escenario no-epidémico, el control depende de la dimensión temporal, es decir, a corto plazo, el control significa lograr que el número observado de caso sea igual al número esperado, mientras que, a largo plazo implica la reducción del riesgo de tal forma que no se convierta en un problema de salud pública (96).

En cuanto a las medidas de prevención y control del dengue se pueden mencionar el uso de insecticidas, toldos, lavado de tanques, eliminación de contenedores y recipientes como neumáticos, botellas vacías, ollas, etc., que puedan almacenar agua, así como el uso de repelentes para evitar las picaduras de los mosquitos. Además, las actividades de limpieza en las comunidades y las campañas educativas son otra forma de controlar el vector y prevenir la enfermedad, por lo que se hace necesaria la aplicación de un modelo ecosistémico transdisciplinario, que requiere como su nombre lo indica, de la participación de todas las disciplinas, incluidas las propias comunidades, para establecer estrategias más efectivas para la prevención y control del dengue (89).

2.3.3 Estrategia comunitaria. Las estrategias de salud abordan un rango amplio de patrones relacionados a los determinantes de la salud, las cuales están diseñadas para llegar a todas las personas. El enfoque de salud comunitaria presenta ventajas tales como la reducción de gastos en salud y un clima general de estabilidad económica, social y bienestar para toda la población, porque si las personas están sanas son más productivas, lo que incide directamente en el desarrollo de un país (90).

La participación comunitaria en estrategias de salud, ha tomado mucha fuerza desde la declaración de Alma-Ata en 1978, cuando se define por primera vez este concepto como "el proceso en virtud del cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad, y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y comunitario" (28), reconociendo así la importancia de la comunidad y su participación en el desarrollo de estrategias que permitan el acceso universal a los servicios.

Fortalecer la acción comunitaria a partir de su participación activa, permitirá tomar decisiones, planificar e implementar estrategias en pro de una mejor salud, para lo que se requiere que las comunidades obtengan el control de sus propias iniciativas y puedan organizar acciones en conjunto para hacer frente a un sistema que no satisface sus necesidades (91)

Las estrategias comunitarias desempeñan un papel clave en la renovación de los sistemas de salud y el acceso a la atención médica, mejorando así los indicadores del servicio de salud. A partir de un enfoque integrado de salud multidimensional y multisectorial, se garantiza un mejor acceso de la comunidad a la mayoría de los servicios de salud, gracias a la supervisión continua y la estrecha vinculación en de los niveles del sistema (92).

2.3.4 Conocimientos, Actitudes y Prácticas. El conocimiento se refiere al nivel de comprensión y conciencia que tienen los niños, jóvenes y adultos respecto a situaciones particulares, en cuanto a temas de salud, el conocimiento se refiere a qué tanto saben las personas sobre alguna enfermedad, sus principales síntomas, qué la causa y qué se puede hacer para prevenirla. Las actitudes son las percepciones, sentimientos y valoraciones que hacen las personas frente a situaciones de riesgo, es decir, cómo se comportan las personas ante una enfermedad. En esta categoría también se incluyen las creencias y las ideas previas que se tienen sobre algún tema en específico. Finalmente, las prácticas en el área de la salud, es la manera como las personas aplican sus conocimientos y actitudes para prevenir o tratar una enfermedad a través de sus acciones (93).

Una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un estudio que permite reunir información sobre lo que las personas saben o conocen, cómo se siente y cómo se comportan ante una situación en particular. Estas tres dimensiones son elementos complejos que no se evidencian en su totalidad en las encuestas, la cual no está diseñada para identificar relaciones de causa y efecto. Las encuestas CAP se utilizan permiten recoger datos importantes que pueden servir para fortalecer la planificación y el diseño de programas, como el de prevención y control del dengue (94).

2.3.5 Comunidad indígena. Los pueblos o comunidades indígenas se desarrollaron en sus territorios a través de una continuidad histórica previa a la invasión y colonización de sus tierras y tienen la determinación de conservar y transmitir a sus futuras generaciones su identidad étnica y territorios ancestrales, como parte de su existencia, teniendo en cuenta sus instituciones sociales, sistemas legales y patrones culturales (95).

Según la Organización de las Naciones Unidas [ONU] se estima que hay aproximadamente 370 millones de personas indígenas en el mundo, con diversidad de lenguas, culturas y tradiciones. En América Latina habitan alrededor de 400 grupos indígenas, conformados por aproximadamente 37 millones de personas. Los pueblos indígenas en esta región representan el 14% de las personas en situación de pobreza y 17% de pobreza extrema, y según

datos del Banco Mundial, la pobreza afecta a más del doble de los hogares indígenas en comparación a los hogares no indígenas (96)

En Colombia, los pueblos indígenas viven en instituciones legales y sociopolíticas de carácter especial llamados Resguardos, los cuales están conformados por una o más comunidades indígenas, que tienen un título de propiedad colectiva con las garantías de la propiedad privada, en la que pueden regirse por su propio sistema normativo a través de una organización autónoma respaldada por la jurisdicción indígena (97).

Los resguardos indígenas se organizan por medio de Cabildos, que son una entidad pública especial y una organización sociopolítica tradicional, cuyos integrantes son elegidos y reconocidos por una comunidad indígena, su función principal es la de representar legalmente a la comunidad, así como ejercer la autoridad y realizar las actividades atribuidas por el reglamento interno de cada resguardo (96).

Una comunidad indígena es un conjunto de familias, que comparten una identidad, costumbres, valores, forma de gobierno, gestión y sistemas normativos que la distinguen de otras comunidades. Por su parte, el seguimiento a los cambios en la situación de salud de esta población, se realiza a través de un Sala Situacional de La Oficina de Promoción Social, para conocer las tendencias de salud y la evaluación de los servicios en esta área (96).

2.4 MARCO LEGAL

En Colombia, el dengue es considerado un problema prioritario de salud pública, debido a su endemidad, distribución, potencial epidémico, circulación de los cuatro serotipos y su presencia en aproximadamente el 90% del territorio nacional, por lo que desde su reemergencia en la década de los setenta, el país ha seguido los lineamientos en materia de control y prevención del dengue propuestos por la OMS/OPS, a partir de la aprobación de resoluciones, normas y decretos que regulen la implementación de programas y estrategias encaminadas hacia la erradicación del vector (48)

En primera instancia, es preciso mencionar el Plan de Atención Básica (PAB) del Sistema General de Seguridad Social para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo, el cual fue definido y caracterizado en la Resolución 4288 de 1996, donde además se fijaron los componentes y competencias territoriales para su aplicación, destacando la gratuidad, la obligatoriedad, lo estatal, la territorialidad y la complementariedad entre sus principales características (98).

Durante el mismo año, se reglamentó el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante el Decreto 1283 de 1996, destinando un recurso económico para la vigencia del año 2000 con el fin de apoyar a los entes territoriales al desarrollo del Proyecto de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, además de financiar las actividades de educación, promoción y prevención a partir del control de insectos vectores y la ejecución de proyectos encaminados a reorientar las acciones de vigilancia en el país (99).

Por su parte, frente a la necesidad de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de los colombianos, el Ministerio de Salud formuló El Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, atendiendo las diferencias regionales, étnicas y culturales, el cual fue aprobado según Decreto número 3039 de 2007, con el fin de incluir las prioridades, estrategias y metas en salud que se articulen con los indicadores y convenios internacionales, así como definir las responsabilidades del Estado, los entes territoriales y los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para proveer de forma integral las acciones de salud individuales y colectivas (100).

Bajo esta directriz y continuando con la premisa que la salud pública es un compromiso de la sociedad, surge el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021, que define la actuación articulada entre las personas y los sectores públicos, privados y comunitarios, para incluir la salud en todas las políticas del desarrollo humano, social, económico y ambiental. Este documento muestra la ruta de trabajo para consolidar las capacidades técnicas en el ámbito de la protección social, la planeación y el seguimiento de las intervenciones basadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (101).

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 busca orientar las políticas de salud pública del país a partir de dimensiones como la salud ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud en el ámbito laboral y salud pública en emergencias y desastres, además, define dos dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud (101).

La dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles específicamente, busca garantizar el derecho de los colombianos a vivir sin enfermedades transmisibles en todas las etapas de la vida sin distinción alguna, a partir de la transformación de situaciones epidémicas, endémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas. Además, pretende reducir la exposición a

condiciones de riesgos sanitarios y biológicos, y crear capacidades en las personas para gestionar planes y programas que reduzcan el riesgo a las exposiciones (101).

En cuanto a la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, el enfoque étnico del PDSP promueve la protección de los derechos colectivos de las etnias, sus prácticas tradicionales en salud y su cosmovisión, mediante la planeación en salud etnocultural y el desarrollo de rutas de atención que preserven las raíces culturales de la medicina tradicional (101).

En Colombia además existen una serie de orientaciones legales que garantizan los derechos de los indígenas, como el Decreto 1811 de 1990 “que reglamenta parcialmente la Ley 10 de 1990, en lo referente a la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas”. Asimismo, la Corte Constitucional aprobó una protección especial a la comunidad indígena, para proteger la diversidad cultural y concederlos los mismos derechos que a los demás ciudadanos, prohibiendo cualquier forma de discriminación, de acuerdo a lo estipulado en la Sentencia T-1340 de 2001 de la Constitución de 1991.

Por su parte, la Ley 691 de 2001 reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, para velar por los derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, garantizando su permanencia social y cultural, y de esta manera proteger su integridad cultural. En este orden de ideas, en el artículo 20 de la Ley 1164 de 2007 se dictan las disposiciones del Talento Humano en Salud que puede ejercer la medicina tradicional, garantizando el respeto a las culturas médicas de los diversos grupos étnicos, que solo podrán ser practicadas por quienes se certifiquen a través de la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, a su vez, el Estado vigilará y controlará mecanismos el ejercicio de prácticas basadas en las culturas médicas tradicionales.

Siguiendo con la revisión de la normativa que regula y protege los derechos de las comunidades indígenas, se encuentra el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la “Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04” (102), donde se ordena implementar planes para proteger los grupos étnicos del desplazamiento forzado por el conflicto armado, quienes durante años han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Así bien, La Ley 1438 de 2011 reforma el sistema general de seguridad social

en salud e incluye otros elementos de prácticas tradicionales para la atención en salud en la implementación de la APS (103).

Por otro lado, el trabajo técnico y consultivo que permite la creación de políticas en salud para las comunidades indígenas, se lleva a cabo en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas, creada gracias al Decreto 1973 de 2013, donde participan personas delegadas de las instituciones y de las organizaciones indígenas (104).

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se propuso “reducir las brechas territoriales y poblacionales existentes, para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a servicios fundamentales como la salud, la educación y la vivienda para toda la población.” Para lo cual buscó privilegiar estrategias, con enfoque intercultural, de medicina familiar y comunitaria, mediante la capacitación del talento humano del área de la salud (105).

En 2014 además surge el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural-SISPI, según Decreto 1953, con el que se estableció un régimen especial para los territorios indígenas, garantizando que hasta que se lleve a cabo, el cuidado de salud de los pueblos indígenas está a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de las instituciones de salud indígenas y no indígenas (106). Más tarde en 2018, de acuerdo a los numerales 2.1 y 2.2. de la Circular 011 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, establece algunas instrucciones para los departamentos, distritos y municipios donde habitan las comunidades indígenas relacionadas a los componentes del SISPI (107).

Finalmente, el PDSP 2012-2021 fue modificado en la Resolución 00000050 de 2021 para “adoptar el capítulo indígena para los pueblos y comunidades indígenas de Colombia como parte integral del Plan Decenal de Salud Pública”. Los ajustes realizados en este capítulo se construyeron través de espacios de participación entre organizaciones como la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, y las comunidades indígenas, brindando acompañamiento y respetando su autonomía. El capítulo, además, define la participación de las comunidades indígenas en la incorporación de variables interculturales para el Análisis de la Situación de la Salud (ASIS), con el propósito de elaborar el componente estratégico y de inversión plurianual de los Planes Territoriales de Salud (108).

2.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Las investigaciones referenciadas en este punto, señalan las perspectivas analíticas del estudio del dengue y sus mecanismos de prevención y control,

desde una visión social que promueve la participación de familias, comunidades y Estado en la lucha conjunta contra el dengue, en el ámbito internacional, nacional y local.

A nivel internacional se encuentra el estudio de Jian-Wei, et al. (109), sobre las creencias, conocimientos y percepciones del dengue en la Región Especial IV de Shan Oriental, en Myanmar, para contribuir al diseño de estrategias locales para intervenciones eficaces contra esta enfermedad. Se emplearon técnicas mixtas de recolección de datos aplicando 18 entrevistas semiestructuradas en profundidad y 259 encuestas domiciliarias.

Dentro de los resultados se destaca la creencia que el entorno natural afecta la salud humana, distribuidos en opiniones sobre las implicaciones del clima y la presencia o no de árboles. Además, los autores establecieron relación vinculante entre los ingresos económicos y las enfermedades; otro grupo de informantes afirmó que la mala higiene y el agua sucia son causa de enfermedades y en lo que respecta a las prácticas preventivas se encontró que gran parte de los participantes sabía limpiar los criaderos, conocen sobre el uso de mosquiteros, insecticidas y protectores de ventanas y puertas.

Los autores identificaron mayores niveles de conocimientos sobre dengue en aquellos hogares donde hubo presencia de la enfermedad. Asimismo, la comunidad Shan posee como práctica regular la limpieza de sus casas y alrededores de la vivienda, sin embargo, poseer conocimientos sobre la enfermedad y cultivar prácticas de higiene no se constituyeron en bases para implementar estrategias eficaces de control del dengue, porque estas comunidades requieren de una estructura de salud pública fuerte, mayor apoyo internacional y aumentar la toma de conciencia sobre el dengue tendientes a lograr estrategias comunitarias con mayor movilización social y participación de las comunidades.

En esta línea, el estudio de Kumaran et al. (67), realizado en la provincia camboyana de Kampong Cham en 2018, se centró en investigar acerca de los niveles de conocimiento de los pobladores, sus prácticas de control autoinformadas y observadas contra los vectores tendientes al diseño de una estrategia con enfoque de gestión integrada adaptada al contexto local. Los autores destacan que en esta región mayoritariamente rural y los datos se desprendieron de un ensayo aleatorizado por conglomerados, en el cual se buscó evaluar el efecto de incluir peces guppy y reguladores de crecimiento de insectos aprobados por la OMS en depósitos de agua domésticos. Además, se administró en una fase previa una encuesta CAP y encuestas entomológicas.

Con respecto a los conocimientos y prácticas, los resultados muestran un nivel alto de los participantes en aspectos sobre la transmisión del dengue, métodos de prevención e identificación de síntomas. Los encuestados lograron identificar en su mayoría al mosquito como vector del dengue, mostraron por lo menos un lugar de reproducción del dengue como frascos, latas, cáscaras entre otros; asimismo, señalan como práctica cambiar el agua de los recipientes con frecuencia, uso de mosquiteros y usar ventiladores. Se logró establecer que el nivel de conocimiento disminuye ante la necesidad de distinguir el dengue de otras enfermedades febriles.

La condición femenina, los grados de formación y el nivel socioeconómico son predictores para la toma de conciencia de los síntomas del dengue; sin embargo, el conocimiento sobre los síntomas es menor con relación a otros aspectos de la enfermedad porque en su mayoría las personas identificaron la fiebre, pero disminuye la proporción cuando se trata de identificar al menos tres síntomas. Asimismo, no se estableció correlación entre los conocimientos y las prácticas preventivas, relacionado quizás con la percepción de la comunidad sobre la responsabilidad estatal de este tipo de problemáticas.

Los autores concluyeron que para formular estrategias o programas preventivos contra el dengue es necesario fortalecer la educación en salud, particularmente la identificación de síntomas, aunque se considera que la mera educación no causa impactos reales en las comunidades, en cambio la inclusión de enfoques de cambios de comportamiento como COMBI, podrían lograr mayores niveles de participación y apropiación de las temáticas.

Machado et al. (110), realizaron un estudio con comunidades indígenas en 2018 con el propósito de establecer los factores asociados de la seroprevalencia del dengue entre indígenas de la etnia Tremembé y los conocimientos que estos construyen en torno a la presencia del mosquito transmisor del dengue. La investigación contó con la participación de 290 indígenas y planteó dos momentos para la recolección de los datos, los cuales iniciaron con un estudio seroepidemiológico analítico transversal y posteriormente se realizó un estudio ambiental que involucró la supervisión mensual de las trampas de huevos.

La exploración de los conocimientos y estrategias de control que emplean los indígenas del Brasil, particularmente de la comunidad Tremembé, destacan como estrategias de interés las emisiones de programas de televisión, conferencias y visitas de trabajadores sanitarios indígenas; asimismo, los indígenas encuestados coincidieron en afirmar que eliminar aguas estancadas, rellenar con arena las macetas vegetales, eliminar residuos sólidos y la limpieza de los patios traseros son reconocidas como medidas de control más certeras.

Es notorio que, aunque los indígenas conocen aspectos esenciales sobre el dengue y estrategias de prevención suelen descuidar las prácticas, cuando persisten en almacenar agua en tanques a pesar de contar con suministro de agua garantizado a través de diversos medios.

El almacenamiento de agua en macetas, tanques y otros recipientes se muestra como un hábito cultural arraigado en esta comunidad, cuyas razones pueden ser el temor a la falta de agua y de aquellas estructuras requeridas para garantizar el suministro de agua. Las revisiones de estas creencias dan cuenta que la ligazón cultural es más poderosa que la realidad, porque según los registros la mayoría de las casas actualmente cuentan con el servicio de forma permanente. Esta práctica atenta contra la salud humana porque el mosquito *Aedes Aegypti* se reconoce por su comportamiento antropofílico y con autonomía media de vuelo, que en zonas rurales se ubica aproximadamente en 570 metros, por lo cual, en este tipo de comunidades indígenas podría considerarse infestación en toda la aldea

Por otra parte, los indígenas reconocieron dentro de las estrategias para prevenir el dengue, la información recibida por los profesionales de la salud, la cual consideran fiable, aunque gran parte de ellos reconocen la televisión como el principal medio informativo, muchos coincidieron en no prestar atención a los comerciales producidos por el gobierno. A partir de estas consideraciones, los autores concluyeron que los programas preventivos contra el dengue deben orientarse de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los indígenas, el mejoramiento en el diagnóstico diferencial y las intervenciones específicas acordes a la etnia y comunidad abordada.

El estudio, “Los chachis: cosmovisión ancestral con la evidencia científica en la prevención y control del dengue” (47), realizado en 2017, se orientó a la exploración de estrategias naturales para prevenir las enfermedades, particularmente el uso de plantas y productos naturales tendientes a mejorar la salud humana. Los investigadores Velásquez et al., plantearon un estudio descriptivo, documental y transversal en la comunidad indígena “chachi” ubicados en la reserva Mache-Chindul, Cantón Muisnes, Esmeraldas, mediante el cual emplearon un cuestionario de encuesta y realizaron un inventario de las plantas empleadas por los indígenas y las cotejaron con revisión bibliográfica para determinar sus propiedades repelentes.

Los autores afirman que esta comunidad suele tener preferencias por el uso de plantas como estrategias para prevenir las enfermedades y mantenerse saludables. Dentro de las afecciones tratadas se destacan chikungunya, dengue, malaria y leishmaniasis, para las cuales emplean mayoritariamente el

Cymbogogon citratus (limoncillo), *Mentha piperita* (menta) y *Eryngium foetidum* (chilangua), considerando la primera opción como la más efectiva en la lucha contra los mosquitos.

El análisis sobre las diferentes estrategias empleadas por comunidades indígenas para prevenir el dengue, muestran la necesidad que el equipo de salud tome en cuenta las especificidades de las personas y actuar como agentes mediadores entre el conocimiento ancestral y el especializado. Lo anterior, porque quedó en evidencia que estas comunidades emplean en primera instancia el uso de plantas medicinales para combatir el vector, razón por la cual no se pueden excluir estas prácticas del proceso de promoción y mantenimiento de la salud.

Desde la perspectiva de los enfoques comunitarios integrados para la prevención del dengue en comunidades no indígenas, en Machala (Ecuador), Mitchell-Foster, et al. (111), coordinó un proyecto con el propósito examinar la efectividad y viabilidad de ampliación del enfoque eco-bio-social tendientes a implementar acciones integradas con las comunidades para prevenir el dengue. En esta estrategia, los autores implementaron un programa de educación en la escuela primaria mediante un diseño de ensayo de grupo controlado aleatorio.

La estrategia se implementó de manera escalonada en escuelas y centro comunitarios donde se atienden niños entre 8 y 12 años, la cual comprendió cuatro sesiones educativas durante dos semanas con temas sobre síntomas del dengue, ciclo de transmisión, ciclo de vida del mosquito y observación de laboratorio en diversas etapas de la vida del vector. Esta fase sirvió de fundamento para la sesión práctica mediante la cual los niños aplicaron sus conocimientos supervisados por los educadores en salud, profesionales en salud pública y personal capacitado en el control de vectores. Este programa educativo se diseñó con elementos para el empoderamiento infantil, participación social y movilización de los niños como futuros líderes de sus comunidades.

Los autores concluyen que el éxito de estrategias locales depende de la integración de diversos enfoques de intervención, apoyo de las comunidades, fomento de la movilización social, participación, empoderamiento y ante todo la integración de esfuerzos intersectoriales como son comunidad, programas de control y los recursos de los gobiernos.

La participación comunitaria es una categoría ampliamente abordada por diferentes enfoques sociales para la prevención del dengue, su lugar es reconocido por Castillo, et al. (112), cuando expone que la identificación y priorización de los problemas de salud ha de considerarse como una actividad

colectiva porque implica el reconocimiento de la comunidad como actor central en el diseño, ejecución y evaluación de programas de salud. Asimismo, estos autores proponen el enfoque de Ecosalud para intervenir comunitariamente el problema del dengue porque desde sus postulados se estudia el vínculo entre el ecosistema natural y los sistemas humanos a partir de la visión sistémica, transdisciplinariedad, investigación-acción, participación social entre otros.

El estudio cuestionó el alcance del programa nacional de control de *Aedes Aegypti* implementado por el gobierno venezolano, al considerar que este enfatiza en desarrollar medidas tradicionales como el control químico de larvas y adultos, entre otros. Para lo cual, el estudio propuso la participación social de voceros, líderes y otros agentes comunitarios para fortalecer las capacidades preventivas, propiciar el intercambio de saberes, lograr acuerdos y fomentar acciones de conservación del medio ambiente. Una primera fase comprendió la sensibilización comunitaria, profesionales de la salud e instituciones del Estado, posteriormente se vincularon las escuelas con el propósito de organizar las brigadas infantiles y capacitarlos sobre la participación social y la eliminación de criaderos.

El estudio contó con mayorías femeninas quienes dinamizaron el proceso durante los 18 meses de trabajo comunitario. Se estableció que la participación social debe ser un proceso de toma de conciencia mediante talleres y diálogos para minimizar el arraigo de mala praxis de líderes o figuras política, porque los autores lograron concluir que cuando la vocería se asume sin tinte político muestra mejores beneficios. Por otra parte, los autores establecieron que la lucha contra el dengue no puede darse en solitario, por el contrario, combatir esta enfermedad amerita la integración de todos los actores sociales, esfuerzos gubernamentales, diversas estrategias y comprender que cada comunidad tiene sus particularidades y necesidades.

En el ámbito nacional, se encontraron estudios orientados a evaluar metodologías, identificar conocimientos, actitudes y prácticas, examinar la percepción del riesgo entre otros, que, aunque no son dirigidos a población indígena si aportan elementos para la identificación de estrategias de intervención comunitaria. El estudio de Ganem y Tuesca (113), comprende una de las investigaciones colombianas tendientes a evaluar la efectividad de la metodología COMBI, la cual observa y motiva cambios en conductas de las comunidades. Este fue desarrollado en Barranquilla (Colombia) con 150 viviendas seleccionadas de forma no probabilística por conveniencia a quienes se les aplicó una entrevista semi-estructurada sobre conocimientos, creencias y conductas.

Los resultados lograron establecer un fuerte vínculo entre las falencias en el conocimiento, percepción del riesgo y la baja sostenibilidad que presentan las personas frente al cambio conductual. Asimismo, la mayoría de los entrevistados no logran identificar al vector, pero comprenden que este se reproduce en agua limpia almacenada y que la forma de prevenir el mosquito es eliminar sus criaderos, saberes desconectados de sus prácticas reales porque mantienen depósitos de agua, tanques sin tapar y lavado poco frecuente.

Los autores reflexionaron finalmente sobre el éxito o fracaso de una intervención comunitaria, del cual aclaran que cumplir los objetivos y lograr cambios conductuales no depende solo de la disposición de la comunidad en general, sino que cada vivienda debe asumir su responsabilidad. Además, los funcionarios públicos, las instituciones y otros agentes comunitarios están llamados a apoyar las comunidades, capacitar mejor a los promotores de salud y programar acciones donde se propicie la participación comunitaria.

En este orden de ideas, también se encuentra la investigación de Benítez, Díaz y Martínez (114), que correspondió a un estudio analítico de corte transversal y muestreo probabilístico, donde participaron 206 familias del municipio de Riohacha. El objetivo principal era estimar la asociación entre la percepción del riesgo y la experiencia de dengue con los conocimientos, actitudes y prácticas de estas familias.

Entre los resultados más relevantes, los autores destacan que el 99% de los participantes considera que el dengue es una enfermedad seria, la mayoría lo define como una enfermedad y el principal síntoma que mencionaron fue la fiebre. Además, conocen que esta enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito que se reproduce en aguas limpias estancadas. Aproximadamente el 97% de los participantes afirmaron que asistían al médico si padecían algún síntoma relacionado con el dengue y que las prácticas más utilizadas para prevenirlo eran eliminar criaderos y fumigar. La mayoría de las familias respondieron que la falta de información limita la puesta en marcha de actividades preventivas y de control del dengue, y que es responsabilidad del gobierno municipal realizarlas.

Finalmente, el estudio no encontró ninguna relación entre la percepción del riesgo y las prácticas preventivas, aunque si se asoció a los conocimientos y la actitud de los participantes frente al dengue. Los autores concluyen que el desconocimiento de los casos de dengue en la comunidad sugiere que las familias participantes tienen poco interés en el control de la arbovirosis, resaltando la importancia de la comunicación para la prevención de un posible brote.

En el contexto local, se rastrearon diferentes estudios sobre dengue cuyo propósito se enmarca en otros ámbitos como son el comportamiento epidemiológico del dengue, los riesgos maternos, reproductivos y perinatales de las enfermedades tropicales, los facilitadores y barreras en la adopción de prácticas preventivas, prácticas de autocuidado de las familias frente al dengue y los conocimientos, actitudes y prácticas sobre manejo integrado de vectores en el departamento de Córdoba.

El estudio de prácticas de autocuidado de las familias frente al dengue y su relación con la implementación del protocolo fue desarrollado por Paternina durante 2019, con el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Se trató de un estudio descriptivo con enfoque mixto que involucró la participación de 298 familias distribuidas en los 33 barrios que conforman la pieza urbana de este municipio.

La autora encontró relevante que las familias ubicadas mayoritariamente en el estrato 1, presentan mayores riesgos de enfermar según lo expuesto por la OMS, que afirma que el 80% de la población mundial está en riesgo de contraer al menos una de estas enfermedades transmitidas por vectores, especialmente las familias de bajos recursos (115). Entre los resultados más relevantes se encontraron el poco uso del toldo como método de barrera, un incorrecto lavado de los tanques, y un alto porcentaje de viviendas con depósitos de agua permanente, lo que permitió afirmar que, pese a que la mayoría de las familias respondieron que tienen conocimientos sobre el dengue y cómo prevenirlo, se evidencian algunos vacíos que demuestran lo contrario.

Paternina concluye que el estrato socioeconómico de las familias se encuentra relacionado con el poco conocimiento sobre el correcto lavado de tanques, el dengue, los criaderos, los síntomas y la no fumigación. Además, a pesar que el nivel de conocimiento sobre el dengue es mayor que en el pasado, muchas familias no han identificado aún la magnitud del problema lo que se ve reflejado en sus malas prácticas y actitudes, por lo que hace necesario desarrollar políticas públicas que tengan en cuenta estos hallazgos y que contribuyan a combatir este tipo de enfermedades (116).

Por su parte, Tuirán (117) en su tesis de maestría titulada Facilitadores y barreras en la adopción de prácticas preventivas del dengue en habitantes de Montería, Córdoba, desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal con una muestra de 187 pacientes recuperados de dengue en la ciudad de Montería, utilizando los criterios de conveniencia, accesibilidad y disponibilidad.

Entre los resultados más importantes de esta investigación se destaca que la mayoría de los entrevistados son mujeres que pertenecen al estrato socioeconómico 1, lo que coincide con el hecho que las mujeres permanecen más tiempo en los hogares estando expuestas a la picadura del mosquito. Para el análisis de los facilitadores y barreras en la implementación de las estrategias de prevención y control del dengue, la autora identificó las condiciones de saneamiento básico, las prácticas preventivas, el conocimiento y control de la enfermedad, participación comunitaria, comunicación y gobernanza.

En cuanto al saneamiento básico, la autora encontró que la mayoría de los participantes cuenta con servicio de acueducto, alcantarilla y recolección de basuras, lo que funciona como un factor de protección al evitar prácticas como el almacenamiento de agua en las viviendas. Entre las prácticas preventivas, se encontró que un alto porcentaje de las personas entrevistadas no utilizan toldo, sin embargo, limpian frecuentemente los tanques y fumigan sus viviendas. Por su parte, más de la mitad de los encuestados no participa de ninguna actividad comunitaria y afirma que las instituciones educativas deben apoyar las actividades de prevención y control del dengue.

A partir de los resultados encontrados Tuirán concluyó que a pesar que los participantes tenían conocimientos adecuados sobre el dengue, lo que se constituye en un facilitador para el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, este conocimiento no se transforma en prácticas preventivas, por lo que persisten conductas de riesgo a pesar de conocer la enfermedad y cómo prevenirla. Por otro lado, la autora afirmó que existen más barreras que facilitadores, principalmente por la respuesta institucional deficiente y la poca responsabilidad por parte de las instituciones de salud, quienes solo se limitan a realizar actividades curativas dejando de lado los mecanismos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Finalmente, en el departamento de Córdoba Benítez y Romero (118) desarrollaron una investigación descriptiva, epidemiológica y transversal con el objetivo de identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias frente a las ETV, para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica e identificar las zonas de riesgo de transmisión de estas enfermedades en el departamento, identificando como factores de riesgo la irregularidad del servicio de acueducto, el hacinamiento en las viviendas, el desempleo, los bajos ingresos y el bajo nivel académico de los participantes.

Entre los resultados más significativos se encontró la persistencia de mitos sobre la transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores, como la creencia que el consumo de alimentos contaminados, el manejo de animales infectados

o la materia fecal del insecto, incluyen en la transmisión del virus, lo que les permitió a las autoras entrever el poco conocimiento que posee la población sobre la transmisión de este tipo de enfermedades.

En este orden de ideas, Benítez y Romero encontraron que, en cuanto a la actitud de los participantes, la mayoría está a favor de la intervención de profesionales de la salud para la realización de las campañas de limpieza de tanques y fumigación, mientras que en las prácticas preventivas se determinaron el uso de insecticidas y toldillos como las más frecuentes. No obstante, las autoras concluyen que existen fallas estructurales de los mecanismos de prevención y control de estas enfermedades, impidiendo la apropiación de los conocimientos y el empoderamiento de las comunidades.

Figura 2. Tendencias investigativas sobre estrategias comunitarias y saberes ancestrales para la prevención del dengue



Fuente: elaboración propia a partir de las tendencias investigativas encontradas.

El presente estudio se basará en la identificación de los conocimientos, actitudes y prácticas preventivas, construidas y aplicadas en torno a la presencia del dengue en diferentes comunidades alrededor del mundo, así como en la exploración de diferentes estrategias naturales utilizadas por pueblos indígenas para la prevención de las enfermedades, que permitirán realizar una

comparación con los resultados que se esperan obtener y sustentar el desarrollo de una estrategia integrada basada en la participación comunitaria para la prevención del dengue.

3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio adoptó el enfoque cualitativo tendiente a facilitar la exploración de los saberes, actitudes y prácticas familiares en miembros de un resguardo indígena en torno a la prevención y control del dengue. Se previó la realización de un análisis reflexivo de los significados subjetivos de sus realidades y la comprensión de las acciones personales y comunitarias que aporten herramientas para responder el interrogante: ¿De qué manera se puede construir una estrategia comunitaria que ayude a la prevención del dengue, a partir de los saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del Departamento de Córdoba?

Con respecto al tipo de estudio se asumió la micro etnografía, tras constituir una alternativa pertinente acorde a los propósitos definidos por el estudio. Esta es una subdivisión de la etnografía centrada en observar y describir características tales como costumbres, creencias y medios de vida de una comunidad o cultura en un tiempo no tan prolongado; así mismo, se basa en la concepción que asume las tradiciones, los valores y las normas como guías regulativas de las formas de vivir de las personas, familias y comunidades, al punto de generar dispositivos interpretativos del comportamiento de los grupos humanos (119).

La micro etnografía focaliza la investigación en una o más situaciones sociales mediante la observación e interpretación del fenómeno de estudio, permitiendo así que el trabajo requiera menos tiempo y lo pueda realizar un solo investigador. Así las cosas, el nivel micro se propuso en el presente estudio como aquellos sucesos que se desarrollan en la comunidad que se encuentran vinculados con la producción y movilización de los saberes; así como también, estos son asumidos desde una perspectiva hermenéutica-holística para comprender el contexto donde se construyen y las lógicas indígenas involucradas en estos (119).

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

Conjunto de saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del departamento de Córdoba para la construcción de una estrategia comunitaria que permita prevenir y controlar el dengue.

3.3 SUJETOS DEL ESTUDIO

Los sujetos del estudio fueron 21 personas de comunidades indígenas pertenecientes al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, del Departamento de Córdoba.

3.4 CONTEXTO INVESTIGATIVO

El ámbito de estudio correspondió a los asentamientos de comunidades indígenas ubicados en los corregimientos El Contento y Los Carretos, y en los Barrios Juan Carlos y La Bomba del municipio de San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba, ubicado geográficamente en las coordenadas 9° 08' y 57" latitud norte y 57° 30' y 44" latitud oeste, presenta clima cálido y corresponde a un bosque tropical seco. Este municipio se divide en 10 corregimientos, 57 veredas, 30 caseríos y un resguardo indígena, que a su vez se subdivide en comunidades que conforman los Cabildos (120)

La historia de San Andrés de Sotavento se remonta a la de los primeros pueblos indígenas que llegaron de Betancí, por lo cual gran parte de su población son descendientes de los Zenúes. El Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento fue creado en 1773 por la Corona española con una extensión de 83.000 hectáreas; y en la actualidad concentra el mayor número de miembros registrados del pueblo Zenú (40.996) en el Departamento de Córdoba, seguidos de Tuchín (39.061) y Chinú (16.363), entre otros (120).

Este municipio integra la sub región de sabanas en Córdoba, según el esquema territorial sugerido por el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, al igual que Tuchín, Chinú y Sahagún. De igual manera, reporta el mayor índice de pobreza multidimensional del Departamento, entre otros aspectos sociales que limitan las posibilidades de desarrollo de sus pobladores (120).

3.5 MUESTREO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En la presente investigación se realizó un muestreo por conveniencia pues se pretendió acceder a la mejor información posible en el menor tiempo, teniendo en cuenta los escenarios específicos en que se desenvuelven el investigador y los sujetos de estudio. Además, este tipo de muestreo permitió escoger los casos más accesibles y que aceptaran hacer parte del estudio, considerando la proximidad y accesibilidad de los participantes.

La selección de participantes se orientó con la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión enunciados a continuación:

Criterios de Inclusión

- Hombre o mujer mayor de 18 años.
- Persona con registro actualizado en la base de datos del Resguardo Indígena Zenú.
- Participante con vivienda permanente en los corregimientos El contento o los Carretos o en los barrios Juan Carlos y la Bomba del Municipio de San Andrés de Sotavento, localidades priorizadas según el número de casos de dengue notificados al SIVIGILA
- Que exprese el deseo de participar en el proyecto.

Criterios de exclusión

- Menores de 18 años.
- Que tenga vivienda transitoria en la región.
- Limitaciones mentales.
- Limitaciones físicas.

Los criterios de selección de la muestra se basaron en los principios de pertinencia que se refiere a la identificación y selección de participantes que aporten la mejor información posible a la investigación, la adecuación; que busca tener los datos suficientes y necesarios para la descripción del fenómeno, la conveniencia; para facilitar el trabajo de registro de la información a partir de una buena ubicación cultural del investigador dentro del grupo estudiado, la oportunidad, que es "estar en el momento justo, y en el lugar preciso", y finalmente, la disponibilidad o acceso a los lugares y situaciones que requiera la investigación (121).

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

Pertinencia: Se confirmó que los participantes cumplieran con los criterios de inclusión de esta investigación y que se encontraran con la mejor disposición para compartir sus saberes, actitudes y prácticas relacionadas a la prevención y control del dengue.

Adecuación: Para obtener datos suficientes que sustenten el estudio, se buscó alcanzar el punto de saturación, donde luego de realizar un número determinado de entrevistas y no se encuentre información nueva o distinta a la ya identificada se procede a suspender la búsqueda de participantes. Para ello, no se contó con límite de tiempo en la selección de los sujetos y la aplicabilidad de las entrevistas semiestructuradas,

Conveniencia: Con el propósito de tener una visión clara de la realidad estudiada, se tuvo en cuenta que la comunidad con la que se trabajara sea conocida o se tenga acceso a ella, facilitando que el investigador se posicione socialmente y garantice la mejor comprensión de las situaciones o eventos.

Oportunidad: Se coordinó con los líderes la mejor hora y lugar para realizar las entrevistas, permitiendo así que los participantes tengan disponibilidad de tiempo para responder las preguntas de forma tranquila y se sientan lo más cómodos posible, sin interrumpir sus labores diarias.

Disponibilidad: Se buscó contar con acceso permanente a las situaciones, lugares y eventos necesarios para la recolección de la información.

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

En una investigación cualitativa de tipo etnográfica, la recolección de datos prioriza la observación y el contacto directo del investigador con los participantes, lo que permitió desarrollar nuevas capacidades y métodos de acercamiento que mejoren el proceso de recopilación de la información. En el presente estudio, este proceso se realizó a través de tres técnicas; la técnica visual que correspondió a la observación participante, la técnica conversacional mediante grupos focales y entrevistas a profundidad, y la técnica gráfica utilizando la cartografía social.

El instrumento fue sometido a validación por panel de expertos en el área de la salud, a partir de la cual se recibieron sugerencias y aportes para reestructurarlo y refinarlo antes de su aplicación. Antes de iniciar con el trabajo de campo, se les solicitó a los participantes la firma del consentimiento informado, mediante el cual dejaron expreso su deseo de estar de acuerdo en participar de la investigación y se tuvo en cuenta los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus SARS COV 2 Covid-19 durante las entrevistas.

La composición de los grupos focales tuvo en cuenta el objetivo de la investigación definiendo criterios como rango de edad, sexo, entre otros, definiendo la homogeneidad o heterogeneidad de los participantes, los cuales debieron contar por lo menos con un rasgo en común que sea significativo para el estudio. Los grupos estuvieron conformados entre 5 a 7 participantes y el número total de grupos dependió del punto de saturación de las respuestas. Por su parte, el número de encuentros también se sujetó al número de categorías consideradas por el investigador y del momento en que las respuestas de los participantes no aporten información nueva.

Durante el desarrollo de los grupos focales se empleó la observación participante como técnica importante de recolección de información, la cual permite comprender la forma como los participantes se comunican entre sí y aportan herramientas para el análisis de las expresiones no verbales, garantizando la validez del estudio a través de una visión más amplia del contexto y del fenómeno estudiado.

Finalmente, la cartografía social permitió el empoderamiento de la comunidad de sus espacios territoriales donde acontecen sus relaciones vitales, teniendo en cuenta elementos sociales y culturales, que promueven su configuración como sujetos de acción social.

3.7 CRITERIOS DE RIGOR METODOLÓGICO

En cuanto a los criterios de rigor, esta investigación contó con estrategias que permitirán validar los resultados. Para ello, los instrumentos de recolección de datos empleados fueron sometidos a evaluación por un panel de expertos, para garantizar la exactitud y claridad del mismo. De igual forma, se emplearon los criterios de rigor propuestos por Guba y Lincoln (121) para estudios cualitativos, tales como la credibilidad, la confirmabilidad, y la transferibilidad.

Credibilidad: la credibilidad es posible cuando el investigador logra obtener información que genera hallazgos reconocidos por los participantes como aproximaciones a sus pensamientos y sentimientos, para lo cual se requerirá tomar atenta nota de las observaciones y conversaciones, así como una transcripción textual de las entrevistas.

Confirmabilidad: Esta estrategia permitió examinar la información obtenida, teniendo en cuenta la documentación que el investigador hizo de sus ideas y decisiones durante el estudio. Para ello se requerirá de una descripción del contexto físico e interpersonal de la investigación, así como de las características de los participantes y el análisis de las transcripciones de las entrevistas.

Aplicabilidad: a través de este criterio de rigor se pudo ajustar los resultados investigativos con miras a que puedan ser aplicados en otros escenarios, por lo que es imprescindible la descripción de las características de los participantes, identificando si es posible transferir los hallazgos a otro contexto.

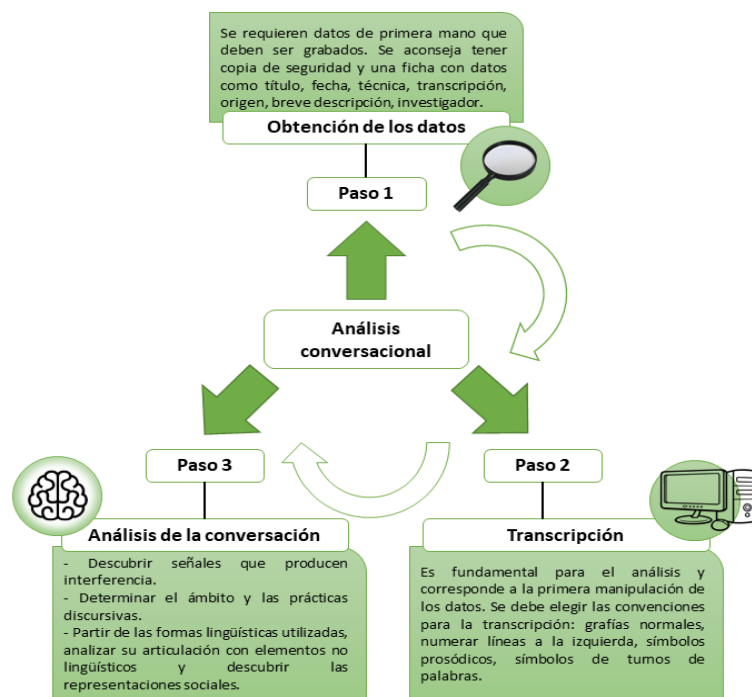
3.8 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS

Para el procesamiento y análisis de la información se empleó el método del análisis conversacional. Este ofrece una alternativa para examinar

detalladamente las interacciones verbales entre los participantes, para ello se requiere de la observación de los encuentros conversacionales, prestando especial atención en toda la actividad verbal que incluye las pausas, el silencio, la duda, los errores, el comportamiento, las creencias y aptitudes de los hablantes. Este método describe, categoriza, parafrasea y propone una investigación sistemática que busca entender lo que las personas expresan cuando hablan.

Los datos conversacionales deben tomar en consideración los objetivos del análisis, pues de ello depende saber la información exacta que se necesita recopilar, cuántos datos y de qué forma se obtuvo, partiendo de una pregunta de tipo lingüístico o de carácter social para proceder a recoger la información. Este método se aplicó a través de tres pasos principales: la obtención de los datos, la transcripción y el análisis de la conversación, que se describen en la siguiente gráfica:

Figura 3. Método del análisis de conversacional



Fuente: Elaboración propia a partir de Tuson (122)

3.9 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

Este estudio adoptó lo estipulado la Resolución 8430 de 1993, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en

Colombia. El Artículo 5, menciona que se debe proteger los derechos de las personas en toda investigación relacionada con seres humanos; por ello, durante todo el proceso de esta investigación se consultó previamente la disponibilidad y deseos de los participantes para participar del estudio; se tuvo en cuenta sus creencias, tradiciones y cosmovisiones; de tal manera que en ningún momento se impuso ningún tipo de pensamiento o doctrina para respetar el derecho a las ideas propias.

Así mismo, el artículo 8, trata sobre la importancia de proteger la confidencialidad del sujeto de investigación; en este sentido, se diseñó un sistema de codificación para las respuestas de estos utilizando códigos alfanuméricos para las entrevistas y los grupos focales. En ningún momento, se socializó el nombre o información personal de las personas que participaron.

El Artículo 11, define la clasificación del riesgo de la investigación que, para efectos de la presente, se puede decir que hace parte de la categoría sin riesgo, tras no modificar ningún aspecto biopsicosocial de los sujetos de estudio. Por su parte, los Artículos 14 y 15 mencionan la importancia del consentimiento informado, el cual fue diseñado y se empleó con fines de solicitar autorización de los entrevistados para hacer uso de la información obtenida durante el estudio.

3.10 PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESPONSABILIDAD

La propiedad intelectual de los resultados, así como la responsabilidad sobre el análisis, las conclusiones y los conceptos emitidos por la investigación, pertenece al investigador principal en su calidad de maestrando en Salud Pública; así como también, a su director temático quien podrá hacer uso del contenido con fines académicos y con autorización expresa del dirigido. Los datos divulgados siempre tendrán que dar crédito a la Universidad y los autores de esta obra.

3.11 ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DEL HALLAZGO

Para socializar los hallazgos se utilizarán distintas vías como la sustentación ante los jurados y evaluadores. Además, se elaboró un artículo científico para ser publicado en una revista científica. La estrategia comunitaria de prevención del dengue fue socializada con los participantes del estudio, autoridades indígenas y la comunidad en general.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El dengue es una enfermedad endémica en el Departamento de Córdoba que anualmente afecta a un significativo número de familias de diversas etnias, clases sociales y territorios. Estos grupos familiares construyen formas particulares de actuar frente a la proliferación del *Aedes Aegypti* e implementan acciones para prevenir y atender el dengue, las cuales se hace necesario documentar para encontrar mecanismos que coadyuven a minimizar los efectos de esta en la salud humana.

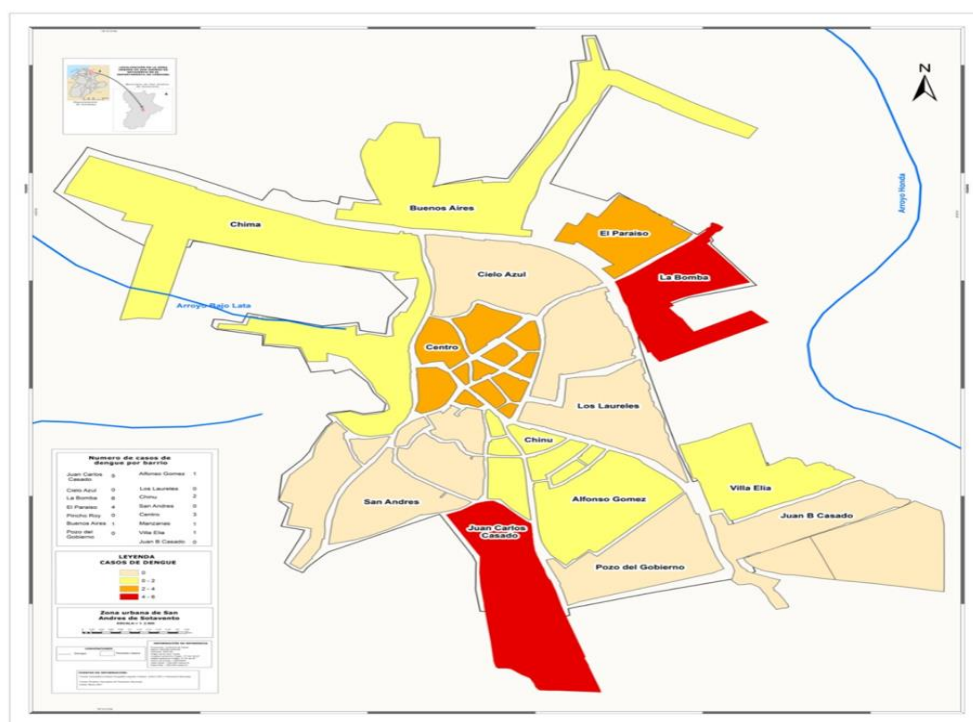
A continuación, se presentan los principales resultados de las 21 entrevistas realizadas en una comunidad del resguardo indígena Zenú del municipio de San Andrés de Sotavento; hallazgos vinculados con los resultados de los grupos de discusión que permiten construir rutas para el trabajo conjunto a partir de los saberes, actitudes y prácticas que construyen como comunidad étnica.

4.1 CONDICIONES INDIVIDUALES, FAMILIARES, COMUNITARIAS Y ESPACIALES DEL CONTEXTO DE ESTUDIO

El presente estudio se desarrolló con algunas comunidades del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento al norte del Departamento de Córdoba, Colombia. La distribución espacial de los casos notificados por dengue en el territorio se concentró en algunos barrios del sector urbano y en puntos específicos de la zona rural.

A partir de las estadísticas de la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba, se pudo cartografiar la prevalencia del dengue en la zona urbana del municipio durante el año 2020 en los barrios Juan Carlos Casado y la Bomba, adicionalmente, se evidencia la conformación de un “corredor” de casos cuyo crecimiento tiende a concentrarse en el sector céntrico del municipio y el Barrio El Paraíso del municipio de San Andrés de Sotavento (Figura 4).

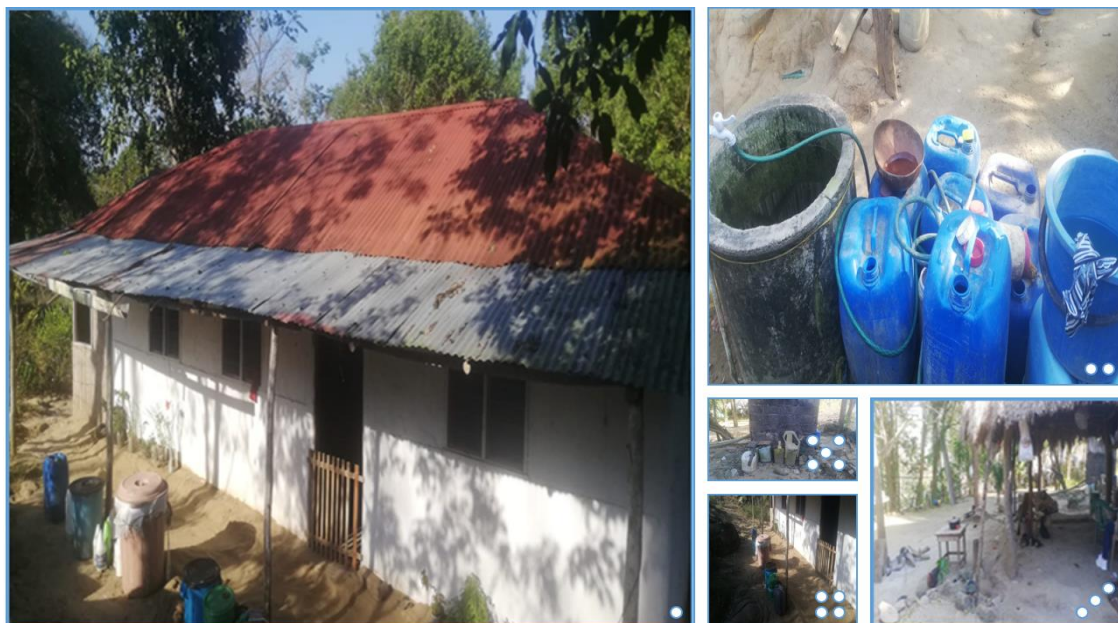
Figura 4. Ubicación de casos reportados de dengue en el área urbana del municipio de San Andrés de Sotavento, durante el año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de bases de dato de la Secretaría de Salud Departamental, 2021.

Las condiciones de las viviendas refieren diversas tipologías concernientes principalmente a los techos de zinc y de palma; y en las paredes predominaron el bloque y bahareque (entiéndase este último como aquel sistema constituido por palos entrecruzados con barro u otro material cubriéndolos), así como también, pisos de tierra para la zona rural y de cemento para la urbana (Ver Figura 5).

Figura 5. Condiciones de las viviendas

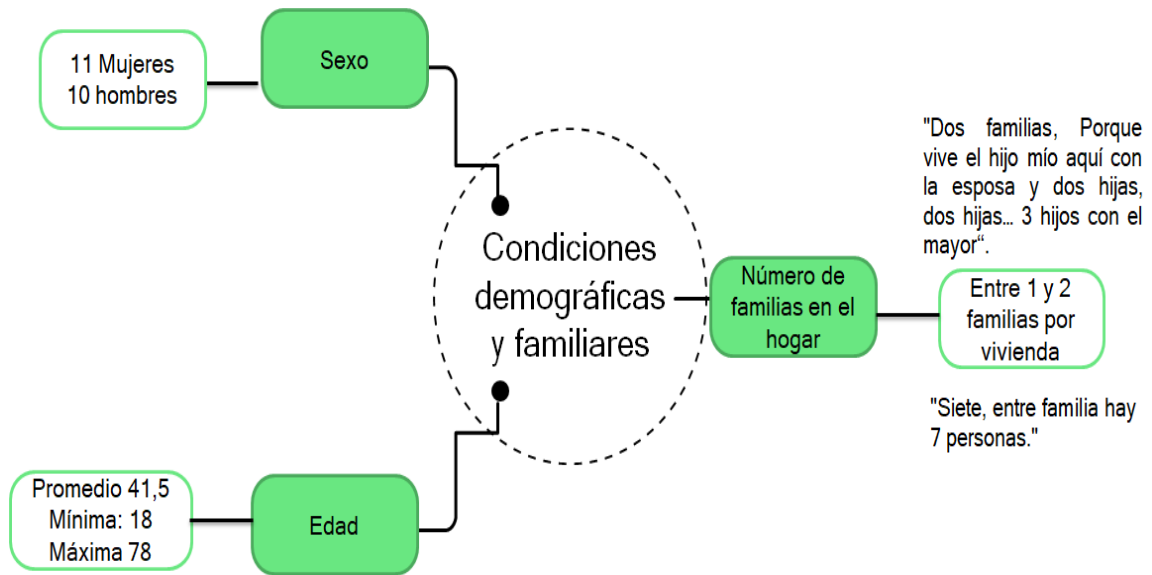


Fuente: Elaboración propia

En la Figura 5, se puede observar la necesidad que tienen muchas de las familias entrevistadas de almacenar aguas lluvias en diversos recipientes, debido a las deficiencias en el servicio de acueducto en esta localidad, lo que se constituye en una práctica que incrementa el riesgo de contraer dengue de no adoptarse las medidas adecuadas para prevenir los criadores potenciales de mosquito como son las aguas estancadas.

En relación con las condiciones demográficas de los participantes, se pudo establecer mayorías femeninas ($n=12$), mientras que la edad promedio se ubicó en 41.5 años y se estableció una edad mínima de 18 y máxima de 78 años. Las características familiares reportan convivencia en una sola vivienda de 1 a 2 hogares; con predominio de aquellas, mediante las cuales los hijos de los dueños de la casa continúan en esta, posterior a su conformación de pareja, como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6. Condiciones individuales y familiares de los participantes

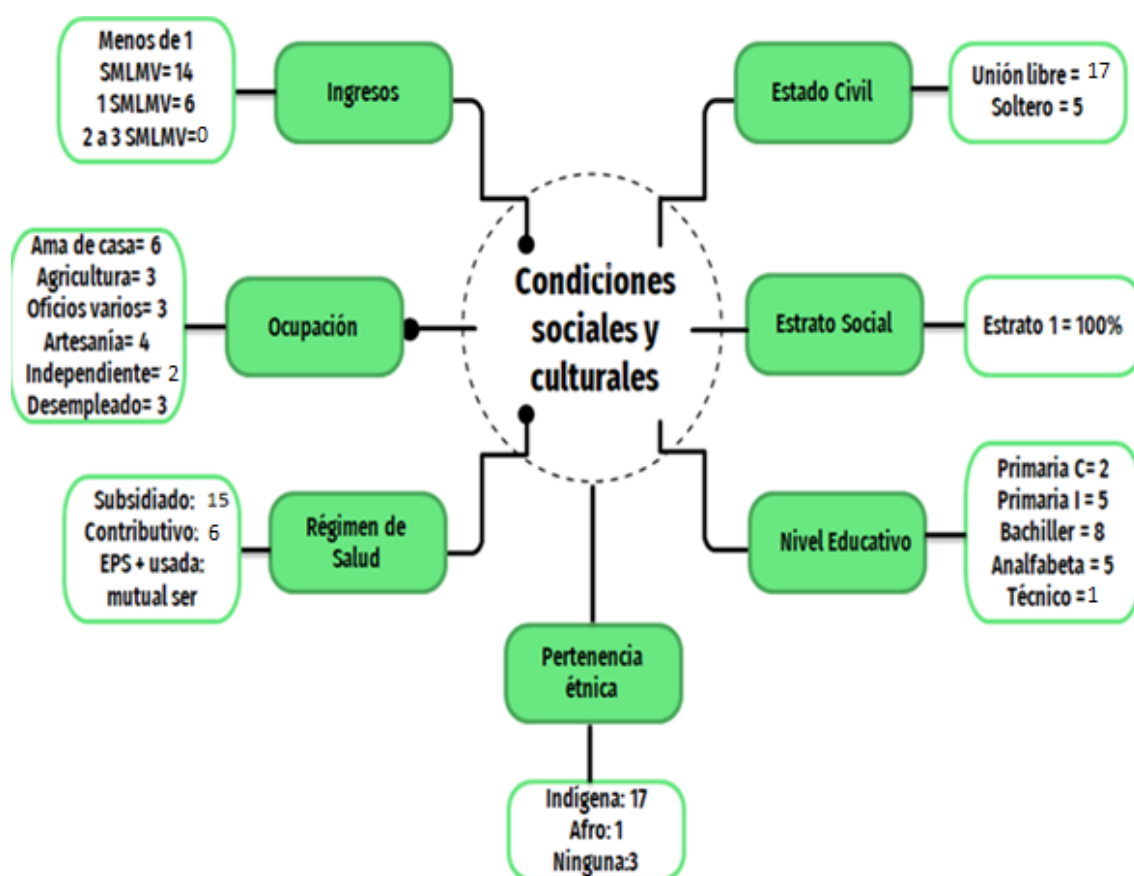


Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos del estudio, 2021.

En cuanto a las condiciones socioculturales de la población se encontró primacía de hogares que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente para su subsistencia; así como también, el predominio en el desarrollo de actividades económicas ligadas al sector informal de la economía (amas de casa, agricultura y artesanías). Todos los participantes informaron pertenecer al estrato socioeconómico 1, lo cual se articula con el tipo de afiliación al sistema de salud, cuya principal tendencia arrojó que pertenecen al régimen subsidiado, siendo la EPS con mayor reporte la Mutual SER.

La Figura 7, refleja que gran parte de los participantes pertenecen a la etnia indígena Zenú y su nivel de formación académica mayoritariamente a bachilleres. Se encontró que solo dos participantes cursaron estudios técnicos posterior al nivel secundario y se destaca la significativa representación de personas analfabetas y con primaria incompleta.

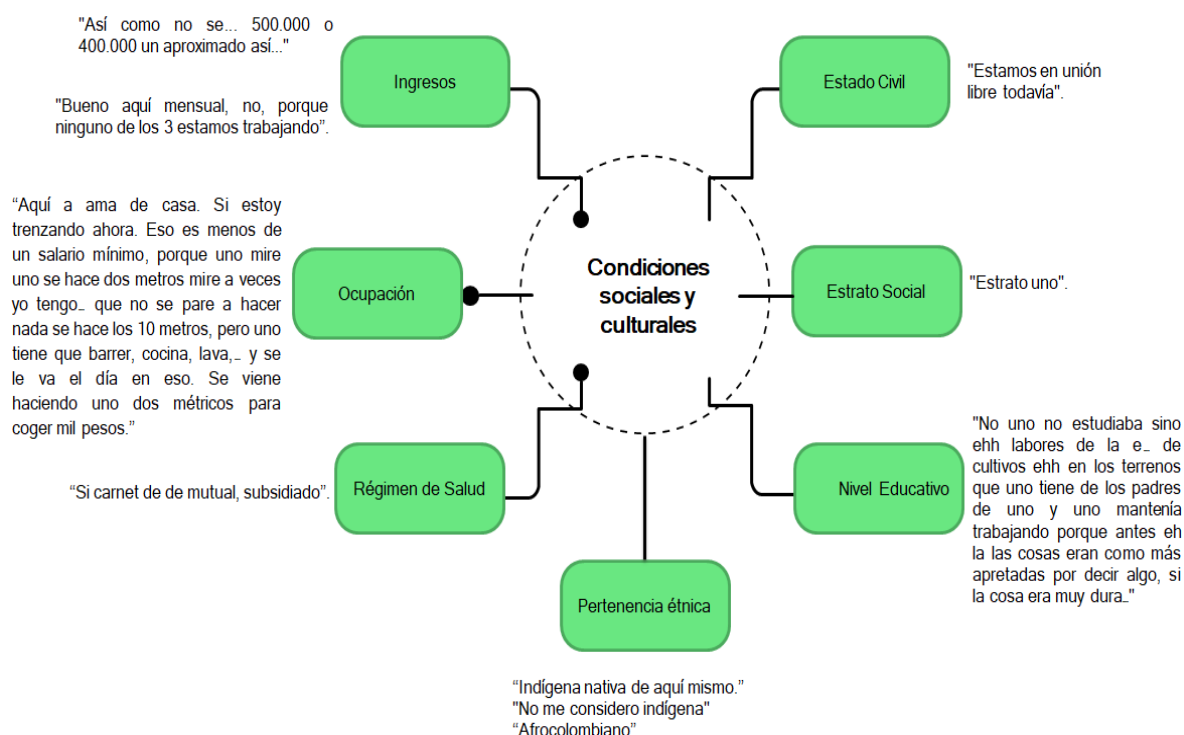
Figura 7. Condiciones sociales y culturales de los participantes



Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

Los resultados evidenciados en la Figura 7, muestran relación con las dinámicas sociales y culturales que se producen en el municipio de San Andrés de Sotavento. En especial, por ser este un territorio del Pueblo Zenú, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, reflejándose en los testimonios de los participantes, cuyos fragmentos se muestran a continuación en la Figura 8.

Figura 8. Testimonios sobre condiciones sociales y culturales de los participantes



Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

La Figura 8, señalan los testimonios acerca de las condiciones precarias de vida que afrontan la mayoría de los participantes del estudio. Estos son una muestra de las vivencias cotidianas y un acercamiento a las trayectorias de vida de la población sujeto de estudio, las cuales son importantes al momento de comprender la problemática del dengue.

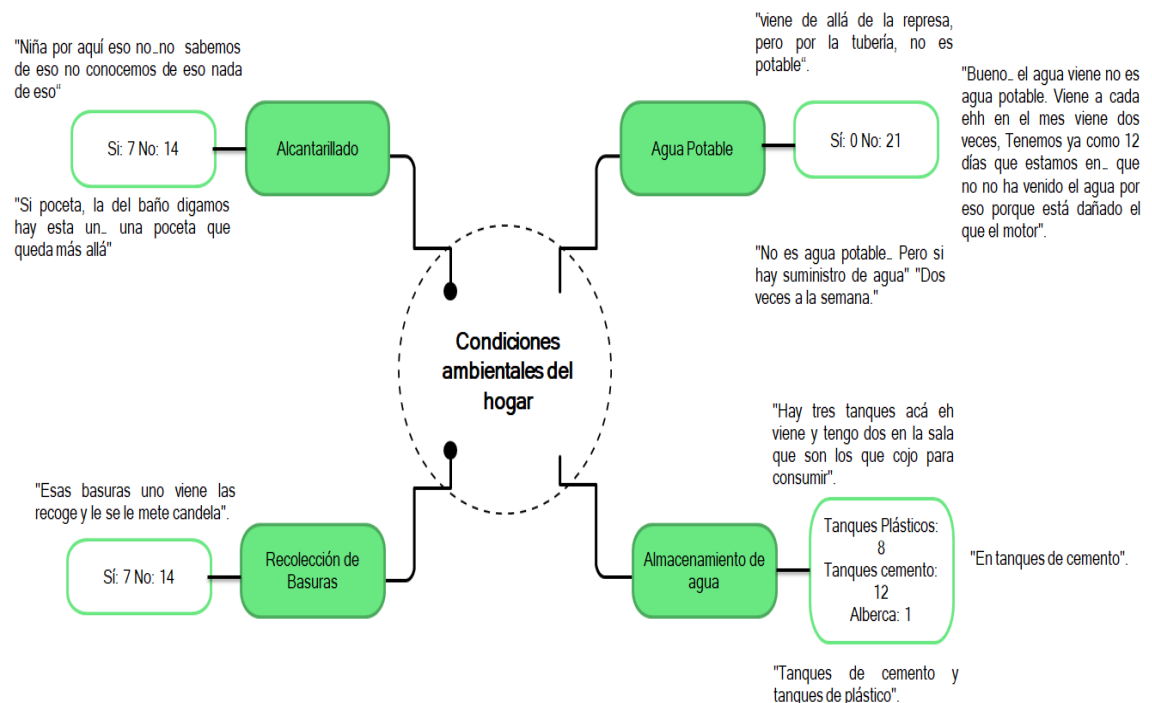
Uno de los factores claves asociados con la prevalencia del dengue son las condiciones de la vivienda como son el acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, recolección de basuras. Los resultados obtenidos se articulan con los presentados en la Figura 5, evidenciándose cierta tendencia hacia la precariedad de mínimos vitales que puedan mejorar las condiciones de vida en esta población. En ese sentido, se obtuvo que prevalece la ausencia del servicio de recolección de basuras y de alcantarillado como se evidencia en la Figura 9.

Por otra parte, los hallazgos informan que el total de los hogares del estudio no cuentan con servicio de agua potable. Los participantes afirman que este servicio proviene de cuerpos de agua aledaños, el cual llega a las viviendas sin ningún

tratamiento y con muchas irregularidades en cuanto a la frecuencia de esta, que puede variar entre dos y ocho días; e inclusive, hay casos donde la disponibilidad de agua podría demorar hasta 15 días, como lo reflejan los testimonios de las personas entrevistadas.

Condicionado a lo anterior, los participantes del estudio y sus familias se ven advocating a almacenar agua en diferentes recipientes para poder esperar el siguiente bombeo o suministro de esta. En ese sentido, la Figura 9 destaca que los participantes emplean tanques de cemento o plásticos, y albercas dispuestas en el hogar para acumular este elemento vital.

Figura 9. Condiciones ambientales de la vivienda: acceso a servicios públicos



Fuente: Elaboración propia a partir de la categorización de las entrevistas, 2021.

La situación anterior, representa altas posibilidades para la creación de criaderos de *Aedes Aegypti* al interior de las viviendas y aumenta las probabilidades de contraer en algún momento de la trayectoria de sus vidas, la enfermedad del dengue. A su vez, el reconocimiento de las condiciones ambientales del hogar, permite que la estrategia a presentar esté formulada para dar respuesta a estas dinámicas particulares que se viven al interior de las comunidades del Resguardo Zenú en el municipio de San Andrés de Sotavento.

4.2 SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS RELACIONADOS CON LA PREVALENCIA DEL DENGUE

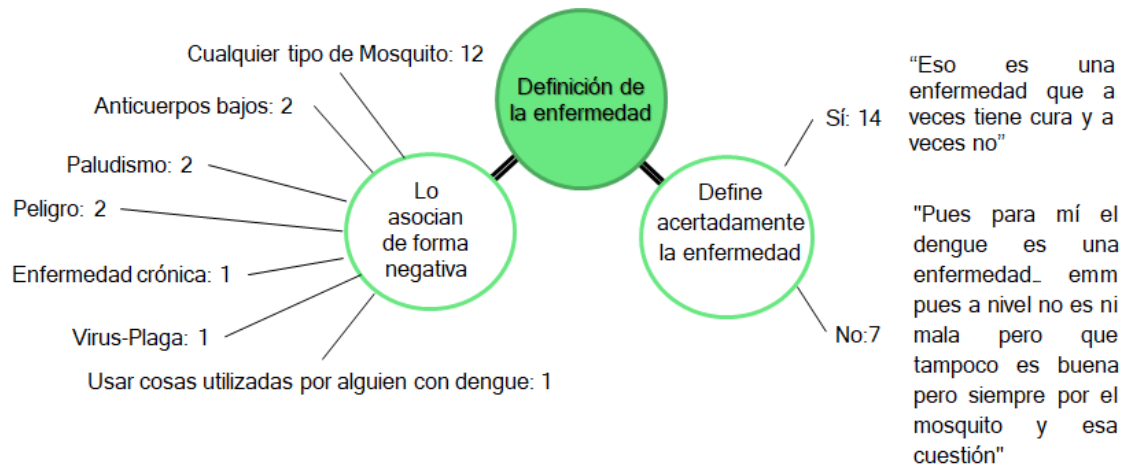
La exploración de saberes, actitudes y prácticas que de manera individual, familiar y colectiva poseen los participantes del estudio para la prevención y atención del dengue constituyen un pilar clave para el diseño de estrategias comunitarias para fortalecer los procesos y esfuerzos para prevenir el dengue en la comunidad de estudio y otros grupos humanos con características afines.

4.2.1 Saberes comunitarios relacionados con la prevención y atención del dengue. Los saberes o conocimientos comunitarios emergentes en el presente estudio, giraron en torno a tres subcategorías. La primera: **“Lo Pica el mosquito”** permite mostrar de manera colectiva los significados construidos por los participantes en relación con el *Aedes Aegypti* y su mecanismo de transmisión. La segunda: **“Los ojos todos eclipsados y una fiebre que no se reposa”** representa las respuestas ante los síntomas que los actores participantes asocian con el dengue. Por último, la tercera: **“Nosotros mismos tenemos que cuidarnos”**, se aprecia el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas de cara a la prevención y atención de la enfermedad.

En la Figura 10, se pueden apreciar los significados asociados con el dengue, donde se muestra que 14 de los participantes manifestaron saber qué era el dengue; sin embargo, cuando se continuó la indagación se pudo constatar que algunas de estas asociaciones estaban erróneas, lo cual pone de manifiesto falencias de la población con respecto a definir dicha enfermedad.

A manera de ejemplo, la mayoría de los participantes indicaron que esta patología es transmitida por cualquier tipo de mosquito, información que resulta un tanto incorrecta si se analiza con lo estipulado en la etiología de la enfermedad. Otras asociaciones que realizaron los miembros de la comunidad con el dengue fueron: tener anticuerpos bajos, usar cosas u objetos utilizados por alguien con dengue, o lo relacionan con otras enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo.

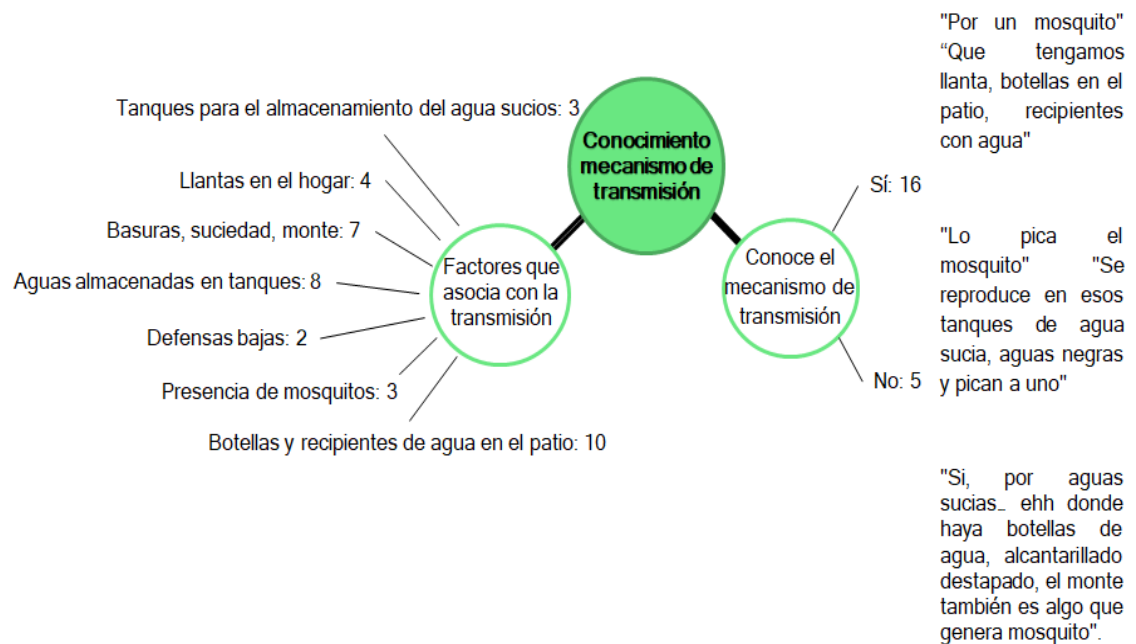
Figura 10. Definición y asociaciones relacionadas con el dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de la categorización de las entrevistas, 2021

En cuanto a los mecanismos de transmisión la mayoría de los participantes expresaron que el dengue se transmite: *"por un mosquito, que tengamos llantas, botellas en el patio, recipientes con agua"* (E5), este tipo de afirmaciones reflejan que existe un reconocimiento acerca de la biología del agente y cómo se produce la enfermedad. Se destaca la percepción emitida por los entrevistados ante el riesgo de botellas y recipientes de agua sin tapas expuestas en sitios como el patio de la casa con la predominancia de la enfermedad al favorecer la proliferación del vector y su transmisión, tal como se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Reconocimiento de mecanismos de transmisión asociados con el dengue

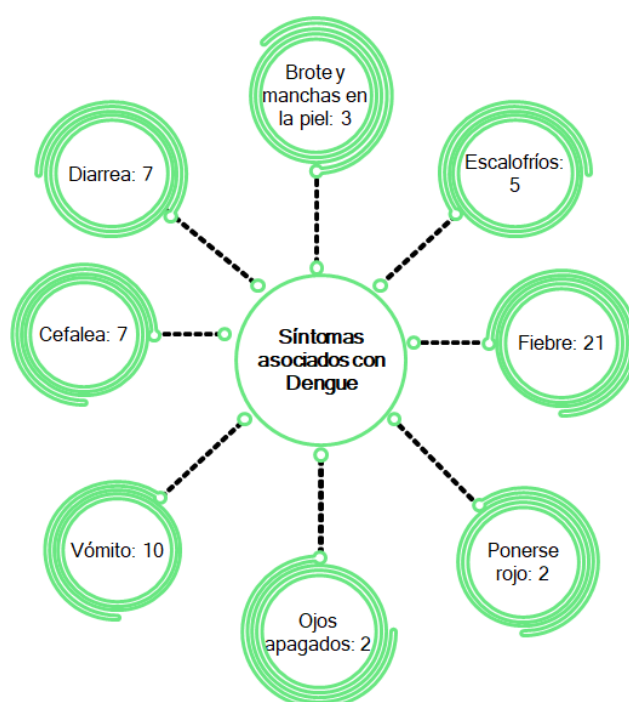


Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021

Los resultados para esta categoría muestran que los participantes poseen nociones básicas relacionadas con los factores que favorecen la transmisión del dengue; sin embargo, cuando se indagó por el significado de la enfermedad, las respuestas en su mayoría fueron confusas por lo que se requiere solidificar estas pre-concepciones que poseen los participantes, situación a la que debe dar respuesta la estrategia a diseñar en la presente investigación.

4.2.2 Los ojos todos eclipsados y una fiebre que no se reposa: percepción y asociación sintomatológica con el dengue. Los resultados de esta categoría se muestran en la Figura 12, destacándose como principal síntoma la fiebre, seguido de otras manifestaciones como vómito, diarrea y cefalea. Los participantes enunciaron otros síntomas como escalofríos, brote o erupciones cutáneas, ojos apagados y algunos manifestaron que un paciente con dengue se caracteriza por ponerse su piel roja, manifestación un tanto inusual pero que obedece a posibles vivencias de los participantes, tal como se presenta en la Figura 12.

Figura 12. Síntomas que asocian los participantes con el Dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de la categorización de las entrevistas, 2021.

Es de resaltar que estas afirmaciones sobre el conocimiento de la sintomatología asociada al dengue, parte de las experiencias personales o familiares de los sujetos, obedece a la propia experiencia y no conecta a los parámetros de una

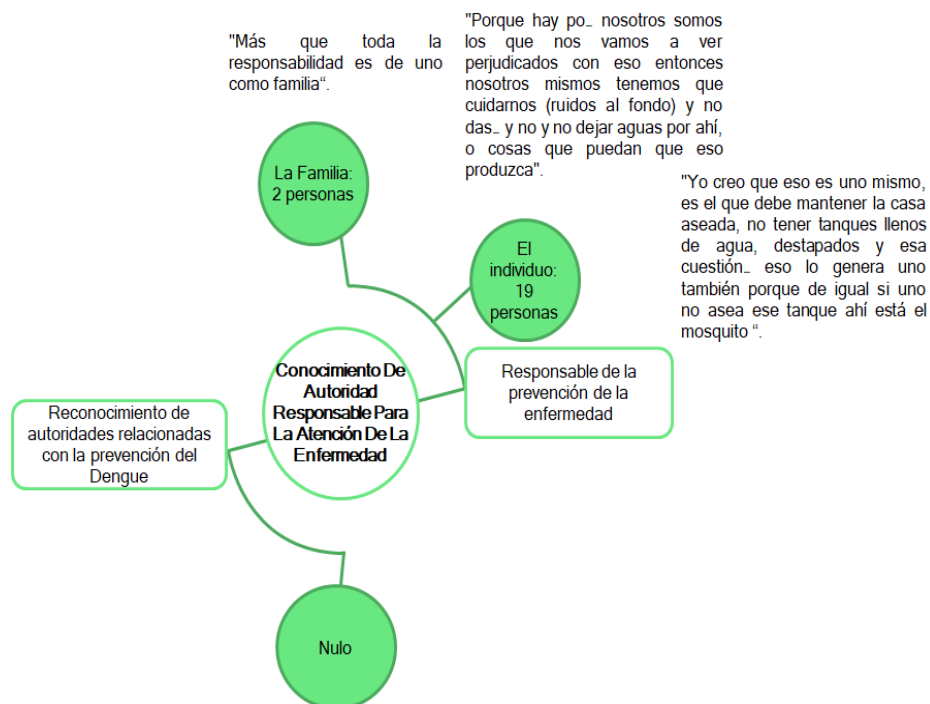
educación para la salud intencional, por lo que puede llegar a convertirse en un tipo de conocimiento fragmentado.

La fiebre es el síntoma más característico, seguido del vómito, la cefalea, la diarrea y los escalofríos. Por su parte, síntomas como brotes y manchas en la piel, “ponerse rojo” o los “ojos apagados” fueron los menos reconocidos por las personas entrevistadas. Cabe anotar que el poco conocimiento que se evidencia en relación con los síntomas del dengue, puede deberse a la falta de actividades educativas y la fragilidad del sistema de salud pública local, donde la información no llega de manera formal a las comunidades, las cuales no han recibido apoyo educativo por parte de las autoridades, obstaculizando la puesta en marcha de estrategias comunitarias con mayor movilización y participación social.

4.2.3 Nosotros tenemos que cuidarnos. Reconocerse y reconocer al otro como actor clave para la prevención y atención oportuna del dengue, es una condición importante para construir una estrategia comunitaria que permita empoderar a todos los actores en función de un propósito para el bienestar colectivo.

En ese sentido, las respuestas de los participantes entrevistados se dividen en dos secciones; por un lado, se encuentran aquellos testimonios que reconocen la responsabilidad individual que debe ir en función no solamente de sí mismo, sino también de la familia. Por otra parte, no existe reconocimiento de la responsabilidad que deben asumir las autoridades locales en el control y prevención del dengue, tal como se aprecia en la Figura 13.

Figura 13. Reconocimiento de responsabilidades para la prevención y atención del dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de la categorización de las entrevistas, 2021.

En este sentido, la mayoría de las personas entrevistadas conocen la responsabilidad del individuo en la prevención y control del dengue, mientras que solo dos participantes reconocen el papel fundamental de la familia para la atención de la enfermedad. Por otra parte, la falta de conocimiento que tienen los entrevistados en relación con las autoridades responsables de gestionar este tipo de acciones, evidencia la necesidad de una vinculación más activa de los actores institucionales en el desarrollo de actividades que contribuyan a mejorar la efectividad de las mismas.

4.3 ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL DENGUE

4.3.1 Actitudes. Las actitudes evidenciadas por los participantes de la investigación, reflejan la forma en que los sujetos actúan frente a un caso de dengue en su familia o inclusive en su comunidad. Estas representan en el contexto de la investigación un punto de acercamiento a las experiencias de los sujetos con relación a la enfermedad. Los hallazgos muestran desconocimiento de la estrategia de control de vectores, además se pudo percibir el abandono de los procesos educativos e intervención comunitaria que podrían incidir en mejorar dichas actuaciones.

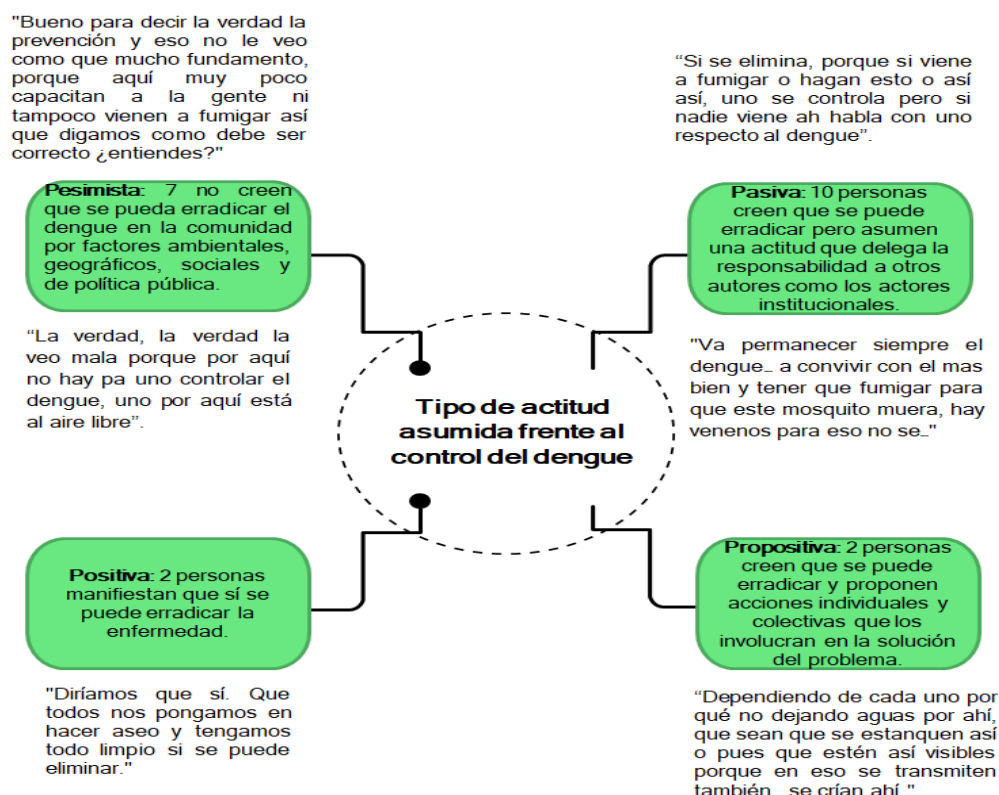
La Figura 14, recoge las principales actitudes asumidas por los entrevistados de cara a la vivencia del dengue. En primer lugar, se evidenció en un mayor número de participantes una actitud pesimista frente al control de la enfermedad, por

ejemplo, afirmaciones como *“Va permanecer siempre el dengue... a convivir con el más bien...”* (E= 13), así lo constatan.

Seguidamente se encuentran las personas con una actitud pasiva, cuando en sus testimonios consideran que, si se puede disminuir la prevalencia de la enfermedad, con el apoyo institucional (la institucionalidad en este caso). En este sentido, los entrevistados señalan el abandono en que se encuentran: *“aquí muy poco capacitan a la gente ni tampoco vienen a fumigar”* (E=21).

En menor proporción se encuentran las personas con actitud positiva frente al control de esta enfermedad y del vector, mostrándose optimistas, lo cual resulta ser el ideario a esperar de todos los participantes, porque estas personas asumen un rol activo y comprometido en la solución del problema y no están a esperas que el (los) otro (s) lo solucionen por ellos *“Que todos nos pongamos en hacer aseo y tengamos todo limpio si se puede eliminar”* (E=13), tal como se aprecia en la Figura 14.

Figura 14. Actitudes asumidas por los participantes frente al control del dengue



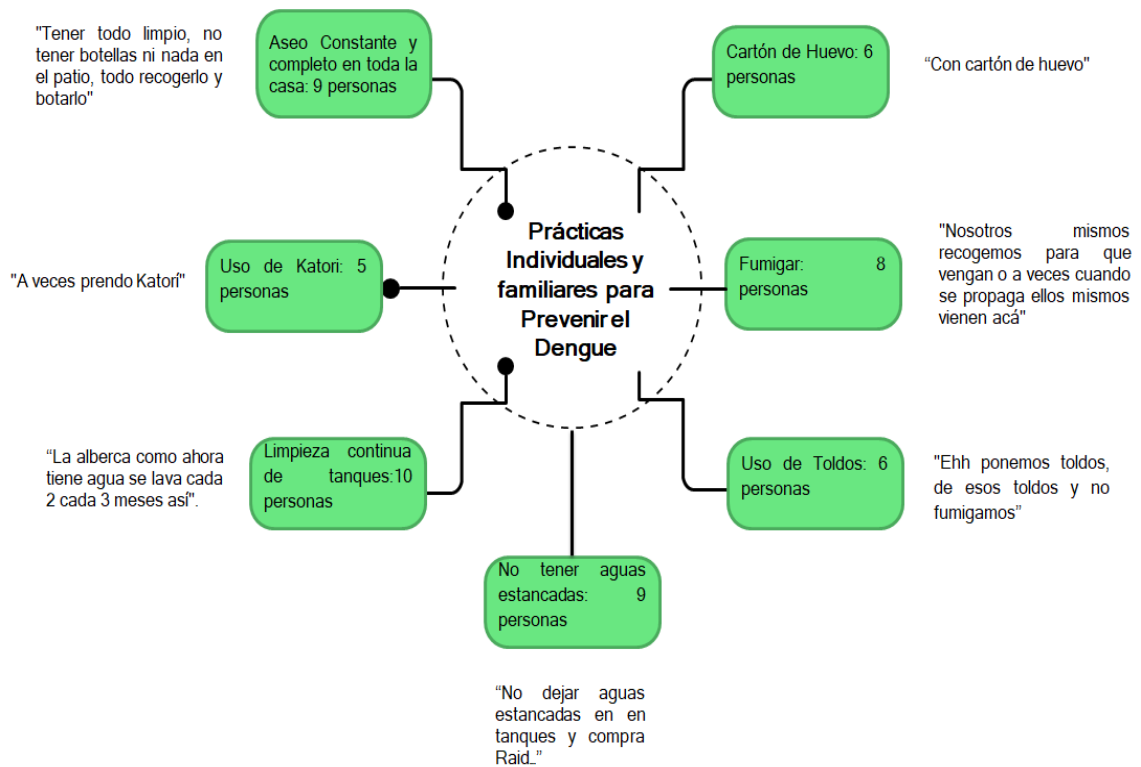
Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

4.3.2 Prácticas de prevención y control del dengue. Siguiendo con los resultados obtenidos, la categoría de prácticas se desplegó a partir de tres subcategorías: ***"actuar-es"***, ***"Entre lo ancestral y lo actual: recursos para afrontar el vector y la enfermedad del dengue"*** y ***"Qué hacer frente a los síntomas"***.

La primera subcategoría: ***"actuar-es"*** muestra las acciones generales desarrolladas por los sujetos a nivel personal, familiar y comunitario para prevenir la proliferación del vector en su entorno. La segunda: ***"Entre lo ancestral y lo actual: recursos para afrontar el vector y la enfermedad del dengue"***, se evidencian todos los recursos empleados por los sujetos para afrontar de manera activa la presencia del vector transmisor y los efectos en la salud humana, en esta se aprecian los recursos y prácticas heredadas del contexto familiar y sociocultural, así como también se visibilizó otro tipo de productos y herramientas propias del desarrollo químico e industrial actual que coexisten con las anteriormente enunciadas. Por último, los resultados concernientes a: ***"Qué hacer frente a los síntomas"***, comprende las acciones de los sujetos de cara a la identificación de posibles síntomas asociados con el dengue.

A partir de lo anterior, la Figura 15 pone de manifiesto los resultados obtenidos para la primera subcategoría, específicamente se muestran las acciones individuales y familiares que adoptan para prevenir el dengue en los hogares equivalentes a la limpieza continua en la casa, no acumular basuras y lavar los recipientes de almacenamiento, seguido de otras más generalizadas como el humo generado por la quema de varios materiales: Katori, cartón de huevos u hojas de árboles típicos de la región. No se puede desconocer que en las entrevistas también afloraron prácticas como la fumigación con diferentes productos químicos de amplia comercialización.

Figura 15. Prácticas individuales y familiares para prevenir el dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

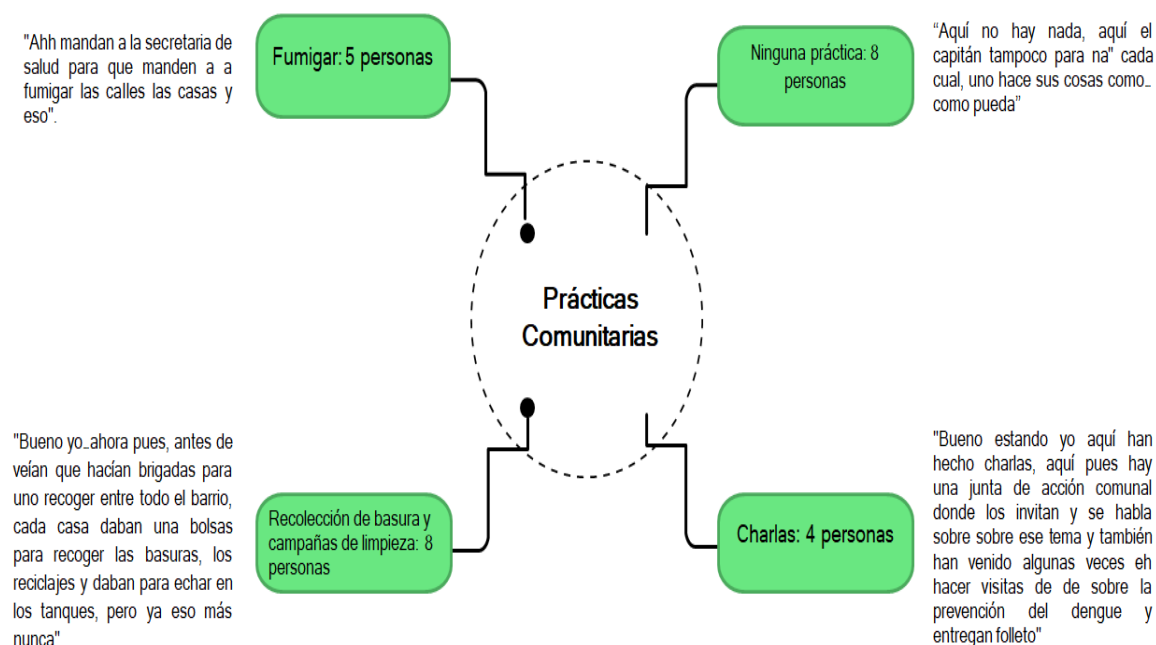
Las prácticas generales que desarrollan los sujetos para prevenir el dengue, tales como la limpieza de los tanques, el aseo de las viviendas y la fumigación son actividades reconocidas entre los entrevistados. No obstante, las respuestas también reflejaron poco conocimiento frente a la biología del vector en cuanto a criaderos y reposaderos. Por otra parte, en la subcategoría **“entre lo ancestral y lo actual: recursos para afrontar el vector y la enfermedad del dengue”**, se encontró el uso de algunos productos comerciales como el Katori y la quema de plantas como el matarratón como las prácticas más utilizadas para ahuyentar o eliminar las poblaciones de mosquitos adultos presente en las viviendas.

De igual manera, el uso de espirales antimosquitos es ampliamente utilizado por las comunidades, aunque es poco lo que dicen los participantes y autoridades sanitarias sobre el riesgo para la salud que representan estos productos, los cuales están compuestos por piretroides clasificados por la OMS como levemente peligrosos (123); si su uso es seguido y prolongado puede causar vómito, diarrea y daño pulmonar (124). Además, según el estudio de Shu-Chen y colaboradores (125), la exposición al humo de los espirales de mosquito puede ser un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Este tipo de riesgos se debe

socializar oportunamente con los colectivos para evitar futuras afectaciones a su salud.

Por otra parte, la Figura 16, muestra las prácticas comunitarias realizadas para prevenir la proliferación de criaderos del vector transmisor del dengue, los resultados indican que estas no se realizan con frecuencia, sin embargo, la población sujeto destaca acciones como las jornadas de fumigación dirigidas por la alcaldía municipal, y en ocasiones por los mismos vecinos, así como también, la realización de jornadas de aseo, recolección de basuras y en menor medida, se mencionó la realización de charlas.

Figura 16. Prácticas comunitarias realizadas para prevenir la transmisión del dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

Siguiendo con la presentación de los resultados, la segunda subcategoría de prácticas de prevención y control del dengue se muestra en las Figuras 17 y 18, poniendo sobre la mesa la coexistencia de prácticas construidas culturalmente y de recursos con alto procesamiento químico e industrial.

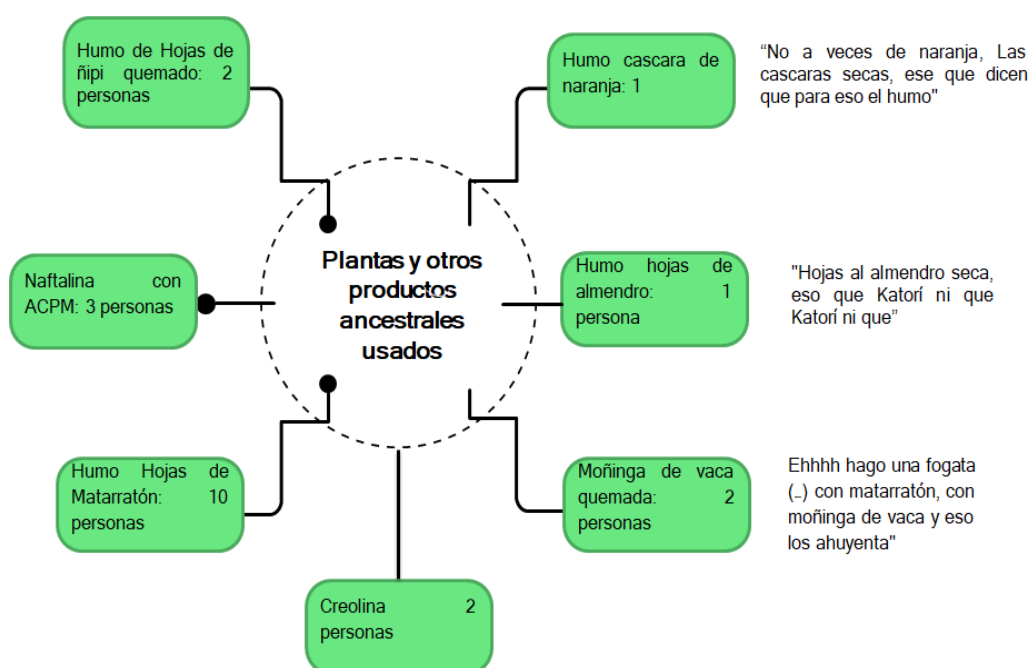
En ese sentido, la Figura 17 enfatiza en los recursos y estrategias tradicionales que manifiestan los participantes utilizar en la actualidad, destacando la quema de diversas plantas como el matarratón, almendro, naranja y ñipi que son árboles típicos de la región, aunque también se encontraron casos donde quemaban estiércol de vaca.

En contraste, hay familias que emplean en la actualidad recursos como fumigar la casa con creolina, ACPM y Naftalina. Los participantes desconocen el riesgo derivado de la exposición a los vapores de productos químicos, que en el caso de esta última su uso debe limitarse solo al control de las polillas de la ropa a través de un procedimiento establecido que no genere riesgo para la salud, de lo contrario, puede provocar cefalea, diarrea, vómito, náuseas, tos, irritación de ojos y nariz, así como también efectos más graves por la exposición a largo plazo que puede producir daño al hígado y al riñón (126).

Los resultados de las entrevistas permiten observar que los participantes prefieren recurrir a la quema de plantas y productos químicos antes que realizar la limpieza de los tanques y demás recipientes de agua, aduciendo la escasez del líquido. Esta situación es preocupante si se tiene en cuenta las preferencias de la hembra del *Aedes aegypti* durante el proceso de oviposición. De igual manera, las aspersiones de humo se realizan con plantas y sustancias aromáticas cuyo uso continuo podría tener consecuencias a nivel pulmonar en los miembros de la familia; sin embargo, estas se afianzan en dicha práctica tras considerar que el mosquito puede percibir los olores fuertes y alejarse de las viviendas.

Por otra parte, la entrega de folletos educativos por sí solos no produce el efecto esperado, porque esta ha de estar acompañada con charlas y visitas a las familias para tratar temas como los compromisos intrafamiliares y personales en el autocuidado. Así las cosas, suele convertirse en una medida poco eficiente ni costo-efectiva, si se toma en consideración el déficit educativo reportado, lo que dificulta que la información de este tipo de campañas de control y prevención del dengue contribuya en el fomento de una actitud positiva y participativa en los miembros del Resguardo.

Figura 17. Plantas y recursos tradicionales empleados para la prevención del dengue

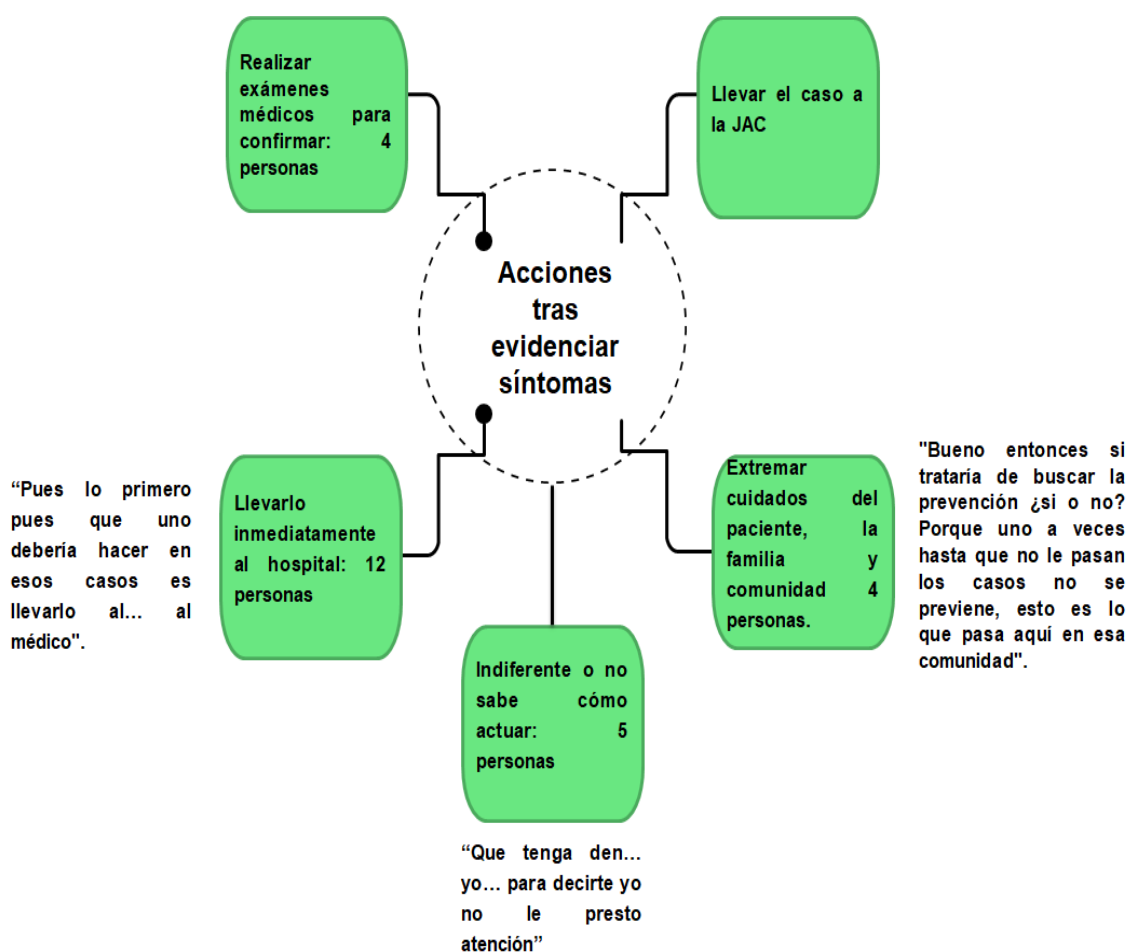


Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

En lo que concierne a las prácticas realizadas al conocer un caso positivo de dengue en la comunidad se puso de manifiesto que la reacción primaria es llevar a la persona de inmediato al hospital para que sea atendida por el personal médico o le realicen exámenes correspondientes.

La Figura 18, también muestra resultados acordes con el nivel de conocimiento que estos participantes poseen sobre el dengue, al no saber cómo actuar o ser indiferentes frente a estos, constituyendo una situación de riesgo para la salud del paciente, puesto que se le debe brindar una atención oportuna para mitigar cualquier daño u afectación, es por esta razón, que ante el desconocimiento de la secuencia de los síntomas del dengue, se hace necesario implementar estrategias educativas sobre el manejo de cada uno de ellos desde las prácticas familiares, permitiendo a las comunidades identificar las señales de alerta temprana para evitar así las complicaciones.

Figura 18. Prácticas relacionadas con la manifestación de síntomas asociados con Dengue



Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos, 2021.

4.4 ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE: “HOJAS DE ALMENDRO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE”

Los resultados hasta aquí presentados constituyeron el punto de partida para la construcción de la Estrategia: “Hojas de Almendro para la prevención y control del dengue”, la cual se presenta a continuación:

ESTRATEGIA
COMUNITARIA

HOJAS DE ALMENDRO

Para la prevención del
dengue



¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA HOJAS DE ALMENDRO?

La Estrategia Comunitaria “Hojas de Almendro” es una iniciativa derivada de este proyecto de investigación, con la que se busca plantear acciones e intervenciones integrales para la prevención y control del dengue, a partir de los saberes, actitudes y prácticas de los indígenas de un resguardo del Departamento de Córdoba.

Esta estrategia debe su nombre a la respuesta de uno de los participantes del estudio, quien ante la pregunta sobre las plantas o productos ancestrales que utilizaba para prevenir el dengue, respondió: **“Hojas de almendro secas, eso que Katori ni que Katori ni que...”**, haciendo alusión a un producto comercial popularmente utilizado en las casas para repeler los mosquitos, demostrando que, por lo menos en su caso, ese saber ancestral ha demostrado su efectividad.

Para la implementación de la estrategia “Hojas de Almendro”, se requiere la conformación y capacitación de un grupo de personas interesadas en fomentar la participación de su comunidad en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Esta iniciativa se considera una prueba piloto que pone a dialogar los saberes ancestrales con aquellos formulados y consignados en las políticas de salud pública y la Estrategia de gestión integral del dengue, con el propósito de consolidar un conjunto de acciones contextualizadas que responda a las necesidades y particularidades del territorio.

Para la formación de los participantes que conformarán la “Patrulla anti dengue” se cuenta con referentes teóricos fundamentados en la salud intercultural, así como con un marco conceptual donde se definen conceptos importantes como dengue, prevención y control, actitudes, conocimientos, prácticas y estrategia comunitaria. De igual forma, esta estrategia se sustentará en el Enfoque Territorial y el Enfoque Étnico del Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE). Finalmente, las pautas para la implementación de la estrategia se desarrollarán en cinco fases; Diagnóstico, Formación, Articulación, Implementación y Evaluación.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA ESTRATEGIA?

La estrategia se fundamenta en la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles y la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021, el cual busca garantizar el derecho de los colombianos a vivir sin enfermedades transmisibles en todas las etapas de la vida sin distinción alguna y pretende reducir la exposición a condiciones de riesgo sanitarios y biológicos, y crear capacidades en las personas para gestionar planes y programas que reduzcan el riesgo a las exposiciones (101).

En cuanto a la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, el enfoque étnico del PDSP promueve la protección de los derechos colectivos de las etnias, mediante la planeación en salud etnocultural y el desarrollo de rutas de atención que preserven las raíces culturales de la medicina tradicional (108). De acuerdo a lo anterior, la Estrategia Hojas de Almendro está dirigida a comunidades indígenas con el propósito de proteger y conservar sus prácticas tradicionales en salud y su cosmovisión ante la prevención de enfermedades, específicamente las transmitidas por vectores.



¿POR QUÉ EL DENGUE?

El dengue es una enfermedad vírica transmitida principalmente por mosquitos hembra de la especie *Aedes aegypti*, que viene en aumento en las regiones tropicales y subtropicales del mundo con aproximadamente 390 millones de infecciones anuales de las cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. El número de casos reportados de dengue se ha multiplicado por 8 en los últimos 20 años, pasando de 505.430 casos en 2000 a 4,2 millones en 2019 (1). Asimismo, la región de las Américas 579.645 casos en 2017, 561.398 en 2018, 3.167.542 en 2019 y 2.251.859 en 2020 (3), lo que evidencia un comportamiento cíclico expresado en picos epidémicos cada 3 o 4 años (127).

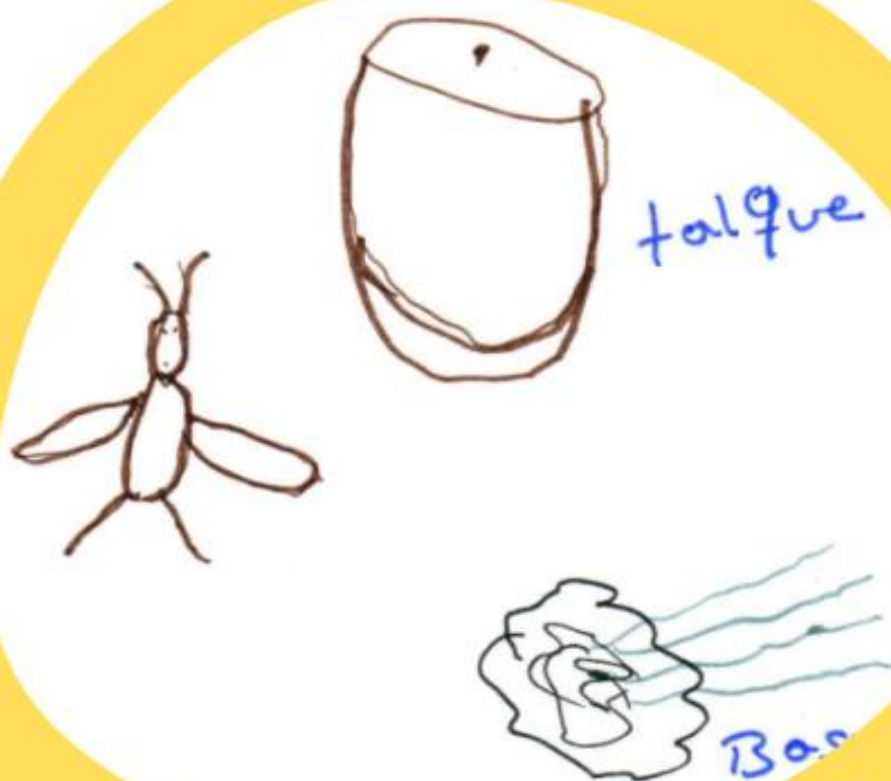
Colombia, ocupó para el año 2021 el segundo lugar de los países con mayor número de casos reportados en la región de las Américas (23), con un total de 53.334 casos y una incidencia de 104,03, de los cuales 29.334 fueron confirmados por laboratorio (5). Por tanto, el Ministerio de Salud y de la Protección Social afirma que el país se encuentra en una etapa inestable debido a la pandemia por Covid-19, lo que ha disminuido las consultas en centros de salud y subdiagnosticado otros síndromes febriles como dengue (128).

El Departamento de Córdoba presenta características ambientales y climáticas que permiten la reproducción del *Aedes aegypti* (129, 130, 118), lo que sumado a factores sociales como el alto porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (35,08%) (131), el bajo logro educativo (75,5%) y las carencias en el sistema de suministro de agua potable (46,7%) (132); incrementa el riesgo de contraer la enfermedad, especialmente porque los programas educativos con los que se intenta prevenir y controlar el dengue son poco efectivos y no garantizan la participación de las comunidades en el desarrollo de estrategias contextualizadas y acorde a sus necesidades (133).

En este sentido, existen comunidades como los pueblos indígenas que cuentan con saberes ancestrales que pueden hacer frente a esta problemática. Tal es el caso del uso de algunas plantas y frutas como el limoncillo, la menta, el yarumo y la chilangua que previenen la picadura del mosquito (49), y el limón criollo, el mango y el guineo, para tratar los dolores ocasionados por el virus del dengue y Chikungunya (50). En este orden de ideas, esta estrategia convoca la mirada interdisciplinar y profunda de una problemática de salud pública priorizada en las agendas locales, nacionales e internacionales, pero dada su complejidad amerita nuevas formas de intervenirla.

OBJETIVOS

- Articular los saberes ancestrales con el conocimiento científico para la consolidación de una estrategia que responda las necesidades y particularidades de los territorios.
- Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de sus acciones en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
- Contribuir al empoderamiento de una comunidad del Resguardo Indígena Zenú como actor fundamental en la prevención del dengue.



¿DE DÓNDE PARTIMOS?

El trabajo de campo permitió conocer la articulación entre los saberes ancestrales y los conocimientos científicos y tecnológicos adoptados por los participantes en el proceso de prevención y control del dengue. Un primer aspecto a considerar es la movilización de dichos saberes a las prácticas familiares equivalentes a las formas tradicionales para contener la propagación del vector o las acciones empleadas para aliviar los síntomas.

A continuación, se expone la visión preliminar que sustenta esta estrategia:

Tabla 3. Prácticas para prevenir el dengue

Práctica	Descripción	Imágenes
Para el dengue prevenir el tanque debo cubrir	Tapar los tanques y recipientes de almacenamiento de agua, se constituye en una práctica muy importante para evitar la reproducción del vector <i>Aedes aegypti</i>. Algunas familias proponen no dejar agua almacenada en los tanques, si se llena se utiliza inmediatamente y luego se lava bien para evitar la proliferación del mosquito, tal como lo mencionó uno de los participantes: <i>“No eso no se deja, eso no, si se utiliza, se llena, se lava, se llena, luego se acabó el agua, se lavó ese tanque y vuelve cuando viene el agua otra vez” (E1).</i> En otros casos, la recomendación es tapar bien los tanques. Como puede observarse en la imagen, algunas familias utilizan láminas de zinc como tapas.	

Práctica	Descripción	Imágenes
<i>Mi tanque lavo y al mosquito acabo</i>	Realizar un correcto lavado de los tanques, hace parte de las medidas propuestas por el Ministerio de Salud y la Protección Social en Colombia para prevenir el dengue. Recomendación que se vincula con una de las prácticas mencionadas por algunos participantes del grupo de discusión, quienes aseguran utilizar cloro y cepillo para lavar sus tanques y de esta forma evitar que el dengue se propague; <i>“depende del día que este más vacío, ese día lo termino de chicar, lo lavo bien lavado, si es de comprar este límpido le echo límpido...y con cepillo”</i> (E3).	
<i>Agua que no has de usar, no la dejes estancar</i>	Eliminar los desechables y recipientes que pueden almacenar agua también se considera una práctica necesaria en la lucha contra el dengue. En este caso, algunos participantes del grupo de discusión aseguran no tener ningún recipiente lleno de agua en sus casas; <i>“No tengo chócoros llenos de agua”</i> (E2), mientras otros mencionan que los voltean para evitar que acumulen agua; <i>“bueno, yo no dejo tener la casa sucia, los frascos los que tengan agua que no sirvan eso yo los volteo, que se bote esa agua porque eso e’ que da eso”</i> (E1).	

Práctica	Descripción	Imágenes
Para el dengue evitar mi casa debo limpiar	Mantener una casa limpia es sinónimo de salud y bienestar para muchos participantes, barrer y botar la basura hace parte de las prácticas preventivas que más mencionaron a la hora de escuchar la palabra dengue; <i>“Uno tiene que barrer, botar la basura y quemarlas, así hago yo” (E1).</i> <i>“Tener todo limpio, no tener botellas ni nada en el patio, todo recogerlo y botarlo” (E5).</i> No obstante, uno de los problemas a los que se enfrentan a diario es la falta de un sistema de recolección de basura más eficiente, razón por la cual, en muchos casos se ven obligados a quemarla.	
Ahumando y ahuyentando	El humo que se produce al quemar algunos elementos como ramas de matarratón, hojas secas de almendro, cascarritas, entre otros, es utilizado en algunos casos como repelente para los mosquitos. Las respuestas de la mayoría de los participantes permitieron evidenciar que esta es una práctica bastante arraigada a la cultura Zenú, que se ha transmitido de generación en generación y que aún hoy en día permanece, a pesar de las múltiples opciones de repelentes e insecticidas que se encuentran en el mercado; <i>“Hojas al almendro seca, eso que Katori ni que Katori ni que” (E7).</i> El matarratón es una de las plantas más utilizadas por esta comunidad como repelente contra los mosquitos, en algunos casos se utilizan las ramas que estén más verde y se queman por toda la casa:	

Práctica	Descripción	Imágenes
	<i>“eso se le echa candela y se pone las ramas biches de matarratón, bueno eso, 10 a 20 minutos no se puede echar...Se echan en los cuartos, se abren las ventanas y se echan y esos mosquitos se salen...por ahí a las 7 de la noche” (E1).</i> En otros casos se hace una fogata de matarratón y moñinga de vaca; <i>“Ehhhh hago una fogata (...) con matarratón, con moñinga de vaca y eso los ahuyenta” (E6).</i>	

Fuente: Elaboración propia.

Prácticas para tratar los síntomas del dengue

Cuando se presentan casos de dengue en la comunidad, son muchas las respuestas que demuestran la multi cosmovisión de los participantes y la falta de una ruta de acción clara para tratar la enfermedad. Esta disparidad en las respuestas respecto a la actitud que se asume frente a la aparición de los síntomas del dengue y las prácticas más comunes empleadas, no hace más que reafirmar la necesidad de implementar una estrategia comunitaria que permita poner en diálogo estos saberes y fijar una directriz que defina los pasos a seguir ante la sospecha de dengue.

A continuación, se relacionan las principales posturas o visiones encontradas en los resultados:

Tabla 4. Principales visiones o posturas frente a un caso de dengue

Visión o Postura	Descripción
Ausente	A esta categoría pertenecen aquellos participantes que no consideran que el dengue sea un problema para sus comunidades, porque aseguran que ya casi no hay mosquitos o que no existen los principales focos de proliferación del vector, tal como lo demuestran algunas de sus respuestas: <i>“Casi no hay mosquito... No, a veces de noche hay unos mosquiticos...pero aquí no hay” (E1).</i> <i>“Bueno ya eso (mosquitos) por aquí no existe porque las quebradas que antes se encharcaba y</i>

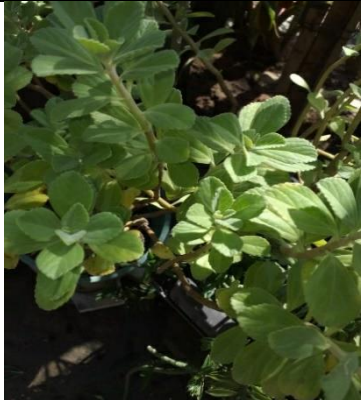
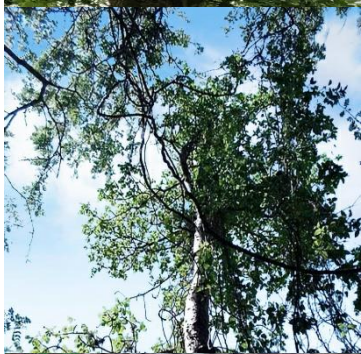
Visión o Postura	Descripción
	<i>hacían pozas en el mes de Marzo están secas... ya eso no existe ya” (E3).</i>
Ancestral	En cuanto a la visión ancestral, se encontraron respuestas que demuestran el uso de prácticas que han sido transmitidas de generación en generación, como es el caso de la quema de matarratón o la cascarilla para repeler los mosquitos: “Sí, eso ... todo el tiempo porque yo desde pequeña me acuerdo... ya desde que fui sabiendo ya oí mentando que la cascarilla servía para espantar los mosquitos... desde pequeñita ehh mis papás usaban eso” (E2).
Institucional	La visión o postura institucional es aquella que asumen algunas personas ante la aparición de los síntomas de cualquier enfermedad, esta consiste en tratar dichos síntomas en los centros de salud: “No, aquí nadie en ese extremo nadie favorece a otro, cada quien busca por su lado para donde el médico” (E3).
Autoridad indígena	La visión de los capitanes como autoridades indígenas encargadas de velar por el mantenimiento de la salud y el bienestar de todos los habitantes del cabildo, hace parte de las tendencias encontradas en las respuestas de los participantes; en muchos casos, la ruta a seguir es informar al capitán de la aparición o sospecha de casos de dengue, para que sea el encargado de implementar estrategias de prevención en la comunidad y llevar a los enfermos hacia los centros de salud más cercanos. Esto puede evidenciarse en la siguiente respuesta: “yo me enteré que ella (capitana) hizo como que alguna reunión y fue ese día no sé qué ella repartió toldos, pero para allá, ella para acá no... yo creo que es allá a la capitana y de ahí van al centro de San Andrés y hacen esas vueltas...” (E2).

Fuente: elaboración propia

En este orden de ideas, como parte de ese saber ancestral que aún conservan los indígenas Zenues para el tratamiento de algunos de los síntomas del dengue,

se encuentra el uso de plantas medicinales como las hojas de acetaminofén, el matarratón, el limoncillo, la balsamina, entre otras, cuyas principales características se describen en la siguiente tabla:

Tabla 5. Plantas medicinales para tratar los síntomas del dengue

Nombre común	Nombre científico	Usos para tratar el dengue	Imagen
Hojas de acetaminofén	<i>Plectranthus ornatus codd.</i>	Esta planta es comúnmente utilizada para el tratamiento de los síntomas del dengue, como la fiebre y el dolor de cabeza.	
Matarratón	<i>Gliricidia sepium</i>	Los baños de matarratón se utilizan para disminuir la fiebre.	
Indio encuero	<i>Bursera simaruba</i>	Esta planta es empleada para tratar picaduras de insectos y como baño para disminuir la fiebre.	
Balsamina	<i>Mordica charantia</i>	Tiene muchos usos como planta medicinal para el control de la diabetes y la alergia, también se utiliza para disminuir la fiebre.	

Nombre común	Nombre científico	Usos para tratar el dengue	Imagen
Hierba limón - Limoncillo	<i>(Lemongrass) Cymbopogon flexuosus</i>	Se emplea como repelente para mosquitos y para las picaduras de insectos.	
Altamisa	<i>Tanacetum parthenium</i>	Se utiliza en las comunidades indígenas para aliviar dolores articulares, disminuir la fiebre, tratar los dolores de cabeza y las picaduras de insectos.	

Fuente: Tomado de Beltrán y López (134)

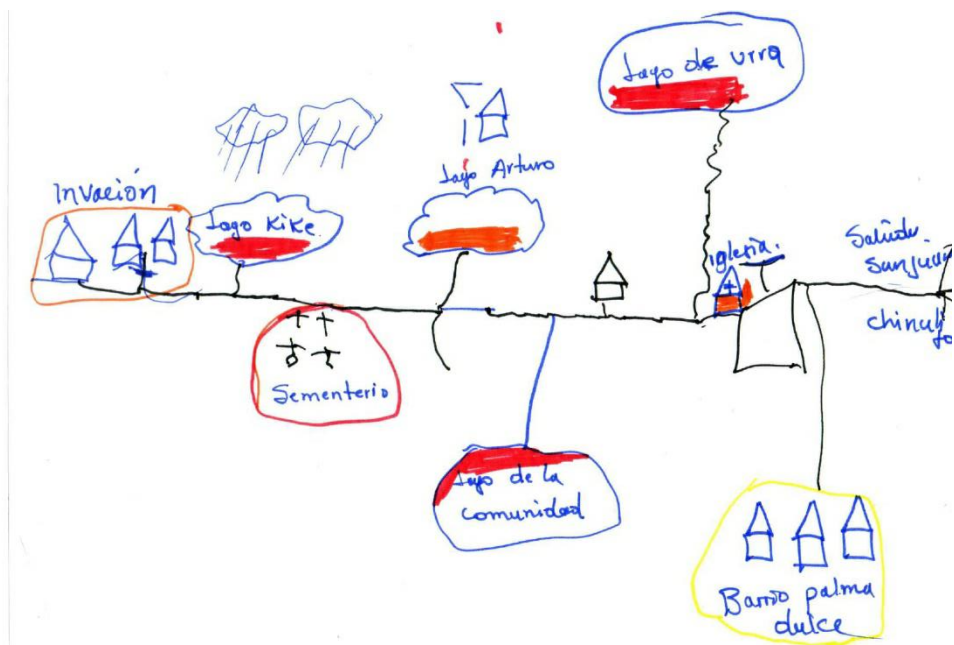
¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA?

La Estrategia Comunitaria para la prevención del dengue “Hojas de Almendro” se implementará a través de las siguientes fases:

1. Diagnóstico: Contempla la exploración del contexto mediante un proceso de observación de las realidades y prácticas que se desarrollan en torno a la prevención del dengue. En esta fase se realiza el reconocimiento de los posibles focos de proliferación del vector *Aedes aegypti* en la comunidad, tal como se evidencia en el siguiente mapa elaborado por los participantes del grupo focal que se desarrolló durante la investigación.

Figura 1. Mapa de los posibles focos de proliferación del mosquito *Aedes aegypti*

Fuente: Elaborado por los participantes del grupo focal.



2. Patrulla anti dengue: Durante esta fase se conforma la Patrulla anti dengue, integrada por un grupo de personas interesadas en fomentar la participación comunitaria para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. Para ello, el facilitador media el conocimiento científico y promueve su

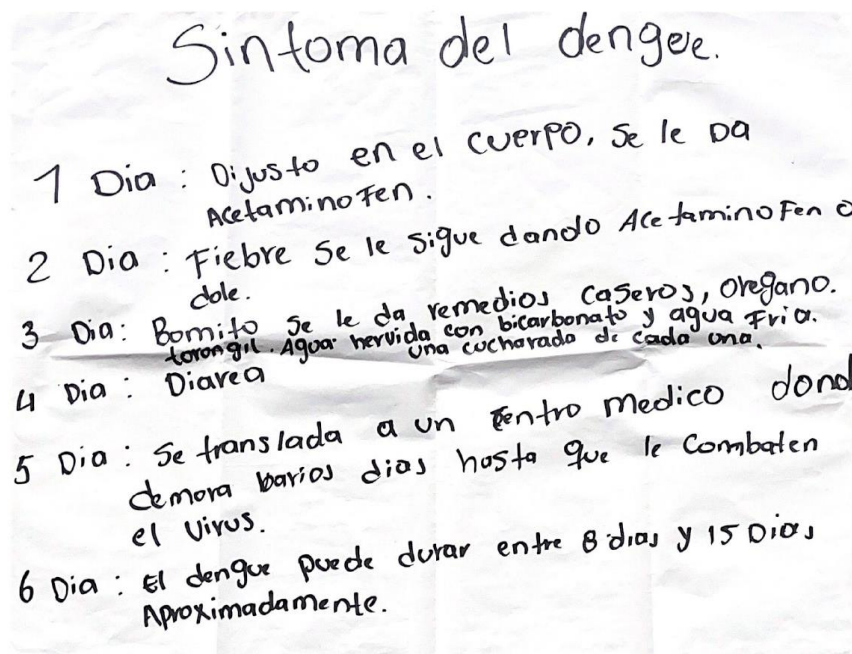
articulación con los saberes ancestrales que poseen los integrantes de la Patrulla anti dengue sobre el control y prevención de esta enfermedad.

Luego de esta fase, los patrulleros estarán en la capacidad de replicar lo aprendido, generando conciencia, sentido de pertenencia y conservación de lo que los identifica como pueblo indígena, especialmente aquellos conocimientos tradicionales que les permite tener una buena salud.

Adicionalmente, se deben identificar las debilidades y oportunidades con las que cuenta la comunidad para la promoción de la salud. Esto con el fin de proponer alternativas de solución y/o aprovechar esas fortalezas para la consolidación de una estrategia de prevención del dengue que se adapte a sus características particulares.

En esta fase se elabora una línea de tiempo, como la que se muestra a continuación, donde se represente la aparición de los síntomas del dengue día por día y su respectivo tratamiento, tomando en consideración la forma como los patrulleros tratan los casos de dengue en sus hogares. La Línea de tiempo se complementará con las recomendaciones médicas para estos casos y se incluirá en el vademécum comunitario, el cual se irá construyendo a medida que se implementa la estrategia.

Figura 2. Línea de tiempo síntomas del dengue



Fuente: Elaborado por los participantes del grupo focal.

3. Mesas participativas de discusión: A través de esta estrategia se busca que los participantes y toda la comunidad asuman una actitud más activa y propositiva frente a las acciones de prevención de las enfermedades que pueden realizarse desde el hogar, dejando de lado la idea que el control del vector que transmite el dengue solo es responsabilidad de los entes de salud y del Estado, y que no es posible controlarlo, tal como lo mencionaron algunos participantes de esta investigación:

"...Bueno para decir la verdad la prevención y eso no le veo como que mucho fundamento, porque aquí muy poco capacitan a la gente ni tampoco vienen a fumigar así que digamos como debe ser correcto ¿entiendes? ..."

"...Va permanecer siempre el dengue... a convivir con él más bien..."

"...La verdad, la verdad la veo mala porque por aquí no hay pa uno controlar el dengue, uno por aquí está al aire libre..."

Por esta razón, se propone implementar mesas participativas de discusión donde haya representación de las familias, la patrulla anti dengue, el facilitador y los diferentes sectores institucionales, de tal forma que se construya un escenario de compromisos frente a la situación problema, donde a partir del diagnóstico se puedan plantear posibles soluciones que tomen en consideración las debilidades y amenazas presentes en la comunidad, como por ejemplo, las deficiencias en el servicio de acueducto, alcantarillado y la recolección de las basuras, de tal forma que se trabaje de manera conjunta con las autoridades locales para realizar jornadas de limpieza en los barrios, eliminando así los posibles focos de proliferación del mosquito.

4.A replicar lo aprendido: durante esta fase, la patrulla anti dengue asumirá el rol de facilitadores y mediadores del conocimiento, replicando lo aprendido y construido en las primeras fases, para formar a las otras familias a través de talleres, charlas, perifoneo. Este proceso de sensibilización puede llevarse a cabo siguiendo los pasos propuestos por los participantes de la investigación:

Figura 3. Guía metodológica propuesta por los participantes de la investigación.

- ① Con un megafono se le informa a la comunidad que hay casos de dengue.
- ② Se le informa al capitán para reunir a la comunidad, para buscar estrategias para combatir el dengue.
- ③
 - a) Recolección de basuras
 - b) Limpiar los Pasos, tanques, y cascos abandonados
 - c) Acercarnos a secretaria de salud, para petición de fumigación y toldillos para las familias

Fuente: Elaborado por los participantes del grupo focal.

De igual forma, pueden realizarse talleres de elaboración de tapas para los tanques con material reciclado y reutilización de objetos que se encuentran en las viviendas, específicamente en los patios, como llantas, botellas, baldes, recipientes plásticos, a los que se les puede dar un segundo uso construyendo por ejemplo un parque para la comunidad.

5. Evaluación de la estrategia: La Estrategia Comunitaria “Hojas de Almendro” se encuentra en continua construcción, porque se va a ir consolidando a medida que se interactúa con los otros y se aprende de sus experiencias. Es por ello, que se propone una última fase de evaluación que sea un espacio donde se retroalimente los aciertos y los aspectos por mejorar luego de su implementación, de tal forma que esta estrategia pueda ser aplicada en otros contextos.

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El dengue es una enfermedad endémica con alta prevalencia en diversas regiones del mundo, como es el caso de Colombia (1). Los impactos de esta enfermedad van más allá de las afectaciones a la salud humana, teniendo incidencia en las condiciones socioeconómicas de los pueblos e impactando el funcionamiento de los sistemas de salud. En ese sentido, preguntarse por los mecanismos y estrategias para la prevención del dengue, es una cuestión totalmente válida y pertinente para mejorar la calidad de vida de los sujetos.

En relación a los resultados obtenidos para la categoría condiciones individuales, familiares, comunitarias y espaciales del contexto de estudio, se encuentra concordancia con los hallazgos de otras investigaciones donde prevaleció la representación femenina, cuya ocupación principal era ser ama de casa, aspecto posiblemente asociado con creencias culturales donde la información sobre la vivienda, salud de la familia y cuidados generales del hogar en relación al dengue, son suministrados por las mujeres al asociarlas con un rol de cuidadoras del hogar (135, 136).

Por otra parte, el nivel de escolaridad de los participantes del presente estudio coincide con otras investigaciones donde osciló entre analfabetismo y educación primaria completa, mientras que los participantes con formación profesional o posgradual fueron mínimos (137-139). Lo anterior se relaciona con otros aspectos como los ingresos económicos reportados por los participantes y las limitantes que a nivel contextual existen para que estos puedan acceder a centros de educación técnica, tecnológica o superior, lo cual permitiría potenciar sus capacidades y dotarles de herramientas que resulten efectivas para la prevención del dengue en su familia y comunidad.

En cuanto a la composición familiar, en la presente investigación se obtuvo que la media de habitantes por vivienda fue de 5 personas y entre 1 y 2 familias por vivienda, resultado que difiere un poco de lo obtenido por Chuc y otros, donde el número de personas por vivienda fue de 4, con estos investigadores también se difiere en la vinculación al servicio de salud; en el presente estudio todos los participantes se encuentran afiliados al sistema de salud principalmente bajo la categoría de subsidiados, sin embargo, en Chuc y otros, solo el 70% de los participantes tuvo afiliación al servicio de salud (136). Se resalta que, en una investigación realizada en Casanare, Colombia por Castañeda y Zuleta en un 97% de los participantes pertenecían al régimen subsidiado (137).

Los resultados arrojados para la subcategoría de condiciones ambientales permiten dimensionar las condiciones de vida desiguales en las que se desenvuelven los sujetos en relación al acceso a servicios básicos domiciliarios como el agua potable y la recolección de basuras, punto de coincidencia con hallazgos reportados en múltiples investigaciones desarrolladas sobre prevalencia del dengue, como es el caso de Martínez et al, en Venezuela donde las comunidades de dos barrios tenían acceso irregular a agua potable y no contaban con el servicio de recolección de basuras (135). Lo anterior, conlleva a la necesidad de almacenar agua potable en diferentes recipientes para poder abastecerse en los periodos en que no se cuenta con este servicio, tal como se ha documentado por autores como Niño, Yong y Díaz, quienes determinaron que un 73% las personas almacenaban agua para su consumo, depositada principalmente en baldes y tanques, situación que también es concordante con los resultados obtenidos en otra región de Venezuela por Flórez et al (139, 140).

En el Estado de Morelos en México, también se evidenció que el no acceso continuo a agua potable conlleva a que en un 70% existen en las viviendas almacenamiento de agua en recipientes destapados, ubicados principalmente en el patio de estas quedando expuestos a condiciones climáticas y ambientales propicias para la proliferación del vector que transmite el dengue (136). En el departamento de Córdoba también se tiene evidencia de comunidades que no cuentan con acceso a agua potable y deben almacenar esta en diferentes recipientes como albercas, tanques, y baldes (138).

Los datos obtenidos sobre el acceso y disposición del agua potable, más allá de mostrar las desigualdades sociales en que viven millones de familias alrededor del mundo, sirven para entender que existe una relación entre dichas condiciones y la prevalencia del dengue a nivel comunitario, afirmación respaldada y validada por los autores citados previamente, quienes concuerdan en enfatizar que almacenar agua y no tomar las medidas de limpieza necesarias de estos contenedores, constituye una amplitud del margen de exposición para ser picado por el *Aedes Aegypti* y por ende desarrollar la enfermedad del dengue. Sumado a lo anterior, la desconexión entre la afirmación realizada por los participantes de la investigación en relación a saber que es el dengue y la forma en que profundizaron su definición, muestra que existe una gran brecha y desafíos por afrontar de cara a la educación comunitaria para la prevención de esta enfermedad, partiendo por supuesto, de las creencias y las dinámicas contextuales. En ese sentido la revisión de la literatura permite evidenciar que hay coincidencias en dicha dinámica incongruente entre lo que se cree saber y lo que en verdad implica el dengue (137). Por ejemplo, Soto encontró en una investigación realizada en Chiclayo Perú, que la gran mayoría de los participantes desconocían lo que era el dengue, factores asociados y

mecanismos de transmisión pese a ser una región endémica con alta difusión mediática de recomendaciones y medidas preventivas para esta enfermedad (141). También hay coincidencia con Benítez y otros, quienes obtuvieron en su investigación que menos del 40% de los encuestados sabía que el nombre del mosquito es *Aedes aegypti* y que se identifica por las franjas blancas en sus patas (142).

Además, hay concordancia con la información asociada a la transmisión del dengue; los participantes identifican que es produce por la picadura de un mosquito, sin embargo, no reconocen los aspectos más relevantes del vector, por lo que puede confundirse con otro tipo de mosquitos, concordando con lo obtenido en otros estudios donde el 75% de los participantes reconoció que el dengue se contrae por la picadura de un zancudo que se reproduce en aguas estancadas (149). Dichas nociones básicas también se vieron reflejadas en los conocimientos que manifiestan poseer los participantes del estudio en relación a los síntomas posiblemente asociados con el dengue, de lo cual la fiebre, vómito, cefalea y diarrea constituyen el cuadro sintomatológico de mayor prevalencia según los participantes. Al respecto, Souza y otros también evidenciaron que la fiebre es el síntoma que mayor refieren las personas estar asociado con el dengue, situación que puede confundirse con otras patologías por lo cual, se requiere afianzar este conocimiento empírico que poseen los actores comunitarios participantes, constituyendo uno de los principales desafíos a afrontar con la creación y puesta en marcha de la estrategia diseñada (149).

A partir de lo expuesto, puede afirmarse que existe un reconocimiento de algunos conceptos y términos médicos o científicos asociados con el dengue, pero desafortunadamente los participantes no tienen claro lo que ello verdaderamente implica, obstaculizando la reacción oportuna ante un posible caso sospechoso de dengue (143, 138). Por lo expuesto, se coincide con Santos y otros, al afirmar que pese a ser el dengue una enfermedad endémica en Colombia, persisten en territorios y comunidades considerables vacíos relacionados con el manejo oportuno de esta enfermedad (144).

Otro aspecto clave a discutir y que se tuvo presente en la construcción de la estrategia diseñada a partir de la presente investigación, es la actitud pasiva y negativa que la mayoría de los participantes reporta frente a la prevención, control o posible erradicación del dengue en su comunidad, por cuanto son actitudes que limitan el empoderamiento de los sujetos y su vinculación activa al desarrollo de acciones continuas que tributen a tal fin. Lo anterior se relaciona con los resultados mostrados por Souza et al, y Benítez et al, donde se delegaba la responsabilidad a los entes gubernamentales de hacer frente al dengue y los factores asociados a esta enfermedad, lo cual en términos de los autores se

podría entender como un discurso de acusación (142, 143). Lo anterior se puede interpretar como actitudes negativas para el logro de una comunidad saludable, si se considera que en términos de la estrategia COMBI de la OMS, son los miembros de la comunidad quienes están llamados a actuar partiendo de la identificación de los factores de riesgo y así poder gestionar ante los entes competentes e incluso la comunidad misma, los recursos y acciones necesarias para contrarrestar dichos factores de riesgo, por ello, la estrategia aquí propuesta se estructuró bajo una lógica integrativa multisectorial para dar una respuesta efectiva e integral al problema en cuestión (145).

De las prácticas adoptadas por las comunidades para la prevención de la enfermedad, hay concordancia con la literatura revisada en cuanto al aseo general de la casa, la limpieza de los tanques, uso de repelente y fumigar con productos químicos ampliamente comercializados, sin embargo, el uso de prácticas alternativas que vinculen saberes ancestrales fue mínimo en las investigaciones encontradas (142, 139, 135). De lo anterior se exceptúa la investigación de Gaviria y Humánez donde se encontró uso de plantas y recursos naturales cuyo uso ha sido heredado de manera ancestral al interior de la etnia Embera Katio a la cual pertenecen (138). A su vez, en la investigación adelantada por Barruz se pone de manifiesto la efectividad de las plantas para tratar aspectos medicinales y en el caso concreto del dengue el uso principal de plantas de la familia *Fabaceae*, a la cual pertenece el “matarratón” del cual se refirieron los participantes del presente estudio al decir que usaban el humo emanado de la quema de hojas de esta planta para evitar el contacto con el vector transmisor del dengue (146).

Es importante destacar que en otras investigaciones resaltó el hecho que al interior de las familias y comunidades no se estuviera aplicando ninguna medida para la prevención de esta enfermedad o que su uso fuera mínimo pese a ser regiones endémicas y comunidades con formación previa al respecto (137) (141).

Lo anterior evidencia que conocer o recibir información específica sobre el dengue no necesariamente constituye la materialización de acciones efectivas que pongan en práctica lo aprendido, lo cual puede estar relacionado al tipo de enfoque metodológico empleado en el proceso de formación de la comunidad. En ese sentido, se deben construir estrategias que fomenten el empoderamiento de los actores comunitarios para que así se obtengan conocimientos y procesos sostenibles en el tiempo, tal como fue el propósito de la presente investigación.

Para finalizar con las prácticas, se destaca el hecho de confiar en el sistema de salud al llevar de manera inmediata a una persona que manifiesta sintomatología

asociada con dengue, pese a ser un aspecto positivo, es necesario precisar los tiempos transcurridos entre el surgimiento de los síntomas y el ingreso al centro médico, porque una atención oportuna es decisiva para la salud del paciente y la superación de la enfermedad en cuestión. Se destaca que la predominancia de esta práctica también se reportó en una comunidad Wayú en el departamento de la Guajira con una prevalencia del 97% (142).

Partiendo de la revisión y contraste con literatura existente, se puede afirmar que las estrategias que se diseñan para hacer control al dengue y que poseen una estructuración vertical han resultado ser ineficientes debido a que acuden a métodos descontextualizados que no permiten que los actores comunitarios se apropien y empoderen de esta tarea (147). Por su parte, estrategias como la diseñada en Yopal por Criollo, Bernal y Castañeda que estuvo diseñada bajo una lógica de movilización social y empoderamiento comunitario, demostró tener una alta efectividad al aumentar el nivel de conocimientos al interior de la comunidad y evaluar las prácticas desarrolladas para la prevención del dengue, a partir de pruebas posteriores a la implementación de la estrategia (148).

En concordancia, el logro del objetivo de la presente investigación permite nutrir esa línea de trabajo que ha venido repensando el accionar de la salud familiar y comunitaria, promoviendo el empoderamiento y participación activa de los diferentes actores desde una perspectiva integrativa y multidimensional que parta de los saberes y prácticas tradicionales. Cabe resaltar que no se puede medir la efectividad de la estrategia diseñada debido a que ese no fue el propósito del presente estudio, siendo el tiempo disponible una de las principales limitantes, por lo que se propone su validación en futuras investigaciones.

6. CONCLUSIONES

La construcción de la estrategia comunitaria para la prevención del dengue resultante de la presente investigación, parte de las condiciones de vida y del contexto en el que se desenvuelven los participantes, miembros en su mayoría de la etnia Zenú del municipio de San Andrés de Sotavento en el Departamento de Córdoba. Esta población carece de acceso a servicios domiciliarios como agua potable y recolección de residuos sólidos domésticos, factores que se relacionan con la creación de condiciones ambientales propicias para la proliferación de criaderos del vector *Aedes Aegypti*. Las condiciones individuales y familiares de los participantes mostraron que en su mayoría son mujeres, amas de casa o vinculadas con actividades laborales del sector informal de la economía, por ello, sus ingresos económicos mensuales son inferiores a un salario mínimo. A su vez, las condiciones sociales de los participantes, puso de manifiesto que poseen un bajo nivel de formación académica y están afiliados al régimen de salud bajo la categoría de subsidiados.

Las condiciones descritas anteriormente, son entendidas como factores de riesgo que pueden llegar a aumentar la probabilidad de adquirir la enfermedad del dengue, por ende, cualquier política, programa o estrategia diseñada para contrarrestar los impactos de esta enfermedad, no se puede plantear a espaldas de las condiciones estructurales de cada grupo poblacional.

Por otra parte, se evidenció que existe una brecha entre lo que afirman saber los participantes con la verdadera dinámica y significado del dengue en todas sus etapas, situación que debe tomarse como referente para delimitar y estructurar las acciones a implementar, porque no se trata de negar las experiencias y trayectorias de vida de los sujetos y los conocimientos que eso les ha generado, por el contrario, el resultado final reflejado en la estrategia aquí mostrada, muestra una metodología que confiere un rol activo y protagónico a los actores comunitarios tomando como punto de partida lo que saben bien sea acertado o errado, para así subsanar los vacíos o incongruencias que hayan a través de la conciliación entre el conocimiento popular y el conocimiento científico brindado por la salud pública.

Los resultados mostraron que los participantes tienen arraigadas actitudes que, de no ser intervenidas oportunamente, constituirán un obstáculo para la implementación de cualquier tipo de estrategia o medida. Estas actitudes se fundamentan en ser pasivo y/o pesimista ante el control del vector *Aedes Aegypti* y del dengue como enfermedad prevalente en la comunidad. Se destaca que los participantes han asumido un discurso acusatorio y delegatorio, representando en afirmaciones que muestran la espera de acciones acaecidas desde las entidades institucionales en función de la prevención del dengue.

Por otra parte, las prácticas que han adoptado los actores participantes a nivel individual y familiar evidenciaron una articulación entre prácticas heredadas ancestralmente como la quema de plantas típicas o el excremento de las vacas, así mismo, las personas usan técnicas de fumigación con productos procesados de manera química que son ampliamente conocidos a nivel comercial como la creolina, naftalina, ACPM, Lorsban o baygón. También se registró el uso de técnicas más primitivas como el “ventear” o sacudir la casa con un trapo para expulsar el mosquito y otras prácticas como el cerrado de puertas y ventanas en horario donde mayormente hay mosquito. Lo anterior plantea la articulación entre lo moderno y lo tradicional, relación que ampliamente se ha documentado como opuestas entre sí, pero que desde la perspectiva de la presente investigación resultan complementarias, aspecto que conllevó a su consideración en el diseño y planificación de la estrategia.

En esa misma línea, se muestran pequeños bosquejos de deseo de los actores comunitarios de desarrollar un trabajo organizado y articulado a nivel comunitario que vincule el accionar colectivo en función de la prevención de la enfermedad y la creación de entornos saludables. Ese aspecto se toma como primordial a fortalecer a través de la implementación de la estrategia, teniendo en cuenta que en el empoderamiento colectivo propicia y potencializa gran parte del cambio y transformación de las realidades poco favorables vigentes hasta la fecha.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que la estrategia creada rompe con las concepciones tradicionales de pensar las estrategias de intervención en salud familiar y comunitaria desde una perspectiva biomédica, donde las comunidades son solo receptoras de la información y no participan activamente en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Esta estrategia en cambio, no se concibe como algo perfecto o terminado, sino que está en retroalimentación continua de los actores y comunidad en general con la cual se interactúa. La estructuración de la estrategia desde un enfoque territorial y diferencial étnico, permitió apreciar esas particularidades que poseen los actores comunitarios participantes para crear una estrategia que rescate y preserve la riqueza en términos de saberes que poseen los actores y que se materializa en la consolidación de redes de trabajo horizontales no hegemónicas y no absolutas.

Es necesario realizar una segunda fase de este estudio y materializarlo en una segunda investigación que permita evaluar los resultados obtenidos de la implementación de la estrategia aquí diseñada, para validar su aplicación en otros contextos y su enriquecimiento continuo.

7. RECOMENDACIONES

A las instituciones gubernamentales a nivel nacional y departamental con competencias en el sector salud:

- Fundamentados en los resultados aquí obtenidos, se requiere diseñar o rediseñar las estrategias vigentes para la prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores para que atiendan a las realidades contextuales y a las necesidades que aquí se han puesto de manifiesto.
- Por otra parte, se orienta a dar un cambio en la visión en que se soporta el diseño de este tipo de estrategias, renunciando a la visión hegemónica, vertical y positivista, por nuevas perspectivas emergentes de ver y entender este tipo de problemáticas para la salud pública.

A la Universidad de Córdoba y la Maestría en Salud Pública:

- Fomentar el desarrollo de investigaciones que propendan por la identificación de la riqueza ancestral expresada en conocimientos y prácticas que permitan la prevención del dengue y otras ETV, ~~y que~~ contribuyan a la salud de las comunidades desde un enfoque multicultural, diferencial étnico y territorial.

A la dirección Local de Salud del municipio de San Andrés de Sotavento:

- Crear las condiciones necesarias para la implementación de la estrategia diseñada en procura del empoderamiento comunitario y el llamado a la acción colectiva a partir de las experiencias y potencialidades locales.

A los actores comunitarios y familias del municipio de San Andrés de Sotavento:

- Se recomienda a las familias y actores comunitarios en general, el desarrollo de acciones individuales y colectivas que propendan por la prevención del dengue a nivel territorial haciendo uso de sus conocimientos y prácticas ancestrales.
- Se espera la participación activa de las familias y comunidades en la implementación y retroalimentación continua de la estrategia diseñada.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud. Dengue y dengue grave [internet]. [Consultado 20 feb 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>
- [2] Dick O, et al. The history of dengue outbreaks in the Americas. *The Ame jour of trop med and hyg.* 2012; 87 (4): 584-593.
- [3] Organización Panamericana de la Salud. Dengue [internet]. [consultado 20 feb 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue.html>
- [4] Mendoza M, Rodríguez A, Penilla R, Vázquez M. Compatibilidad de hongos entomopatógenos e insecticidas organofosforados para el control de *Aedes aegypti* (DIPTERA: CULICIDAE). *Ento Mex.* 2015 [consultado 20 feb 2021]; 2: 229-234.
- [5] Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal: Semana epidemiológica 52. 2020. [consultado 21 feb 2021]. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019_Boletin_epidemiologico_semana_52.pdf
- [6] Instituto Nacional de Salud. Informe de Evento: Dengue. INS: Bogotá; 2021. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Informesdeevento/DENGUE%20PE%20XII%202021.pdf>
- [7] Canals M, González C, Canals A, Figueroa D. Epidemiological dynamics of Dengue on Easter Island. *Rev chil de infe.* 2012 [consultado 22 feb 2021]; 29(4):388-394.
- [8] Colombia. Departamento de Córdoba. y Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIA. Plan y acuerdo estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación. [Consultado 23 feb 2021]. Disponible en: <http://repositorio.colciencias.gov.co/bitstream/handle/11146/34051/59%20Planes%20estrategicos%20Dptls%20paed-cordoba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [9] Bacallao G, Quintana O. Dengue. Revisión bibliográfica. *Acta Médica del Centro.* 2015; 7(1): 10-22. Disponible en: <http://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/106>

- [10] Organización Panamericana de la Salud. PLISA Plataforma de Información en Salud para las Américas. Casos reportados en las Américas. [internet]. [consultado 21 feb 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html>
- [11] Colombia. Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal: Semana epidemiológica 52. 2020. [consultado 21 feb 2021]. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019_Boletin_epidemiologico_semana_52.pdf
- [12] Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Plan de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad. [Consultado 23 feb 2021]. Disponible en: <https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx>
- [13] Bock G, Goode J. A. New Treatment Strategies for Dengue and Other Flaviviral Diseases. 2006: 277.
- [14] Gubler D, et al. Dengue and dengue hemorrhagic fever. 2014. CABI.
- [15] Dick O, et al. The history of dengue outbreaks in the Americas. The Ame jour of trop med and hyg. 2012; 87 (4): 584-593.
- [16] Lugones M, Ramírez M. Dengue. Rev Cub de Med Gen Int. 2012; 28 (1): 123-126. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000100015&lng=es&tlng=es.
- [17] Rudnick, A. Ecology of dengue virus. Asi Jour Infe Des. 1978; 2: 156-160.
- [18] Organización Panamericana de la Salud. La historia del dengue y el dengue hemorrágico en la región de las Américas, 1635-2001. 2001. [Consultado 09 de febrero de 2021]. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34859/OPSCHA17039_spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y
- [19] Smith C. The history of dengue in tropical Asia and its probable relationship to the mosquito *Aedes aegypti*. Jour of Trop Med and Hyg. 1956; 59 (10): 243-51

- [20] Gubler D. Dengue and dengue hemorrhagic fever in the Americas. Monograph on dengue/dengue hemorrhagic fever. WHO regional publication SEARO. 1993; 22: 9-22.
- [21] Kuno, G. Emergence of the severe syndrome and mortality associated with dengue and dengue-like illness: historical records (1890 to 1950) and their compatibility with current hypotheses on the shift of disease manifestation. Clinical microbiology reviews. 2009; 22 (2): 186-201.
- [22] Sabin, A. Research on dengue during World War II. Ame jour of trop Med and Hyg. 1952; 1 (1): 30-50.
- [23] Organización Panamericana de la Salud. PLISA Plataforma de Información en Salud para las Américas. Fiebre por dengue en las Américas. [internet]. [consultado 21 feb 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html?start=2>
- [24] Bock G, Goode J. A. New Treatment Strategies for Dengue and Other Flaviviral Diseases. 2006: 277.
- [25] Pan American Sanitary Bureau. Dengue y dengue hemorrágico en las Américas: guías para su prevención y control. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 1995: 109. Disponible en: <https://apps.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/index.html>
- [26] Reed W, et al. The etiology of yellow fever—a preliminary note. Pub hea pap and rep. 1900; 26: 37.
- [27] Finlay C. El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla. Sal Púb de Méx. 1992; 34(4): 474-483.
- [28] Organización Panamericana de la Salud. Declaración de Alma-Ata. Acta de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud; 1978 sept 6-12; Alma-Ata URSS.
- [29] Organización Mundial de la Salud. Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Acta de la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud; 1986 nov 18-21; Ottawa Canadá.
- [30] Lazcano-Ortiz M, Flores-León C, Flores-Ramírez A, Ruíz-Herrera JC, Tolentino-Gallegos CJ, Arias-Rico J, Sánchez-Padilla ML. Factores

condicionantes básicos y autocuidado en adultos con DM2. Boletín ICSa [Internet]. 2017 [Consultado 09 marzo de 2019]; 6(11). Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSa/article/view/2704>

[31] Organización Panamericana de la Salud. Sistematización de lecciones aprendidas en proyectos COMBI en dengue en la región de las Américas [Internet]. [Consultado 21 feb 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Sistematizacion-lecciones-aprendidas-COMBI.pdf>

[31] Organización Mundial de la Salud. Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas. Acta de la Reunión Internacional sobre la Salud en Todas las Políticas; 2010; Adelaida.

[33] Organización Mundial de la Salud. Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI. Acta de Cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud; 1997; Yakarta Indonesia.

[34] División de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes en los registros de salud. 2013. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/35952/S20131049_es.pdf

[35] Organización Panamericana de la Salud. Fortalecimiento y Desarrollo de los Sistemas de Salud Tradicionales. 1997. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/10-Esp%20IND6.pdf>

[36] Organización Panamericana de la Salud. Armonización de los Sistemas de Salud Indígenas y el Sistema de Salud Convencional en las Américas. 2002. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/49-Esp%20IND24.pdf>

[37] Pereyra-Elías R, Fuentes-Delgado D. Medicina Tradicional versus Medicina Científica ¿En verdad somos tan diferentes en lo esencial? Acta Méd. peruana [Internet]. 2012 [consultado 17 mar 2021]; 29(2): 62-63. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172012000200002&lng=es

[38] Álvarez-Ruiz A. Interculturalidad: conceptos, alcances y derecho. México: Centro de Producción Editorial del GPPRD. 2014; [Consultado 16 mar 2021]. Disponible en: <https://rm.coe.int/1680301bc3>

[39] Cardona-Arias J, Rivera-Palomino Y, Carmona-Fonseca J. Expresión de la interculturalidad en salud en un pueblo emberá-chamí de Colombia. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2015 [consultado 16 mar]; 41(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000100008&lng=es.

[40] Trinidad-Santos E, Angel-Vargas L, Chad-Pellón LH. La Interculturalidad en el mundo globalizado y sus impactos en el proceso salud-enfermedad: contribuciones de la Enfermería. Index enferm. 2013;22(4):214–8.

[41] Naciones Unidas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU destaca los desafíos de salud que afrontan. [Internet]. 2015 [consultado 16 mar 2021]. Disponible en: <https://www.un.org/development/desa/es/news/social/indigenous-peoples.html>

[42] Organización Panamericana de la salud. Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas [internet]. Washington: OPS; 2008 [consultado 16 mar 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/54-VisionSaludInterculturalPI.pdf>

[43] Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1954 de 2014. Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución, (2014)

[44] Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 [internet]. Hong Kong: OMS; 2013 [consultado 16 mar 2021]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=B10744734A437A37D1111597F99BF82C?sequence=1#:~:text=La%20estrategia%20de%20la%20OMS,la%20autonom%C3%ADa%20de%20los%20pacientes

[45] Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos técnicos para la articulación de las medicinas y las terapias alternativas y complementarias, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2018 [consultado 16 mar 2021]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/lineamientos-mtac-sgsss.pdf>

- [46] Cardona-Arias J. Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. Rev. salud pública [Internet]. 2012 [consultado 16 mar 2021]; 14(4): 630-643. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642012000400008&lng=en
- [47] Organización Panamericana de la Salud. Política sobre etnicidad y salud. 69ª Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington: 2017. Disponible en: <file:///C:/Users/Dell/Downloads/ethnicityhealth-policy-2017-es.pdf>
- [48] Azcona, M. Acerca de la investigación del proceso salud/enfermedad/atención en la población indígena de la Argentina. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural. 2019; 37: 1-13. Disponible en: <http://rehip.unr.edu.ar/handle/2133/15857>
- [49] Garzón L. Conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales de yarumo (*Cecropia Sciadophylla*), carambolo (*Averrhoa Carambola*) y uña de gato (*Uncaria Tomentosa*) en el resguardo indígena de Macedonia, Amazonas. Luna Azul [Internet]. 2016 [consultado 16 mar 2021]; (43): 386-414. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742016000200017&lng=en
- [50] Velásquez-Serra, G, et al. Los Chachis: cosmovisión ancestral con la evidencia científica en la prevención y control del dengue. Rev de Inv Tal. 2017; 4 (2): 63-69. Disponible en: <https://talentos.ueb.edu.ec/index.php/talentos/article/view/20>
- [51] Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia en salud pública dengue. 2017 [consultado 17 mar 2021]. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/Noticias/Dengue/7.%20Dengue%20PROTOCOLO.pdf>
- [52] Organización Panamericana de la Salud, Ministerio para la Protección Social, Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia y control de dengue. Disponible en: https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=1216-protocolo-para-la-vigilancia-en-salud-publica-del-dengue&Itemid=688
- [53] Organización Panamericana de Salud. Diagnóstico y manejo clínico de casos de dengue [internet]. 2013 [consultado 17 mar 2021]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3467/Guia_bolsillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[54] Rodríguez M, Bisset J, Hurtado D, Montada D, Leyva M, Castex M, et al. Situation of resistance to insecticides in *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) from Pinar del Rio municipality. *Revista Cubana de Medicina Tropical*. 2016. 68(2), 125-135.

[55] Organización Panamericana de la Salud. Módulo de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades. 2011. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informacao-e-analise-saude-096&alias=1269-modulos-principios-epidemiologia-para-control-enfermedades-mopece-unidad-1-presentacion-marco-conceptual-9&Itemid=965

[55] Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento para la gestión y operación del Programa de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis y otras consideraciones para la ejecución de sus transferencias nacionales de funcionamiento [internet]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/lineamientos-gestion-programa-transferencias-etvzoonosis-2020.pdf>

[56] Bellinato D, Viana P, Araújo S, Martins A, Lima J, Valle D. Resistance status to the insecticides temephos, deltamethrin, and diflubenzuron in Brazilian *Aedes aegypti* populations. *BioMed research international*. 2016.

[57] Aguirre O, Duarte I, Álvarez J, Jiménez J. Actividad larvica de extractos vegetales de la familia Asteraceae y modelación matemática para su uso en el control de poblaciones de *Aedes aegypti*. *Actu Biol [Internet]*. 2018 [consultado 21 abr 2021]; 40(108): 5-16. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-35842018000100005&lng=pt. <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v40n108a01>

[58] Pérez I, Mejía S. Evaluación del efecto larvica del extracto etanólico de *Ocimum Basilicum* (Albahaca) sobre larvas de cuarto (4) estadio de *Aedes Aegypti* en condiciones de laboratorio.

[59] Mesa A, Naranjo J, Diez A, Ocampo O, Monsalve Z. Actividad antibacterial y larvica sobre *Aedes aegypti* L. de extractos de *Ambrosia peruviana* Willd (Altamisa). *Rev cubana Plant Med [Internet]*. 2017 [consultado 31 mar 2021]; 22(1): 1-11. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962017000100011&lng=es

- [60] Agrela I, Hidalgo Y, Herrera F. Efecto larvicide de extractos metanólicos obtenidos de semillas y hojas de *Persea americana* (Laurales: Lauraceae) (aguacate) sobre *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). *Bol Mal Salud Amb* [Internet]. 2014 [consultado 31 mar 2021]; 54(2): 199-207. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-46482014000200009&lng=es.
- [61] Cruz M. Instituto nacional de salud pública. centro regional de investigación en salud pública. 2016. Disponible en: <https://catalogoinsp.mx/files/tes/055157.pdf>
- [62] Sawyers R, Sawyers R, Pinto A. Papel de la bacteria endosimbionte *Wolbachia* en el control de enfermedades vectoriales: dengue, zika y chikunkunya. *Acta Médica Costarricense*. 2017; 59(4): 130-133.
- [63] Azevedo V, Vitule J, Pelicice F, García E, Simberloff D. Nonnative fish to control *Aedes* mosquitoes: a controversial, harmful tool. *BioScience*. 2017; 67(1): 84-90.
- [64] Morales A, Nava E, Legorreta J, Cortés A, Balanzar A, Harris E, Ledogar R. "Where we put little fish in the water there are no mosquitoes:" a cross-sectional study on biological control of the *Aedes aegypti* vector in 90 coastal-region communities of Guerrero, Mexico. *BMC public health*. 2017; 17(1): 433.
- [65] Harapan H, Rajamoorthy Y, Anwar S, Bustamam A, Radiansyah A, Angraini P, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding dengue virus infection among inhabitants of Aceh, Indonesia: a cross-sectional study. *BMC infectious diseases*. 2018; 18(1): 96.
- [66] Ortiz C, Rúa G, Rojas C. Conocimientos, prácticas y aspectos entomológicos del dengue en Medellín, Colombia: un estudio comparativo entre barrios con alta y baja incidencia. *Biomédica*. 2018; 38(2):106-116. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=843/84359091014>
- [67] Kumaran E, Doum D, Keo V, Sokha L, Sam B, Chan V, et al. Dengue knowledge, attitudes and practices and their impact on community-based vector control in rural Cambodia. *PLoS neglected tropical diseases*. 2018; 12(2): 62-68.
- [68] Diaz F, Martínez R, Rodríguez A, Rojas R, Luna M, Díaz R. Association between the level of education and knowledge, attitudes and practices regarding dengue in the Caribbean region of Colombia. *BMC public Health*. 2018; 18(1): 143.

[69] Alves A, Fabbro A, Passos A, Carneiro A, Martinez E. Knowledge and practices related to dengue and its vector: a community-based study from Southeast Brazil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 2016; 49(2): 222-226.

[70] Benítez L, Díaz F, Martínez R. Experiencia y percepción del riesgo asociados a conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en Riohacha, Colombia. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2020; 25: 1137-1146.

[71] Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue en la región de las Américas [internet]. [consultado 18 mar 2021]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34859/OPSCHA17039_spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y

[72] Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones y recomendaciones para la inclusión del enfoque diferencial étnico en la atención integral en salud, con pertinencia cultural. 2015. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Anexo-tecnico-pertinencia-cultural.pdf>

[73] Cuartas E, Palacio A, Ríos L, Cardona J, Salas W. Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre sostenibilidad en estudiantes de una universidad pública colombiana. *rev.udcaactual.divulg.cient.* [Internet]. 2019 [consultado 2021 Mar 31]; 22(2): 13-85. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262019000200026&lng=en.

[74] ONU. Guía metodológica para el diseño y aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre acceso a recursos genéticos y participación en beneficios (APB). 2020. Disponible en: https://community.abs-sustainabledevelopment.net/wp-content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-Metodol%C3%B3gica-de-Encuestas-CAP-KAP22072020ALC_organized.pdf

[75] Andrade C, Menon V, Ameen S, Kumar S. Designing and Conducting Knowledge, Attitude, and Practice Surveys in Psychiatry: Practical Guidance. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2020; 42 (5). Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0253717620946111>

[76] Organización Mundial de la Salud. Knowledge, Attitudes, And Practices (KAP) Surveys during Cholera Vaccination Campaigns: Guidance for Oral

Cholera Vaccine Stockpile Campaigns."Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014.

[77] Lozano N, Torrejano C, Trujillo J. Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con prevención y control del dengue en la zona urbana del municipio de Villavieja en el año 2008 – 2009. 2010.

[78] Castañeda O, Omar S, Ramírez A. "Conocimientos, actitudes y prácticas comunitarias en un brote de Dengue en un municipio de Colombia, 2010." Revista de salud pública. 2011; 13: 514-527.

[79] Criollo I, Bernal A, Castañeda O. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue, tras aplicación de estrategias de movilización social. Yopal-Casanare, Colombia, 2012. Investigaciones Andina. 2014; 16 (29): 1001-1015. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2390/239031678001.pdf>

[80] Hernández J, Consuegra C, Herazo Y. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue en un barrio de la ciudad de Cartagena de Indias. Rev. salud pública [Internet]. 2014 [consultado 2021 Mar 31]; 16(2):281-292. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642014000200011&lng=en.

[81] Maestre-Serrano Ronald, Pacheco-Lugo Lisandro, Salcedo-Mendoza Soraya. Índices de infestación aédica e identificación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en llanterías del Departamento del Atlántico, Colombia. Rev. salud pública [Internet]. 2015 [consultado 2021 Mar 31]; 17(5): 738-748. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642015000500008&lng=en.

[82] Valenzuela F, Romaní F, Monteza B, Fuentes D, Vilchez E, Salaverry O. Prácticas culturales vinculadas al cuidado de la salud y percepción sobre la atención en establecimientos de salud en residentes de centros poblados alto-andinos de Huancavelica, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2018; 35(1): 84-92. Disponible en: doi: 10.17843/rpmesp.2018.351.3603.

[83] Organización Mundial de la Salud. Dengue [internet]. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/topics/dengue/es/>

[84] Organización Panamericana de la Salud. Guía de Bolsillo Diagnóstico y manejo clínico en casos del dengue. [Internet]. 2013 [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/3467>

[85] Organización Panamericana de la Salud. Guía para la atención clínica integral del paciente con dengue. 2010. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en:

https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=1214-guia-para-la-atencion-clinica-integral-del-paciente-con-dengue&Itemid=688

[86] Organización Panamericana de la Salud. Todos a prevenir la transmisión del virus del dengue [internet]. 2019. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/topics/dengue/es/>

[87] Malhotra V, Kaur P. The Community knowledge, attitude and practices regarding Dengue fever infield practice area of urban training health centre of Patiala. 2014; 2: 19–26.

[88] Quintero E, De la Mella S, Gómez L. La promoción de la salud y su vínculo con la prevención primaria. *Medicentro Electrónica* [Internet]. 2017 [consultado 15 Mar 2021]; 21(2): 101-111. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432017000200003&lng=es

[89] Basso C, García da Rosa E, Romero S, González C, Lairihoy R, Roche I, et al. Improved dengue fever prevention through innovative intervention methods in the city of Salto, Uruguay. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 2015;109(2):134-42.

[90] Rojas-Ochoa F. El componente social de la salud pública en el siglo XXI. *Rev. Cubana Salud Pública* [Internet]. 2004 [consultado 15 mar 2021]; 30(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000300008&lng=es.

[91] Bang C. Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. *Psicoperspectivas*. 2014; 13(2): 109-120. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol13-Issue2-fulltext-399>

[92] Buong J, Gwoswar C, Kaseje D, Mumbo H, Odera O y Ayugi M. Uptake of community health strategy on service delivery and utilization in Kenya. 2013 [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/236412185.pdf>

[93] CHILDFUND. Propuesta de encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). Modelo me quiero, me cuido. [Consultado 15 mar 2021].

Disponible en:
http://regionalamericacf.org/3_MeQuiero/anexos/Anexo_9_Encuesta_CAP.pdf

[94] Holman A. Encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en el ámbito de la Protección de la Infancia. Save the Children. 2012. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en:
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7245/pdf/kap_report_sp_hires_0.pdf

[95] Organización de las Naciones Unidas. El concepto de Pueblos indígenas. Seminario sobre recopilación y desglose de datos relativos a los pueblos indígenas. 2004 [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en:
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_data_background_es.htm

[96] Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Perfil de Salud de la Población Indígena, y medición de desigualdades en salud. 2016 [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en:
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Perfil-salud-pueblos-indigenas-colombia-2016.pdf>

[97] Colombia. Ministerio de Salud y Protección. Pueblos indígenas. [Consultado 15 mar 2021]. Disponible en:
<https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx>

[98] Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 4288. Por la cual se define el Plan de atención Básica (PAB) del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y se dictan otras disposiciones. 1996. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%204288%20DE%201996.pdf

[99] Ministerio de Salud. Acuerdo 173 de 2000. Por el cual se destinan recursos de la Subcuenta de Promoción del Fosyga para garantizar por parte del Ministerio de Salud la ejecución del Plan Nacional de Control de Vectores de Interés en Salud Pública. Disponible en:
<http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/Acuer173.htm>

[100] Colombia. Ministerio de Salud. Decreto número 3039 de 2007. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 2007. Disponible en:
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Políticas_Nacionales_Salud-Colombia_2007-2010.pdf

[101] Colombia. Ministerio de Salud. ABC del Plan Decenal de Salud 2012-2021. 2012. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/IMP_4feb+ABCminsaud.pdf

[102] Colombia. Corte Constitucional. Auto 004. Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04. 2009. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>

[103] Congreso de Colombia. Ley 14 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 2011. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley1438de2011.pdf>

[104] Congreso de Colombia. Decreto 1973 de 2013. Por el cual se crea la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. 2013. Disponible en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1379474#:~:text=DECRETO%201973%20DE%202013&text=1973%20DE%202013-,por%20el%20cual%20se%20crea%20la%20Subcomisi%C3%B3n%20de%20Salud%20de,los%20Pueblos%20y%20Organizaciones%20Ind%C3%ADgenas>

[105] Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf>

[106] Colombia. Ministerio de Salud. Decreto número 1953 de 2014. Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. 2014. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636>

[107] Colombia. Ministerio de Salud. Circular 00000011 de 2018. Directrices para avanzar en la construcción e implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural- SISPI a nivel territorial, en diálogo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2018. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-11-de-2018.pdf>

[108] Colombia. Ministerio de Salud. Circular 00000050 de 2021. Por la cual se modifica la Resolución 1841 de 2013, en el sentido de adoptar el capítulo indígena para los pueblos y comunidades indígenas de Colombia como parte integral del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012-2021. 2021. Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-050-de-2021.pdf>

[109] Jian-Wei X, Liu H, Ai D, Yu Y, Yu B. The Shan people's health beliefs, knowledge and perceptions of dengue in Eastern Shan Special Region IV, Myanmar. *PLoS Negl Trop Dis*, 2019; 13(6): 74-98. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007498>

[110] Machado, R, Montenegro F, Malta D, Alencar, Pessoa V Martins, V, Araújo, L. V., ... & de Goes Cavalcanti, L. P. Dengue Fever and *Aedes aegypti* in indigenous Brazilians: seroprevalence, risk factors, knowledge and practices. *Tropical Medicine & International Health*. 2018; 23(6): 596-604.

[111] Mitchell K, Beltrán E, Breilh J, Spiegel J, Arichabala A, Ordoñez T, et al. Integrating participatory community mobilization processes to improve dengue prevention: an eco-bio-social scaling up of local success in Machala, Ecuador. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 2015; 109(2): 126-33. <https://doi.org/10.1093/trstmh/tru209>

[112] Castillo A. "Recorrido de participación social desde el enfoque de ecosalud para el control de *Aedes aegypti*. Municipio Mario Briceño Iragorry. Venezuela, 2017." *Comunidad y Salud*. 2017; 15(2): 93-101.

[113] Ganem A, Tuesca R. "Promoción de la salud y prevención del dengue: implementación de la metodología-combi-en tres barrios del distrito de Barranquilla, Colombia." *Salud Jalisco* 5. 2018: 82-92.

[114] Benítez L, Díaz F y Martínez R. Experiencia y percepción del riesgo asociados a conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en Riohacha, Colombia. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2020; 25: 1137

[115] Organización Mundial de la Salud (OMS). Respuesta mundial para el control de vectores 2017-2030. Documento de contexto para informar las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud en su 70a reunión. Ginebra: OMS; [Internet]. 2017. Versión 5.4. [Consultado 21 de marzo de 2019]. Disponible https://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030-esp.pdf

- [116] Paternina L. Prácticas de autocuidado de las familias frente al dengue y su relación con la implementación del protocolo, en un municipio de Colombia. Córdoba [tesis de maestría]. Montería: Universidad de Córdoba;2019
- [117] Tuirán K. Facilitadores y barreras en la adopción de prácticas preventivas del dengue en habitantes de Montería, Córdoba [tesis de maestría]. Montería: Universidad de Córdoba; 2020. Disponible en: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4352>
- [118] Benítez L, Romero I. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre manejo integrado de vectores. Córdoba. Colombia. Cult del Cuid Enf [internet]. 2019 [consultado 22 feb 2021]; 16(2): 7-18. Disponible en: <https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/1069/pdf>
- [119] Cotán A. El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga. 2020; 1 (1). 83-103. Disponible en: DOI: <http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7241>
- [120] Córdoba. Alcaldía de San Andrés de Sotavento. Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023: Trabajemos juntos [internet]. 2020. Disponible en: https://sanandresdesotaventocordoba.micolombiadigital.gov.co/sites/sanandresdesotaventocordoba/content/files/000122/6083_pdt-sas-v7-1.pdf
- [121] Guba EG, Lincoln YS. Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. *Educ Tech Res Dev*. 1982; 30(4): 233-52. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/30219846?seq=1>
- [122] Tuson A. El análisis de la conversación: entre la estructura y el sentido. cultat de Ciències de l'Educació, Edifici G-5 Universitat Autònoma de Barcelona 08193 - Bellaterra (Barcelona), Spain
- [123] World Health Organization. WHO specifications and evaluations for public health pesticides: d-Allethrin. Geneva; 2002.
- [124] Nitin J, Jioty J. Prolonged use of mosquito coil, mats, and liquidators: a review of its health implications. *Int J Clin Exp Physiol*. 2015;2(4):209-13.
- [125] Shu-Chen C, Ruey-Hong W, Li-Jie S, Ming-Chih C, Huei L. Exposure to mosquito coil smoke may be a risk factor for lung cancer in Taiwan. *J Epidemiol*. 2008;18(1):19-25.

[126] National Pesticide Information Center. ¿Puedo usar bolas contra polillas para repeler insectos o animales? [internet]. 2021 [consultado 10 feb 2021]. Disponible en: <http://npic.orst.edu/faq/mothball.es.html>

[127] Baldi G, Hernández S, Gómez R. Actualización de la fiebre del Dengue. Rev Méd Sin [internet]. 2020 [consultado 20 feb 2021]; 5(1). Disponible en: <file:///C:/Users/compaq/Downloads/341-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2058-2-10-20200104.pdf>

[128] Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. En esta nueva normalidad no hay que bajar la guardia frente al dengue. [Internet]. [Consultado 21 feb 2021]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-esta-nueva-normalidad-no-hay-que-bajar-la-guardia-frente-al-dengue.aspx>

[129] Alvis N, Rodríguez H, Mattar S. Dengue in an area of the Colombian Caribbean. Col Méd. 2015 [consultado 22 feb 2021]; 46(1): 3-7.

[130] Caraballo A, Chica I, Ocampo M. Comportamiento epidemiológico del Dengue, Chikungunya y Zika. Córdoba–Colombia 2014-2017. Rev Col Sal Lib [internet]. 2017 [consultado 22 feb 2021]; 12(2): 7-14. Disponible en: <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rcslibre/article/view/1725/1261>

[131] Colombia. DANE. Necesidades básicas insatisfechas (NBI). [Internet]. [Consultado 22 feb 2021]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

[132] Colombia. Alianza Social por la transformación de Córdoba. Córdoba transformada por una región sostenible. [Internet]. [Consultado 22 feb 2021]. Disponible en: https://www.unisimon.edu.co/showimagen/v/Comunicaciones/20181024113621_0.pdf

[133] Valencia N, Ortega J, Castro R. La Educación y Alfabetización de Jóvenes y Adultos en Regiones del Caribe Colombiano y su Impacto en el Trabajo y los Ingresos. Educação & Sociedade [internet]. 2017 [consultado 22 feb 2021]; 38(141): 935-950. Disponible en: <https://www.scielo.br/pdf/es/v38n141/1678-4626-es-es0101-73302017167856.pdf>

[134] Beltrán K, López M. Usos de la medicina herbaria en el manejo del dengue en indígenas de un Cabildo del departamento de Córdoba (Tesis de grado). 2020.

[135] Martínez M, Espino C, Moreno N, Rojas E, Mazzarri M, Mijares V, et al. Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre dengue y su relación con hábitats del vector en Aragua-Venezuela. Bol Mal Salud Amb [Internet]. 2015 [consultado 2021 Dic 05]; 55(1): 86-93. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-46482015000100006&lng=es.

[136] Chuc S, Hurtado-Díaz M, Schilman A, Riojas-Rodríguez H, Rangel H, González-Fernández M. Condiciones locales de vulnerabilidad asociadas con dengue en dos comunidades de Morelos. Salud Publica Mex. 2013; 54: 170-178. Disponible en: <https://www.scielosp.org/pdf/spm/2013.v55n2/170-178/es>

[137] Castañeda O, Zuleta L. Conocimientos, actitudes y prácticas para el control de enfermedades transmitidas por vectores en zona rural dispersa, San Luis de Palenque, Casanare-Colombia, 2017. Rev. Méd. Risaralda 2018; 24 (2) 108-114.

[138] Gaviria J, Humanez M. Conocimientos Y Prácticas Culturales Sobre Dengue En Las Familias De Un Cabildo Indígena Del Departamento De Córdoba [trabajo de grado de internet]. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Montería: 2020. [Consultado 2021 05 dic]. Disponible en: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/3425/GaviriaCarvajalJessicaPaola-HumanezPaterninaMaryElen.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[139] Niño E, Yong H, Díaz C. Conocimientos y prácticas en prevención de dengue en ciudad afectada por epidemia del dengue posfenómeno de El Niño Costero, Perú, 2018. Rev Cubana Med Trop [Internet]. 2019 [consultado 2021 Dic 05]; 71(2): 4-10. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037507602019000200008&lng=es

[140] Flores K, Guevara M, Mazzarri M, Rattia J, Marruffo M, Alcalá P, et al. El Control De Aedes Aegypti, Con Enfoque De Eco salud Mediante Una Estrategia De Intersectorialidad En Un Municipio De Venezuela. MedULA. 2019; 28(1): 2. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/45898/art_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[141] Soto V. Conocimientos y Prácticas Preventivas Sobre Dengue En Época De Epidemia En Sector 2 Distrito La Victoria Chiclayo 2017. Rev Exp Med 2018; 4(2): 73-75 disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6559214>

- [142] Benítez L, Díaz F, Martínez R. Experiencia y percepción del riesgo asociados a conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en Riohacha, Colombia. *Ciência & Saúde Coletiva* [Internet]. 2020; 25 (3): 1137-1146. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.08592018>
- [143] Souza K, Rangel M, Santos I, de Sousa G, Kalabric L. Saberes e práticas sobre controle do *Aedes aegypti* por diferentes sujeitos sociais na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. *Cad. Saúde Pública*. 2018; 34(5). Disponible en: <https://www.scielo.br/j/csp/a/nM73CV6s7LzRWLdSd5cknkt/?format=pdf&lang=pt>
- [144] Santos S, Parra G, Silva B, Silva L. Dengue in Brazil and Colombia: a study of knowledge, attitudes, and practices. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop* 2014; 47(6): 783-787.
- [145] Parks W, Lloyd L, UNDP/World Bank/World Health Organization (WHO) Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. Planificación de la movilización y comunicación social para la prevención y el control del dengue Guía paso a paso. Ginebra: WHO; 2004
- [146] Barruz I. Plantas medicinales frente al dengue [trabajo de grado de internet]. Universidad Complutense. 2018 [consultado 2021 05 dic]. Disponible en: <http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/ITZIAR%20BARRUZ%20JIMENEZ.pdf>
- [147] Morales M, Betancourt J, Acao L, León C. Actitudes, conocimientos y prácticas sobre el dengue y su vector en el municipio Camagüey. *AMC* [Internet]. 2016 [consultado 2021 Dic 05]; 20(3): 253-261. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552016000300005&lng=es.
- [148] Criollo I, Bernal A, Castañeda O. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue, tras aplicación de estrategias de movilización social. Yopal-Casanare, Colombia, 2012. *Investigaciones Andina*. 2014; 16(29): 10-15.